RESUMEN EPICRISIS

PACIENTE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO	**IDENTIFICACION:** PT 7527774	**HC:** 7527774 - PT
FECHA DE NACIMIENTO: 23/4/2015 **EDAD:** 10 Años **SEXO:** F		**TIPO AFILIADO:** Beneficiario
RESIDENCIA:	VALLE DEL CAUCA-CALI	**TELEFONO:** 0000
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A)	**OCUPACIÓN:** ESTUDIANTE	
NOMBRE ACOMPAï¿½ANTE:	**PARENTESCO:**	**TELEFONO:**
FECHA INGRESO: 04/03/2026 08:55 PM	**FECHA EGRESO:**	**CAMA:** UPI305
DEPARTAMENTO: UCIPED - UCI PEDIATRICA	**SERVICIO:** U.C.I.	
CLIENTE: SAVIA SALUD EPS	**PLAN:** SAVIA SALUD EPS SUBSIDIADO 2026	

FECHA	MOTIVOS DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL
2026-03-04	**22:50 obegetsa - OBEIMAR EFREN GETIAL SALAZAR** **CAUSA QUE MOTIVA LA ATENCIÓN:** Accidente de transito de origen comun **MOTIVO DE CONSULTA :** ACCIDENTE DE TRANSITO " EMERGENCIA VITAL **ENFERMEDAD ACTUAL :** EN COMPAÑIA DE FAMILIAR Y PERSONAL DE ATENCION PREHOSPITALARIA LLEGAN EN HORAS DE 20:00 CON ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE PASAJERO DE MOTO DE LAS 18 HORAS APROIXIMADAMENTE, ARROYADO POR BUS, POSTERIOR SANGRADO Y ABULSION DE PIERNA IZQUIERDA CON SOMNOLENCIA, MAS ESTUPOR, POR LO QUE DECIDEN EN PRIMER NIVEL TONIQUETE, CEFAZOLINA, TRANEXAMICO 500 MG Y SACAR COMO VITAL, AL INGRESO PACIENTE A EMERGENCIA PARA REANIMACION.

DIAGNOSTICOS DE INGRESO ASIGNADOS

CODIGO	DIAGNOSTICO DE INGRESO	ESTADO	OBSERVACION	USUARIO	FECHA
S789	AMPUTACION TRAUMATICA DE CADERA Y MUSLO NIVEL NO ESPECIFICADO			OBEIMAR EFREN GETIAL SALAZAR	2026-03-04
R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO			SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	2026-03-06
S223	FRACTURA DE COSTILLA			SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	2026-03-06
S320	FRACTURA DE VERTEBRA LUMBAR			SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	2026-03-06
S328	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS			SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	2026-03-06
T212	QUEMADURA DEL TRONCO DE SEGUNDO GRADO			SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	2026-03-06
T134	TRAUMATISMO DE VASOS SANGUINEOS NO ESPECIFICADOS DE MIEMBRO INFERIOR NIVEL NO ESPECIFICADO			ANNI KARINA QUIÑONES RINCON	2026-03-10

MOTIVO DE SALIDA Y RECOMENDACIONES

2026-03-04 22:44	**PROFESIONAL:** obegetsa - OBEIMAR EFREN GETIAL SALAZAR	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

****INGRESO A URGENCIAS******
NOTA RETROSPECTIVA POR CONGESTION DEL SERVICIO

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD:10 AÑOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:7527774
ENTIDAD: SOAT
ACUDIENTE PADRE
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS:04/03/2026

MC: "ACCIDENTE DE TRANSITO " EMERGENCIA VITAL

ENFERMEDAD ACTUAL:

EN COMPAÑIA DE FAMILIAR Y PERSONAL DE ATENCION PREHOSPITALARIA LLEGAN EN HORAS DE 20:00 CON ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALIDAD DE PASAJERO DE MOTO DE LAS 18 HORAS APROIXIMADAMENTE, ARROYADO POR BUS, POSTERIOR SANGRADO Y ABULSION DE PIERNA IZQUIERDA CON SOMNOLENCIA, MAS ESTUPOR, POR LO QUE DECIDEN EN PRIMER NIVEL TONIQUETE, CEFAZOLINA, TRANEXAMICO 500 MG Y SACAR COMO VITAL, AL INGRESO PACIENTE A EMERGENCIA PARA REANIMACION.

REVISIÓN POR SISTEMAS: NIEGA

ANTECEDENTES:
*PATOLÓGICOS NIEGA
*FARMACOLÓGICOS NIEGA
*QUIRÚRGICOS: NIEGA
*HOSPITALIZACIONES: NIEGA
*ALERGIAS NIEGA
*VACUNAS: REFIERE COMPLETAS NO APORTA CARNET

CONCILIACIÓN MEDICAMENTOSA: NIEGA

EXAMEN FÍSICO:

BUEN ESTADO GENERAL
TA: 120/50 MMHG FC: 130 XMINUTOS, FR:30 XMINUTOS, T:35,8 C SOP2: 80 % FIO2 21%
PESO:40 KG APROXIMADAMENTE

CABEZA Y CUELLO: SE OBSERVA HERIDA FRONTAL, PUPILAS ISOCORICAS NORMOREATIVAS, MUCOSAS SECAS, CON CIANOSIS PERIBUCAL. CUELLO MOVIL SIN DOLOR, CON COLLARIN

TORAX: SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN BASES, SIN SOBREAGREGADOS A LA AUSCULTACION RUIDOS CARDIACOS RITMICOS NO SE AUSCULTAN SOPLOS
HERIDAS POR ESCORACION A NIVEL POSTERIOR DE TORAX

ABDOMEN:DOLOROSO A LA PALPACION, CON INDURACION, SIN SIGNOS CLAROS DE IRRITACION PERITONEAL

EXTREMIDADES: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CON ABULSION DE PIEL CON SANGRADO ABUNDANTE EN MUSLO Y PIERNA PARTE LATERAL, A NIVEL DISTAL CON PULSOS DISMINUIDOS LLENADO VASCULAR MAYOR A 3 SEGUNDOS DEMAS EXTREMIDADES SIN LESIONES

PIEL LO COMENTADO

NEUROLOGICO: CON ESTUPOR SUPERFICIAL, PUPILAS NORMOREACTIVAS, SIN FOCALIZACION.

IMPRESION DIAGNOSTICA
- ACCIDENTE DE TRANSITO
- TRAUMA CRANEO ENCEFALICO SEVERO RIESGO ALTO
- TRAUMA TORAX CERRADO
- TRAUMA ABDOMINAL CERRADO
- SANGRADO CON AMPUTACION PARCIAL DE MUSLO Y PIERNA

ANÁLISIS/PLAN:
PACIENTE TRAIDO POR ACCIDENTE DE TRANSITO REMISION DE NIVEL I, LLEGA APROXIAMDAMENTE A LAS 20:00 HORAS NOTA RETROSPECTIVA POR CONGESTION DEL SERVICIO, COMENTAN PRIMER NIVEL ACCIDENTE DE ALTA CINEMATICA POR BUS VS PASAJERO DE MOTO, AL INGRESO ALGICA SIN PERDIDA DE LA CONCIENCIA PERO CON SANGRADO ABUDNANTE Y ABULSION PARCIAL DE PIERNA Y MUSLO IZQUIERDOS A NIVEL LATERAL, POR LO QUE INICIAN CEFAZOLINA, TRANEXAMICO, LIQUIDOS Y SE INGRESA COMO VITAL, A SU INGRESO PACIENTE SE LLEVA A REANIMACION, A NIVEL NEUROLOGICO CON ESTUPOR SUPERFICIAL, PUPILAS NORMOREACTIVAS, A NIVEL RESPIRATORIO CON DESATURACION MURMULLO DISMINUIDO EN BASES, SE INICIA MANEJO DE MASCARA DE NO REHINALACION, A NIVEL GASTRICO CON DOLOR A LA PALPACION, SIN SIGNOS CLAROS DE IRRITACION PERITONEAL, SE DAJA SIN VIA ORAL Y LIQUIDOS INICIALES DE BOLO Y POSTERIOR MANTENIMEINTO, HEMODINAMICO CON TAQUICARDIA SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE Y CON PRESIONES ELEVADOS. SE INICIA REANIMACION CON LIQUIDOS,SE PASA DOSIS DE 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS, SE DEJA TRANEXAMICO 500 MG, CON MANEJO ANTIBIOTICO DE AMPICILINA SULBACTAM, ANALGESICOS Y SE PONE DOSIS UNICA DE KETAMINA PARA SEDOANALGESICA, POR AHORA SE OBSERVA TAC DE CRANEO SIN ALTERACIONES, PERO SE CONSIDERA VALORACION DE CIRUGIA VASCULAR PARA CONTROL DE DAÑOS, SE PASA A UCI ANTE RIESGO ALTO DE SANGRADO CON CHOQUE HIPOVOLEMICO Y HASTA MUERTE.EN EL MOMENTO PACIENTE SIN FAMILIAR.-

ORDENES MÉDICAS**
-INGRESO UCI
-NADA VIA ORAL
-CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-CONTROL DE SIGNOS VITALES
-MONITORIA NO INVASIVA

MEDICAMENTOS:
PESO 40 KG APROXIMADOS
-DIPIRONA 1 GR CADA 8 HORAS EV
-OMEPRAZOL 40 MG CADA 24 HORAS EV
-LEV HARTMAN DE 500 CC BOLO INICIAL, DEJAR A 70 CC HORA
- AMPICILINA SULBACTAM 1 GR CADA 8 HORAS E
-ACIDO TRANEXAMICO 500 MG AHORA
-KETAMINA 40 MG DOSIS UNICA EV

SE SOLICITA:

- TAC DE CRANEO SIMPLE
-TAC DE COLUMNA CERVICL
- TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO
-TAC DE ABDOMEN Y PELVIS
-RX DE TORAX PORTATIL
-SANGRAR PARA: HEMOGRAMA PCR, PERFIL HEPATICO, RENAL, ELECTROLITOS, TIEMPOS.
-GASES VENOSOS
-GLUCOMETRIA
-SE SOLICITA VALORACION POR VASCULAR.

SEGUIMIENTO:
-PEDIATRÍA/MEDICINA GENERAL

2026-03-04 23:01	**PROFESIONAL:** evidurqu - EVIS ZIOMARA DURANGO QUINTERO	**ESPECIALIDAD:** CIRUGIA VASCULAR

CX VASCULAR - DRA. DURANGO

PACIENTE CON +/- 5 HORAS DE EVOLUCION DE TRAUMA SEVERO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CON GRAN AVULSION DE TEJIDOS BLANDOS MUSCULOTENDINOSO Y SANGRADO ACTIVA A NIVEL DE MUSLO TERCIO SUPERIOR, MEDIO E INFERIOR. AL EXAMEN FISICO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES CON SIGNOS DE HIPOPERFUSION DE LA EXTREMIDAD Y SANGRADO DE TEJIDOS BLANDOS, MUSCULAR Y POSIBLEMENTE COMPROMISO ARTERIAL DE GRANDES VASOS POR LO CUAL REQUIERE SER LLEVADA A CIRUGIA COMO URGENCIA VITAL PARA CONTROL DE SANGRADO Y POSIBLIDAD DE REVASCULARIZACION SEGUN HALLAZGOS.

SE REALIZA INDICE DE MESS: 9 LO CUAL INDICA PERDIDA DE LA EXTREMIDAD MAYOR AL 90 %. SE EVALUARA DE MANERA INTRAOPERATORIA POSTERIOR AL CONTROL DEL SANGRADO LA VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD PARA DEFINIR UNA POSIBLE AMPUTACION MAYOR. NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE DISPONIBLIDAD DE QUIROFANO PARA INICIAR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO.

2026-03-04 23:32	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

** REPORTE DE PARACLINICOS **

N° Orden: 202603040206 - FECHA 04/03/2026

.- HEMOGRAMA (SIN ANEMIA, CON LEUCOCITOSIS,SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00
MCV 80.4
MCH 27.3
MCHC 33.8
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1
RDW SD 42.5
RDW CV 14.2
MPV 9.2
NEUTROFILOS Abs 16.95
LINFOCITOS Abs 6.17
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.25
BASOFILOS Abs 0.02
NEUTROFILOS % 68.7
LINFOCITOS % 25.0
MONOCITOS % 3.6
EOSINOFILOS % 1.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 40.2
HEMOGLOBINA 13.6
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383

.- TIEMPOS DE COAGULACION (TP - INR - PROLONGADOS)

INR 1.35
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4

.- GLICEMIA 195.0 (AUMENTADO)

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0 (AUMENTADO)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADA)

CREATININA SERICA 0.50
NITROGENO UREICO 11.0

2026-03-04 23:46	**PROFESIONAL:** lausolla - LAURA CRISTINA SOLANO LATORRE	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

NOTA ACLARATORIA
PACIENTE INGRESO SE HACE CON USUARIO DEL DOCTOR OBEIMAR Y LA NOTA FUE HECHA POR LA DR. LAURA SOLANO

2026-03-04 23:58	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

INGRESO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - PEDIATRIA -
DR. JOSE GERMAN NARVAEZ (MD ESPECIALISTA) - FRANCISCO QUINTERO P (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774

ENTIDAD: SIN INFORMACION
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UCIP: 04/03/2026

MOTIVO DE CONSULTA: POLITRAUMA POR ACCIDENTE DE TRANSITO

ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE DE 10 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DESCONOCIDOS INGRESA SIN FAMILIARES EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE APH QUIEN REFIERE QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRANSITO. CURSANDO CON POLITRAUMA Y TRAUMA COMPLEJO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, DONDE PRESENTA HERIDA ABULSIVA Y CON EXPOSICIÓN DE MUSCULO Y SANGRADO ARTERIAL PROFUSO, SE PASA A SALA DE IMAGENES SE REALIZA SERIE DE TRAUMA.
.- TAC DE CRANEO: SIN LESIONES EXPANSIVAS NI HEMORRAGICAS, NO SIGNOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA (PENDIENTE REPORTE OFICIAL DE RADIOLOGÍA)
.- TAC DE COLUMNA CERVICAL: SIN LESIONES APARENTES (PENDIENTE REPORTE OFICIAL DE RADIOLOGÍA)
.- TAC DE TÓRAX: SIN LESIONES APARENTES (PENDIENTE REPORTE OFICIAL DE RADIOLOGÍA)
.- TAC DE ABDOMEN: SIN LESIONES APARENTES (PENDIENTE REPORTE OFICIAL DE RADIOLOGÍA)
.- ANGIOTAC DE MIEMBROS INFERIORES: EN ESPERA DE REPORTE OFICIAL.
PACIENTE CON SANGRADO ARTERIAL ACTIVO MASIVO, SE COMENTA CASO A CIRUJANA VASCULAR (DRA DURANGO) QUIEN CONSIDERA PASAR CIRUGIA COMO URGENCIA VITAL PARA EXPLORACION VASCULAR, PREVIO A PROCEDIMIENTO SE REALIZO REANIMACIÓN GUIDA POR METAS CON PROTOCOLO DE TRASFUSION MASIVA (2 UNIDADES DE GLÓBULOS ROJOS, 1 UD DE PLASMA 1 UD DE PLAQUETAS) Y 1.000 CC DE CRISTALOIDE BALANCEADO.

ANTECEDENTES:
PATOLÓGICOS: DESCONOCIDOS
FARMACOLÓGICOS: DESCONOCIDOS
QUIRÚRGICOS: DESCONOCIDOS
ALÉRGICOS: DESCONOCIDOS
HOSPITALIZACIONES: DESCONOCIDOS
TRANSFUSIONES: DESCONOCIDOS
VACUNACIÓN: SIN INFORMACION
PROTOCOLO COVID:
1. ¿HA TENIDO SÍNTOMAS RESPIRATORIOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
2. ¿HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
3. ¿HA TENIDO CONTACTO CON ALGÚN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO PARA COVID? NIEGA.

PROTOCOLO ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS:
HA PRESENTADO DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:
-FIEBRE O MÁS? NIEGA.
-TOS POR MÁS DE 15 DÍAS? NIEGA.
-CEFALEA? NIEGA.
-PÉRDIDA DEL GUSTO Y EL OLFATO? NIEGA.
-CONJUNTIVITIS? NIEGA.
-CRECIMIENTO DE GANGLIOS LINFÁTICOS? NIEGA.
-LESIONES EN PIEL: MÁCULAS, PÁPULAS, VESÍCULAS, PÚSTULAS O ÚLCERAS GENITALES? NIEGA.

1. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 21 DÍAS HA TENIDO CONTACTO ESTRECHO CON UNA PERSONA PROBABLE O CONFIRMADA PARA VIRUELA DEL MONO? NIEGA.
2. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS SE HA DESPLAZADO A ZONAS ENDÉMICAS PARA VIRUELA DEL MONO? NIEGA.
3. ¿VIVE USTED O SE HA ENCONTRADO EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO? NIEGA.
4. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS HA TENIDO CONTACTO ESTRECHO (< A 1 METRO DE DISTANCIA) CON UNA PERSONA PROBABLE O CONFIRMADA PARA COVID 19? NIEGA.
5. ¿ES TRABAJADOR DE LA SALUD? NIEGA
6.¿ES TRABAJADOR DEL SECTOR AVÍCOLA O PORCINO ? ¿ O HA ESTADO EN CONTACTO CON AVES O CERDOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA
7.¿ HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS A ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE VIRUS DE INFLUENZA AVIAR O AGENTES RESPIRATORIOS NUEVOS CON POTENCIAL PANDÉMICO? NIEGA
8. ¿ HA ESTADO EN CONTACTO CON PERSONAS O GRUPOS SOCIALES(ENTORNOS FAMILIARES,LUGAR DE TRABAJO, COLEGIOS,UNIVERSIDADES, CÁRCEL, BATALLÓN) CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS? NIEGA

EXAMEN FÍSICO:
PACIENTE INGRESA EN CONDICIONES CRITICAS EN ESTADO DE CHOQUE, CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 104/69/78 MMHG
FRECUENCIA CARDIACA: 127 /MIN.
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 33/MIN.
SO2: 92- 93 % CON FIO2 DEL 21%
TEMPERATURA: 35 °C
GLUCOMETRIA: 173 MG/DL.
.- CABEZA Y CUELLO: PRESENTA HERIDA DE APROXIMADAMENTE 3 CM QUE COMPROMETE PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO, SIN SANGRADO ACTIVO, CON QUEMADURA POR FRICCIÓN, EN REGION FRONTAL IZQUIERDA.
.- NEUROLÓGICO: SOMNOLIENTA, GLASGOW 13/15. PUPILAS A 3 MM REACTIVAS, SIN FOCALIZACIÓN.
-OTORRINOLARINGOLÓGICO: SIN ALETEO NASAL, QUEJIDO NI ESTRIDOR. BOCA SECA. LABIOS PALIDOS.
.- TÓRAX : TAQUIPNEICA. NORMOEXPANSIBLE, PRESENTA MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN LESION N°1 TORAX POSTERIOR EN REGION MEDIA DE APROXIMADAMENTE 10 CM, LESION N° 2 QUEMADURA POR FRICCIÓN EN HEMITÓRAX POSTERIOR IZQUIERDO DE APROXIMADAMENTE 15 CM BORDES IRREGULARES, LESIÓN N° 3 QUEMADURA POR FRICCIÓN EXTENSA QUE COMPROMETE REGION LUMBAR, SACRA Y DORSAL IZQUIERDA
PULMONES: MURMULLO VESICULAR NORMAL, SIN RUIDOS AGREGADOS.
.- CARDIOVASCULAR: TAQUICARDIA SINUSAL, RUIDOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS, PULSOS DEBILES, LLENADO CAPILAR >5S, CON GRADIENTE TERMICO. ACROCIANOCIS.
.- ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO, SIN DISTENSION, ASCITIS, MASAS NI MEGALIAS.
-RENAL: HIPOVOLEMICA, DESHIDRATADA. GASTO URINARIO NO CUANTIFICADO.

-HEMATOLOGICO: SANGRADO RUTILANTE MASIVO EN MUSLO IZQUIERDO. PALIDEZ GENERALIZADA.
-OSTEOMUSCULAR: MUSLO IZQUIERDO CON GRAN ABULSION DE PIEL Y ESTALLIDO DE TEJIDOS BLANDOS (MUSCULOTENDINOSO), CON GRAN SANGRADO ACTIVO. LLENADO CAPILAR >10 S Y AUSENCIA DE PULSOS PERIFERICOS DE LA EXTREMIDAD AFECTADA, CON FRIALDAD, PALIDEZ Y ACROCIANOCIS.

-ANALISIS: YESHIA ESTA EN CONDICION CLINICA CRITICA, CON PRONOSTICO RESERVADO. CURSANDO CON POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGIA CINETICA. CON CHOQUE HIPOVOLEMICO HEMORRAGICO SECUNDARIO A SANGRADO MASIVO POR LESION VASCULAR DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. CON ALTERACION DEL ESTADO DE CONSCIENCIA, HIPOTERMICA, TAQUIPNEICA, HIPERGLUCEMICA. SIN SIGNOS DE ABDOMEN AGUDO. EN ALTO RIESGO DE COAGULOPATIA POSTRAUMA, DILUCIONAL Y POR CONSUMO. FUNCION RENAL EN RIESGO. RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA DESREGULADA. SE DEJA MONITORIZADA EN UCIP, CON ANALGESIA MULTIMODAL, ANTIBIOITCOTERAPIA EMPIRICA, PROFILAXIS ANTITETANICA Y TRASFUSIONES DE ELEMENTOS SANGUINEOS. ACTUAMENTE ESTA SIN FAMILIARES.

DIAGNOSTICOS:
ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGIA CINETICA (04/03/2026).
1.- CHOQUE HIPOVOLÉMICO GRADO IV
2.- TRAUMA COMPLEJO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
2.1. LESION ABULSIVA
2.2. TRAUMA VASCULAR
3. TRAUMA CRANEO ENCEFALICO LEVE.
4. TRAUMA CERRADO DE TORAX.
5. TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN.
6. QUEMADURAS POR FRICCION EN ESPALDA Y REGION LUMBAR.
7. TRAUMA FACIAL.

CRITERIOS UCI
.- ESTADO DE CHOQUE
.- REQUERIMIENTO DE TRANSFUSIÓN MASIVA DE HEMODERIVADOS
.- TRAUMA VASCULAR

PLAN TERAPEUTICO UCIP.
PESO APROX: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
NADA POR VIA ORAL.
HARTMAN 1000 CC EN BOLO IV (YA SE PASO). CONTINUAR A 100 CC/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV.
TOXOIDE TETANICO 40 UI, IM. DU.
CEFAZOLINA 1 G, IV. PREQUIRURGICO.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA).
TRASFUNDIR 2 UD DE GLOBULOS ROJOS COMPATIBLES (YA SE TRASFUNDIERON).
TRASFUNDIR 1 UD DE PLASMA.
TRASFUNDIR 1 UD DE PLAQUETAS.
OXIGENO A 2 L/MIN POR CANULA NASAL.
CUIDADOS DE ENFERMERIA.
CUIDADOS DE LA PIEL.
PREVENCION DE ZONAS DE PRESION Y DE CAIDAS.
PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD.
GLUCOMETRIA CADA 6 HORAS.
MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES.
CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS.

2026-03-04 23:59	**PROFESIONAL:** yurherri - YURY NATHALYA HERNANDEZ RINCON	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

NOTA FISIOTERAPIA TURNO NOCHE
NOTA DE INGRESO A UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

SE INGRESA AL CUBÍCULO SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y EL PREVIO LAVADO DE MANOS SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL. SE RECIBE PACIENTE DE SEXO FEMENINO DE 10 AÑOS DE EDAD, EN CONTEXTO DE POLITRAUMA POR ACCIDENTE DE TRANSITO CON TRAUMA COMPLEJO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, DONDE PRESENTA HERIDA AVULSIVA Y CON EXPOSICIÓN DE MUSCULO Y SANGRADO ARTERIAL ACTIVO.

ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE QUIEN INGRESA CON ANTECEDENTES DESCONOCIDOS INGRESA SIN FAMILIARES EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE APH QUIEN REFIERE QUE PRESENTA ACCIDENTE DE TRANSITO. AL INGRESO A UNIDAD CURSANDO CON CHOQUE HIPOVOLEMICO, YA COMENTADA A CIRUGIA PARA PASO COMO URGENCIA VITAL.

CON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DE:
1.- CHOQUE HIPOVOLÉMICO GRADO IV
2.- TRAUMA COMPLEJO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
2.1. LESION ABULSIVA
2.2. TRAUMA VASCULAR
3. TRAUMA CRANEO ENCEFALICO LEVE.
4. TRAUMA CERRADO DE TORAX.
5. TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN.
6. QUEMADURAS POR FRICCION EN ESPALDA Y REGION LUMBAR.
7. TRAUMA FACIAL.

A LA REVISIÓN POR SISTEMAS

*SISTEMA NEUROLÓGICO: PACIENTE ALERTABLE, CON DOLOR INTENSO, SIN SEDOANALGESIA, DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO NO EVALUABLES, SIN SIGNOS DE FOCALIZACION NEUROLOGICA, GLASGOW 14/15

*SISTEMA CARDIOVASCULAR PULMONAR: SE ENCUENTRA HEMODINÁMICAMENTE SIN SOPORTE VASOACTIVO NI INOTROPICO, CON SIGNOS VITALES FRECUENCIA CARDIACA 127 LATIDOS POR MINUTO, TENSIÓN ARTERIAL 104/69MMHG, SATURACIÓN DE OXÍGENO 97%, FRECUENCIA RESPIRATORIA 33 RESPIRACIONES POR MINUTO, PACIENTE CON TORAX SIMETRICO, PATRÓN VENTILATORIO COSTODIAFRAGMÁTICO A LA AUSCULTACIÓN SE ENCUENTRA MURMULLO VESICULAR ATENUADO EN BASES, SIN SOBREAGREGADOS PULMONARES. NO SE OBSERVAN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA CON SOPORTE DE OXÍGENO SUPLEMENTARIO CON MASCARA DE NO REINHALACION, FIO2 DE 50%
*SISTEMA OSTEOMUSCULAR: ARCOS DE MOVILIDAD ARTICULAR PASIVA Y ACTIVA CONSERVADA, NO EVALUABLES EN MII, FUERZA NO EVALUABLE POR ESTADO DE CONCIENCIA, SE DEJA REGISTRADO EN ESCALA OSTEOMUSCULAR D INGRESO.

.- TAC DE CRANEO: SIN LESIONES EXPANSIVAS NI HEMORRAGICAS, NO SIGNOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA (PENDIENTE REPORTE OFICIAL DE RADIOLOGÍA)
.- TAC DE COLUMNA CERVICAL: SIN LESIONES APARENTES (PENDIENTE REPORTE OFICIAL DE RADIOLOGÍA)
.- TAC DE TÓRAX: SIN LESIONES APARENTES (PENDIENTE REPORTE OFICIAL DE RADIOLOGÍA)
.- ANGIOTAC DE MIEMBROS INFERIORES: EN ESPERA DE REPORTE OFICIAL.

OBJETIVOS
- MANTENER OXÍMETRÍA >92%
- PREVENIR COMPLICACIONES RESPIRATORIA

INTERVENCION
- MONITORÍA RESPIRARTORIA
- POSICIONAMIENTO EN CAMA CON CABECERA DE CAMA A 15°
- SE PASA SOPORTE DE OXIGENO POR CANULA NASAL A 2 LTS
- SE HACE ACOMPAÑAMIENTO EN TRASLADO DE PACINETE A SALA DE CIRUGIA.

SE DEJA PACIENTE SIN COMPLICACIONES POR INTERVENCION, DENTRO DE SU CONDICIÓN CLÍNICA.

2026-03-05 00:07	**PROFESIONAL:** evidurqu - EVIS ZIOMARA DURANGO QUINTERO	**ESPECIALIDAD:** CIRUGIA VASCULAR

CX VASCULAR - DRA. DURANGO - NOTA QUIRURGICA Y POSTQUIRURGICA

PROCEDIMIENTO : PAQUETE DE REVASCULARIZACION Y RECONSTRUCCION ARTERIAL DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

ASEPSIA Y ANTISEPSIA
COLOCACION DE CAMPOS ESTERILES
RETIRO DE TORNIQUETE Y VENDAJE COMPRESIVO.
SE REALIZA LAVADO DE LA EXTREMIDAD
SE REALIZA LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.
SE REALIZA EXPLORACION Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FERMORAL SUPERIFICIAL, POPLITEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCION.
SE REALIZA TROMBECTOMIA Y RECONSTRUCCION VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO
SE VERIFICA DE MANERA ECOGRAFICA PERMEABILIDAD VASCULAR Y FLUJO TRIFASICO A NIVEL DE ARTERIA POPLITEA TERCERA PORCION
SE REALIZA EXPLORACION VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFASICO DISTAL.
SE REALIZA HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACION DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACION DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLITEA.
SE CONTINUA PROCEDIMIENTO CON EL SERVICIO DE ORTOPEDIA INFANTIL PARA DEBRIDAMIENTO DE TEJIDOS Y COLOCACION DE SISTEMA VAC.

CONDUCTA: TRASLADAR A UCI, VIGILAR SIGNOS DE HIPOPERFUSION DISTAL, SANGRADO, SE REALIZARA ARTERIOGRAFIA MII EN 48 HORAS PARA DEFINIR VIABILIDAD DE LA EXTERMIDAD Y FLUJO DE VASOS MUSCULARES PARA COBERTURA DEL DEFECTO A NIVEL DE MUSLO.

2026-03-05 00:53	**PROFESIONAL:** anggomga - ANGELA MARIA GOMEZ GARCIA	**ESPECIALIDAD:** ORTOPEDIA PEDIATRICA

ORTOPEDIA INFANTIL

PACIENTE CON EXTREMIDAD MACERADA, MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CON MESS INICAL DE 9, CON COMPROMISO EXTENSO DE TEJIDOS BLANDOS, AVULSION DE CONDILO FMEORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGEMATO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA, SE REALIZO LAVADO Y DESBRIDAMIENTO EN CONJUNTO CON CIRUGIA VASCULAR, SE RETIRO MATERIAL CONTAMIENATE Y SE DEJO SISTEMA VAC. PACIENTE CON ALTO RIESGO DE INFECCION Y DESENLACE DE MAL PRONOSTICO PARA LA EXTREMIDAD, CON DEFECTO DE COBERTOURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL.
REQUIERE VIGILANCIA CLINICA ESTRICTA EN UCI
CEFAZOLINA 1 GR IV CADA 8 HORAS
GENTAMICINA 160mg IV DIA
PENICILINA BENZATINICA 4.000.000 u DIA
NUEVO LAVADO EN 48 A 72 HORAS SEGUN EVOLUCION CLINICA
SE DEJA CARGADA RADIOGRAFIA RODILLA IZQUIERDA Y TAC DE RODILLA IZQUIERDA

2026-03-05 00:57	**PROFESIONAL:** darvelpi - DARY PATRICIA VELASCO PIAMBA	**ESPECIALIDAD:** ANESTESIOLOGIA

VALORACION PREANESTESTESICA

CON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DE:
1.- CHOQUE HIPOVOLÉMICO GRADO IV
2.- TRAUMA COMPLEJO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
2.1. LESION ABULSIVA
2.2. TRAUMA VASCULAR
3. TRAUMA CRANEO ENCEFALICO LEVE.
4. TRAUMA CERRADO DE TORAX.
5. TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN.
6. QUEMADURAS POR FRICCION EN ESPALDA Y REGION LUMBAR.
7. TRAUMA FACIAL.

SE PROGRAMA A CONTROL DE SANGRADO Y LIGADURA DE SAFENA MAS LAVADO QUIRUJICO COLOCACION VAC MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

PROFILASIX CEFAZOLINA 2GRE V

ANTECEDENTES:
PATOLÓGICOS: DESCONOCIDOS
FARMACOLÓGICOS: DESCONOCIDOS
QUIRÚRGICOS: DESCONOCIDOS
ALÉRGICOS: DESCONOCIDOS
HOSPITALIZACIONES: DESCONOCIDOS
TRANSFUSIONES: DESCONOCIDOS
VACUNACIÓN: SIN INFORMACION
04/03/2026

.- HEMOGRAMA (SIN ANEMIA, CON LEUCOCITOSIS,SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00
MCV 80.4
MCH 27.3
MCHC 33.8
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1
RDW SD 42.5
RDW CV 14.2
MPV 9.2
NEUTROFILOS Abs 16.95
LINFOCITOS Abs 6.17
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.25
BASOFILOS Abs 0.02
NEUTROFILOS % 68.7
LINFOCITOS % 25.0
MONOCITOS % 3.6
EOSINOFILOS % 1.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 40.2
HEMOGLOBINA 13.6
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383

.- TIEMPOS DE COAGULACION (TP - INR - PROLONGADOS)

INR 1.35
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4

.- GLICEMIA 195.0 (AUMENTADO)

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0 (AUMENTADO)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 (AUMENTADO)

CHEQUEO MAQUINA ANESTESIA
CHEQUEO MEDICAMNETOS ANESTESIA

ANESTESIA GENERAL BALANCEADA
SE TRASLADA PACIENTE A SALA DE CIRUGIA # 3 SE INICIA INDUCCION ANESTESICA , CON PREVIA PREOXIGENACION 5 MINUTOS Y SE ADMNISTRA LIDOCAINA 20 MG EV , PROPOFOL 70 MGEV , REMIFENTANILO 30 ML/HR EV , FENTANILO 10MCGEV, MIDAZOLAM 1 MGEVE , SE REALIZA LARINGOSCOPIA DIRECTA CLOMARK Y LEHANE # 6.5CM SE FIJA 18 CM NEUMOTAPONADOR 5 MIL AIRE Y SE ACOPLA A MAQUINA ANESTESIA VOT 350 ML FR 12 RPM I:1 1:2 PEEP 6 SIN COMPLICACIONES-

PACIENTE QUE INGRESO CON TRASFUSION DE GR 500ML Y SE INICIA PLASMA ,POSTERIORMENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRUJICO PRESENTA HIPOTENSION ARTERIAL SE DECIDE INICIAR GOTEO NOREPINEFRINA 3ML/HR A 1 MCG /HG /MIN .
PASO CATETER VENOSO CENTRAL SUBCLAVIO DERECHO POR METOSDO SELDINGER PREVAI ASEPSIA Y ANTISEPSIA SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO SIN CAOMPLICACIONES
PACIENTE POR SU HIPOTENSION Y COMPLEJIDAD DE HERIDA SE DECIDE TRASLADO A UCI PEDIATRICA INTUBADA TOT 6,5 CM CON VENTILACION ASISTIDA AMBU SV TA 100 /50 MMHG FC 100 LPM FR 1|2 RPM SA02 100% .

2026-03-05 02:38	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

NOTA DE REINGRESO A UCIP.
YESHIA REINGRESA A UCIP PROVENINETE DE QUIROFANO.
ACOMPAÑADA POR ANESTESIOLOGA. INGRESA INTUBADA Y BAJO EFECTOS DE ANESTESIA GENERAL.
FC: 123/MIN. TA: 114/74/87. FR: 25/MIN. SO2: 99%. T: 35.2. GLUCOMETRIA: 164 MG/DL.
NEUROLOGICO: BAJO EFECTOS DE ANESTESIA GENERAL. PUPILAS A 4 MM REACTIVAS LENTAS. HIPOTONICA.
ORL: INTUBADA CON TUBO OROTRAQUEAL #6.5 CON NEUMOTAPONADOR FIJO EN 19 CM. SIN NSAGRADO NI FUGAS.
CUELLO: LLENADO YUGULAR NORMAL. SIN MASAS.
TORAX: EXPANSIBILIDAD SIMETRICA, SIN RETRACCIONES.
PULMONES: MURMULLO VESICULAR NORMAL, SIN RUIDOS AGREGADOS.
CARDIOVASCULAR: TAQUICARDIA SINUSAL, SIN SOPLOS, PULSOS NORMALES, LL. CAPILAR 3S. NORMOTENSA. GRADIENTE TERMICO.
ABDOMEN: PERISTALTISMO LENTO. BLANDO. SIN DISTENSION, ASCITIS, MASAS NI MEGLIAS.
RENAL: HIDRATADA, EUVOLEMICA, SONDA VESICAL DRENANDO ORINA CLARA.
METABOLICO: HIPOTERMICA, HIPERGLUCEMICA.
HEMATOLOGICO: SIN SANGRADO ACTIVO.
INMUNOLOGICO: RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA ACTIVADA.
OSTEOMUSCULAR: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CUBIERTO CON VENDAJE ELASTICO, LLENADO CAPILAR DISTAL IPSLATERAL EN 3 S, DIFICIL VALORAR PULSOS.
PIEL: ESPALDA CUBIERTA CON COMPRESAS ADHERIDAS CON MICROPORE.

ANALISIS: YESHIA ESTA EN ESTADO CRITICO. CON PRONOSTICO RESERVADO. REINGRESA A LA UCIP EN POSQUIRURGICO INMEDIATO DE PAQUETE DE REVASCULARIZACION Y RECONSTRUCCION ARTERIAL DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, LAVADO, DESBRIDAMIENTO Y COLOCACION DE SISTEMA VAC EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
CON HALLAZGO INTRAOPERATORIO DE ABULSION DEL CONDILO FEMORAL MEDIAL, PERDIDA DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR DE RODILLA IZQUIERDA. A NIVEL VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS EN 1/3 MEDIO SUPERIOR E INFERIOR DEL MUSLO IZQUIERDO. CONTROL VASCULAR DE LA ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL Y POPLITEA EN SU PRIMERA Y SEGUNDA PORCION. TROMBECTOMIA Y RECONSTRUCCION VASCULAR DE VASOS MUSCULARES.
SE DEJA EN UCIP SOPORTADA CON VENTILACION MECANICA INVASIVA, SEDOANALGESIA, SOPORTE VASOPRESOR SI TAM <65 MMHG. ANTIBIOTICOTERAPIA, REPOSICION DE CALCIO, PROTECCION GASTRICA CON IBP Y CON HIDRATACION CON CRISTALOIDE BALANCEADO.
PLAN: VER ORDENES MEDICAS.

JOSE GERMAN NARVAEZ B.
PEDIATRA INTENSIVISTA. RM 52305/2000 - 76319436

2026-03-05 05:31	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

** REPORTE DE PARACLINICOS **

N° Orden: 202603040210

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

2026-03-05 08:26	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

*** REPORTE DE PARACLINICOS ***

04/03/2026

ORDEN: 202603040210

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

ORDEN: 202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO
TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h Pendiente
REPORTE FINAL SEC Pendiente

05/03/2026
ORDEN: 202603050123

CPK TOTAL 4060.0

CLORO 104.0
POTASIO 4.50
SODIO 135.0

NITROGENO UREICO 12.0
CREATININA SERICA 0.50

HEMATOCRITO 32.3
HEMOGLOBINA 11.1
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264
NEUTROFILOS Abs 7.89
LINFOCITOS Abs 1.26
MONOCITOS Abs 1.45
EOSINOFILOS Abs 0.01
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 72.8
LINFOCITOS % 11.6
MONOCITOS % 13.4
EOSINOFILOS % 0.1
BASOFILOS % 0.0

CKP ELEVADA
ELECTROLITOS NORMALES
AZOADOS NORMALES
HEMOGRAMA CON ANEMIA LEVE, SIN LEUCOCITOSIS, PLAQUETAS NORMALES

ORDEN: 202603050125
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

orden: 202603050129
NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

INR 1.23
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9

AZOADOS NORMALES
TIEMPOS DE COAGULACION PROLOGANDOS

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117 (VALORES DE REFERENCIA: 0.000 - 0.034 ng/ml) --- POSITIVA

ORDEN: 202603050130

ACIDO LACTICO 2.01

pH 7.331
PCO2 41.8
pO2 30.2
HCO3act 21.6
HCO3std 20.4
BE(B) -4.1
BE(ecf) -4.3
ctCO2 22.9
tHb 11.7
SO2 61.6

LACTATO EN LIMITE NORMAL SUPERIOR
GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICO, NORMOCAPNIA, HIPOXEMIA

2026-03-05 11:46	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - PEDIATRIA -DIA HORA O730
DR. MILTON MOLANO (PEDIATRA INTENSIVISTA) FABIAN CHANTRE (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774
ENTIDAD: SIN INFORMACION
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UCIP: 04/03/2026

DIAGNOSTICOS:
1.ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1POLITRAUMATISMO
1.2TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3RABDOMIOLISIS
2.TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION
2.1CONTUSION PULMONAR BILATERAL
2.3 MULTIPLES QUEMADURAS POR FRICCION EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
2.4RIESGODE LESION DE GRANDES VASOS
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
–FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4-TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5.TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1DEFECTO DE COBERTOURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2 AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3 POP ORTOPEDIALAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACION DE SISTEMA VAC.
5.4 POP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACION Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERIFICIAL, POPLITEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCION. TROMBECTOMIA Y RECONSTRUCCION VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACION VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFASICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACION DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACION DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLITEA.
6.CHOQUE HIPOVOLEMICO GRADO IV
7.FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 SECUNDARIA CHOQUE HIPOVOLEMICO

CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO
SOPORTE VASOPRESOR DUAL
SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO
POLITRAUMA

MONITORIA
–GASTO CARDIACO NO INVASIVO

–MONITORIA NIRS

SOPORTES:
- VMI MODO VC+ CON PARÁMETROS FR:20/24 RPM ; VT: 6ML / K ; VTE:307 ML VENTILADA A 6.5ML/KG; TI:0.86SEG; R I:E: 1:2.5; FIO2:30%; PEEP:5.0CMH2O; VSEN: 2.0L/MIN. CON MECÁNICA VENTILATORIA PIP: 16 CMH2O; PMEAN: 8.9CMH2O; PL:15CMH2O; CE: 30; CD: 33; DP: 10 DENTRO DE LIMITE PROTECTOR; ECO2:78 MMHG
-NOREPINEFRINA SE INICIA VASOPRESINA
- MIDAZOLAM -FENTANYL SE SUSPENDE
–KETAMINA INFUSION CONTINUA
-DEXMEDETOMIDINA INFUSION CONTINUA

ANTIBIOTICO AMPICILINA SULBACTAM

INVASION
INTUBACION TRAQUEAL TOT 6,5 CON NEUMOTAPÓNADOR FIJO 21 CM
SONDA VESICAL
CATETER VENOSO CENTRAL
LINEA ARTERIAL

EXAMEN FÍSICO:
PACIENTE EN CONDICION CRITICA INESTABILIDAD HEMODINAMICA TAQUICARDICA
SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 87/57 MMHG TAM:67 MMHG
FRECUENCIA CARDIACA: 160 L/MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 20/MIN
SO2: 99 % CON FIO2 DEL 30 % VMI
TEMPERATURA: 36.8 °C AFEBRIL EN 9 HORAS
BALANCE HÍDRICO EN 9 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 1360 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 740 CC
BALANCE DEL DIA: + 620 CC
BALANCE ACUMULADO: + 620 CC
GU: 1.8 CC/KG/H
METABOLICO: SIN VIA ORAL, GLUCOMETRIA: 164 MG/DL, SIN DEPOSICIONES DESDE EL INGRESO

.- CABEZA Y CUELLO: PRESENTA HERIDA DE APROXIMADAMENTE 3 CM QUE COMPROMETE PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO, SIN SANGRADO ACTIVO, CON QUEMADURA POR FRICCIÓN, EN REGION FRONTAL IZQUIERDA.
.- NEUROLÓGICO: PUPILAS MIOTICAS SEDACION FENTANILO MIDAZOLAM
-OTORRINOLARINGOLÓGICO: INTUBACION TRAQUEAL SIN SANGRADO POR TUBO
.- TÓRAX : MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN LESION N°1 TORAX POSTERIOR EN REGION MEDIA DE APROXIMADAMENTE 10 CM, LESION N° 2 QUEMADURA POR FRICCIÓN EN HEMITÓRAX POSTERIOR IZQUIERDO DE APROXIMADAMENTE 15 CM BORDES IRREGULARES, LESIÓN N° 3 QUEMADURA POR FRICCIÓN EXTENSA QUE COMPROMETE REGION LUMBAR, SACRA Y DORSAL IZQUIERDA , INTUBACIÓN TRAQUEAL EXPANSIÓN SIMÉTRICA , CLARO PULMONAR DISMINUIDO EN LAS BASES SINCRÓNICO CON EL SOPORTE VENTILATORIO
.- CARDIOVASCULAR: TAQUICARDIA SINUSAL, PULSOS DEBILES DISTALES , LLENADO CAPILAR >5 SEGUNDOS CON GRADIENTE TERMICO.
.- ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO, SIN DISTENSION,
-RENAL: DIURESIS COLURICA
-HEMATOLOGICO: NO HAY SANGRADO VISIBLE
-OSTEOMUSCULAR: MII CON VENDAJE QUIRURGICO ELASTICO

-ANALISIS:
PACIENTE QUIEN INGRESA EN CONDICION CRITICA
++POLITRAUMA TRAUMA POR APLASTAMIENTO
++CON TRAUMA TORAX PREDOMINAN LESIONES EN REGION DE DORSO CON RIESGO DE EVOLUCION A SDRA , HIPOXEMIA MODERADA , FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 REQUIERE INTUBACION TRAQUEAL . NO HAY EN LA TOMOGRAFIA NI EN LA VALORACION POCUS E SIGNOS DE COMPROMISO DE GRANDES VASOS O DERRAME PERICÁRDICO, DESDE SU INGRESO DE CIRUGIA TAQUICARDIA PERSISTENTE VALORACIÓN POCUS E HIPOVOLEMIA SE INDICA CONTINUA REANIMACION VOLUMETRICA CON SOLUCION HIPERTONICA Y CRISTALOIDES
++ABDOMEN SIN TRAUMA EVIDENTE
++RENAL RIESGO DE LESIÓN RENAL AGUDA CURSANDO CON SÍNDROME DE REPERFUSIÓN + RABDOMIOLISIS CON RIESGO DE CURSAR A INSUFICIENCIA RENAL
++METABOLICO CON TENDENCIA A LA HIPERGLICEMIA EN FASE AGUDA DE REANIMACION
++HEMATOLOGICO, RIESGO DE EVENTOS TROMBOEMBOLICOS
++PELVIS FRACTURA DE RAMA ISQUIOPUBICA NO SE EVIDENCIA EN CORPO TAC LIQUIDO EN PELVIS LIBRE SIN DATOS DE HEMOPERITONEO, EL ANILLO PELVICO NO SE VE COMPROMETIDO ORTOPEDIA INDICA MANEJO DE SEGUIMIENTO MEDICO
++NEUROLOGICO SIN LESIONES EN TAC DE CRANEO , SE DOCUMENTO ALTERACION DEL ESTADO CONCIENCIA A SU INGRESO SECUNDARIO A CHOQUE
RIESGOS
—EVOLUCION A DISFUNCION DE MULTIPLES ORGANOS
—CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION
--RIESGO DE EVOLUCION A SDRA
--RIESGO DE FALLA RENAL
CURSANDO CON SINDROME POSTREPERFUSION
SE EXPLICA A LA MAMA EL CUADRO CLÍNICO ACTUAL RIESGO DE COMPLICACIONES GRAVES INCLUSO DE FALLECER

PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,1 A 1 MCG / K / H
KETAMINA 2 000 MG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 8 MCG / K / MIN INFUSION ENTRE 5 A 30 MCG / K / MIN
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 500 MG, C/6H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

REALIZAR ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.
SUSPENDER MIDAZOLAM FENTANILO

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION PROFUNDA RASS DE -4
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 80 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PROTECTOR
--NORMOXEMIA , HIPERCAPNIA PERMISIVA
--VT 4 A 6 ML / K DP MENOR DE 15 CMH20 PRESION MESETA MENOR DE 28 CMH20
--PEEP OPTIMO CON METAS HEMODINAMICAS INCREMENTAR EL PEEP PROGRESIVAMENTE HASTA 8 CMH2O
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
--CADA 12 HORA GASES ARTERIOVENOSOS CALCULAR SHUNT INTRAPULMONAR META DELTA DE CO2 MENOR DE 10 MMHG ARTERIOVENOSO CUANDO SE TOME LOS GASES REGISTRAR CAPNOGRAFIA Y SO2 N ESE MOMENTO
GI METABOLICO
--INICIAR MAÑANA SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE 0, 8 Y 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2

2026-03-05 11:47	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

HORA 09 00 NOTA DE PROCEDIMIENTO
PACIENTE EN CONDICION CRITICA CON SOPORTE VASOPRESOR ELEVADO SE INDICA MONITORIA DE LINEA ARTERIAL
TRUAMA EN REGION DE EXTREMIDADES CON ABRASIONES
SE INSERTA PREVIA ASEPSIA ANTISEPSIA LINEA ARTERIAL FEMORAL DERECHA UNICA PUNCION SE PASACATETER DE LINEA ARTERIAL

2026-03-05 13:19	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

*** NOTA RETROSPECTIVA DE TRANSFUSION ***

INICIO: 04/03/2026 HORA:12:52 H
TA: 72/40 MMHG FC:112 LPM, FR:12 RPM T:36.2 °C

1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO:
#1 No UNIDAD Y SELLO: 3095524 VOL. 227 CC

1 UNIDAD DE PLAQUETAS:
#1: No UNIDAD Y SELLO: 26060266A VOL. 221 CC

FINALIZA: 03:20 HORAS
TA: 112/79 MMHG FC:150 LPM, FR:20 RPM T:36.5 °C

FINALIZA PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES O REACCIONES TRANSFUSIONALES

2026-03-05 13:28	**PROFESIONAL:** jhosualo - JHON FREDY SUAREZ LONDOÑO	**ESPECIALIDAD:** PSICOLOGIA

VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA

MOTIVO DE CONSULTA: PACIENTE MENOR DE EDAD VICTIMA DE ACCIDENTE DE TRANSITO CON TRAUMA COMPLEJO EN MII SE SOLICITA INTERVENCIÓN POR ESTE SERVICIO PARA LA FAMILIA.

SE ACUDE AL SERVICIO DE UCI PEDIÁTRICA, DONDE SE ENCUENTRA LA PACIENTE MENOR DE EDAD EN COMPAÑÍA DE SU MADRE, LA SEÑORA JAVILET CASTILLO. SE BRINDA UN ESPACIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DIRIGIDO A LA FAMILIAR, QUIEN SE MUESTRA COLABORADORA, RECEPTIVA Y DISPUESTA AL ABORDAJE PSICOLÓGICO.

DURANTE LA INTERVENCIÓN SE OBSERVA AFECTO ACORDE A LA SITUACIÓN, CON PREDOMINIO DE PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE SALUD DE SU HIJA, LLANTO FÁCIL Y ELEVADO NIVEL DE ANSIEDAD ANTE EL ESTADO CRÍTICO DE LA MENOR Y LA ALTA PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE LA EXTREMIDAD. DE IGUAL MANERA, MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE SALUD DE SU ESPOSO, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE URGENCIAS. NO OBSTANTE, MANTIENE UNA ACTITUD ESPERANZADORA Y OPTIMISTA FRENTE A LA EVOLUCIÓN CLÍNICA.
UNA VEZ ESTABLECIDO EL VÍNCULO TERAPÉUTICO, LA MADRE REFIERE:

"NOSOTROS SOMOS DE FLORIDA. MI ESPOSO IBA EN LA MOTO CON MI HIJA CUANDO UN BUS VENÍA DETRÁS DE ELLOS. NO SABEMOS SI EL CONDUCTOR SE QUEDÓ DORMIDO O QUÉ PASÓ, PERO LOS ATROPELLÓ. MI ESPOSO CAYÓ HACIA UN LADO DE LA CARRETERA Y NO ENCONTRABAN A MI HIJA, HASTA QUE LA VIERON DEBAJO DE LAS LLANTAS. LA ENCONTRARON MUY MALHERIDA. AHORA ME DICEN QUE, COMO EL BUS LE ARRANCÓ MUCHA CARNE DE LA PIERNA, PUEDE QUE SE LA TENGAN QUE AMPUTAR (LLANTO). ESO ME TIENE MUY MAL; ELLA SOLO ES UNA NIÑA".

SE REALIZA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER EL AUTOCUIDADO COMO PRIORIDAD DENTRO DE SU ROL DE CUIDADORA PRINCIPAL, INCENTIVANDO LA REACTIVACIÓN DE SUS PROPIOS PROCESOS MÉDICOS Y LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE APOYO FAMILIAR Y EMOCIONAL.

ABORDAJE POR PSICOLOGÍA

.SE REALIZA INTERVENCIÓN EN CRISIS DIRIGIDA A LA MADRE DE LA PACIENTE, BRINDANDO CONTENCIÓN EMOCIONAL Y ESPACIO DE ESCUCHA ACTIVA PARA FACILITAR LA EXPRESIÓN DE TEMORES Y ANGUSTIA FRENTE AL ESTADO CRÍTICO DE SU HIJA.
.SE EXPLORAN REACCIONES EMOCIONALES ASOCIADAS AL EVENTO TRAUMÁTICO Y AL PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN EN UCI PEDIÁTRICA, IDENTIFICANDO PREOCUPACIÓN INTENSA, LLANTO FÁCIL Y ELEVADO NIVEL DE ANSIEDAD.
.SE VALIDA LA RESPUESTA EMOCIONAL DE LA MADRE COMO ESPERABLE ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL CONTEXTO DE CRISIS FAMILIAR.
.SE IDENTIFICA SOBRECARGA EMOCIONAL RELACIONADA CON EL ESTADO CRÍTICO DE LA MENOR Y LA SITUACIÓN DE SALUD DE SU ESPOSO, QUIEN TAMBIÉN RESULTÓ AFECTADO EN EL ACCIDENTE.
.SE EXPLORAN FACTORES DE RIESGO COMO ESTRÉS AGUDO E INCERTIDUMBRE FRENTE AL PRONÓSTICO MÉDICO Y POSIBLE AMPUTACIÓN DE LA EXTREMIDAD.
.SE IDENTIFICAN FACTORES PROTECTORES COMO VÍNCULO AFECTIVO SÓLIDO CON LA MENOR, ACTITUD ESPERANZADORA Y PRESENCIA DE RED DE APOYO FAMILIAR.
.SE BRINDA PSICOEDUCACIÓN SOBRE REACCIONES EMOCIONALES ESPERABLES EN CONTEXTOS DE HOSPITALIZACIÓN EN UCI PEDIÁTRICA.
.SE PROMUEVEN ESTRATEGIAS BÁSICAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y AUTOCUIDADO, FORTALECIENDO RECURSOS DE AFRONTAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN.

**CONTINÚA SEGUIMIENTO POR PSICOLOGÍA*

2026-03-05 15:19	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

IMAGENES

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL 2026-03-05 HORA 09 0 7

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

DLP 0.499 mGy.cm
Proyección única frontal.
HALLAZGOS:
Opacidades alveolointersticiales difusas en el tercio superior del hemitorax derecho; podría ser de etiología inflamatoria/infecciosa.
Tráquea y bronquios fuentes centrales y permeables.
Ensanchamiento mediastinal superior con un diámetro máximo de 9.1cm, sin lograr descartar lesión ocupante de espacio.
No hay cámaras de neumotórax.
Ángulos costofrénicos libres.
No se observan opacidades consolidativas ni masas en ambos hemitorax.
Engrosamiento cisural derecho.
Tórax óseo con evidencia de fracturas de IV arco costal izquierdo en su sector posterolateral.
Elementos de monitoria externa.

ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales finos desde la base del cráneo hasta C7 con reconstrucciones multiplanares y volumétricas evidenciando:
HALLAZGOS:
No se demuestran alteraciones en los cuerpos vertebrales ni en los elementos posteriores.
Tampoco hay trastornos de la alineación.
Las facetas articulares y las articulaciones uncovertebrales presentan aspecto corriente.
No se demuestran particularidades en los discos intervertebrales ni en los agujeros de conjugación.
No hay lesiones líticas ni blásticas.
El canal raquídeo y los recesos lo mismo que los agujeros intervertebrales son amplios y suficientes.
No se demuestran lesiones compresivas ni erosivas.
La médula espinal tiene morfología y densidad normales.
No hay colecciones anormales ni alteraciones epi o subdurales.
Los tejidos blandos paravertebrales no muestran alteraciones.
CONCLUSIÓN:
1. EL PRESENTE ESTUDIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se obtienen cortes axiales finos desde la base del cráneo al vértex.
HALLAZGOS:
En la ventana ósea no se identifican trazos radiolúcidos de fracturas desplazadas ni deprimidas.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En la ventana para parénquima cerebral, se identifica adecuada diferenciación entre corteza y sustancia blanca.
Línea media central.
El volumen y la morfología del sistema ventricular es normal.
Núcleos basales normales.
Cisternas basales libres.
Cerebelo y tallo cerebral de aspecto habitual.
No se identifican colecciones endocraneanas hiperdensas que sugieran hematomas intra ni extraaxiales de carácter agudo.
OPINIÓN:
1. ESTUDIO NEGATIVO PARA SIGNOS DE LESIÓN TRAUMÁTICA ENDOCRANEANA
DE CARÁCTER AGUDO.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE TORAX CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del cuello hasta el hemiabdomen superior previa

administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Corazón de tamaño normal.
Aorta y el origen de los vasos supraaórticos son normales.
Vasos pulmonares normales.
Tráquea y bronquios fuente de aspecto normal.
No hay masas ni colecciones mediastinales.
Espacios pleurales libres.
No hay cámaras de neumotórax.
En la ventana pulmonar no se identifican áreas de consolidación ni atelectasia.
La densidad del parénquima pulmonar es normal.
No hay masas ni colecciones pulmonares.
Estructuras de la pared torácica de aspecto usual.
CONCLUSIÓN:
1. ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:00

ESTUDIO: TOMOGRAFIA 3D
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:33

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales en los miembros inferiores, posterior a la administración de medio de contraste endovenoso en fase de adquisición arterial y venosa, identificándose:
HALLAZGOS:
Lo visualizado de ambas arterias ilíacas comunes, internas y externas, conserva realce normal con el contraste, sin extravasación, al igual que las venas adyacentes.
Se identifican fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Núcleos epifisarios presentes, no fusionados.
Parcialmente, se identifica fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
MIEMBRO INFERIOR DERECHO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, sus ramas, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal, sin trombosis, sin extravasación del contraste.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal.
Se observa extravasación del medio de contraste en la cara lateral del muslo entre el tercio medio y tercio distal, proveniente de la arteria femoral profunda, sin afectar ramas principales; corresponden a ramas intramusculares, identificándose zona de extravasación de aprox. 4cm, que se extiende a lo largo de la cara lateral del resto del muslo y la rodilla en el lado izquierdo, por sangrado agudo activo. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Se identifica distorsión del tercio medio y distal del músculo cuádriceps, tanto en su parte anterior, como en su parte lateral, en relación con lesión muscular con mayor afectación del vasto del cuádriceps; también hay distorsión de la parte más inferior del músculo bíceps femoral, por lo que se sospecha lesión parcial del mismo, la mayoría del sangrado es en el interior del vasto lateral del cuádriceps, con pérdida de tejido en la parte anterior extensa que sugiere exposicion mucular, asociado a algunas imagenes densas puntiformes que sugiren cuerpos extraños.
Enfisema subcutáneo generalizado.
En el muslo no se definen fracturas.
Núcleos epifisarios presentes, conservados.
Derrame articular en la rodilla.
ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO

DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

Distorsión de los tejidos blandos anteriores de la rodilla, tanto medial como lateral, que sugiere solución de continuidad extensa.
No se definen fracturas.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
CONCLUSIÓN:
Sangrado agudo activo abundante, con extravasación del medio de contraste en la cara lateral del tercio medio y distal del muslo izquierdo, secundario a lesión vascular de arterias musculares, ramas de la arteria femoral profunda izquierda. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Edema y distorsión, mal definición de los tejidos blandos de la cara lateral del tercio medio y distal del muslo, también de la rodilla de predominio anterior, que sugiere solución de continuidad extensa con exposición muscular.
Irregularidad del tercio medio y distal del músculo cuádriceps en el lado izquierdo en relación con lesión muscular que afecta sobre todo el vasto lateral del cuadriceps.
Distorsión de la parte inferior del músculo bíceps femoral izquierdo que sugiere lesion parcial del mismo.
En forma adicional, en lo visualizado de la pelvis se identifica: fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:34

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TORAX
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 0.499 mGy.
HALLAZGOS:
Silueta cardiomediastínica normal.
La vascularización pulmonar es normal.
La transparencia pleuropulmonar es satisfactoria.
Estructuras óseas normales.
CONCLUSIÓN:
ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:06

ESTUDIO: TAC DE ABDOMEN TOTAL CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del tórax hasta la sínfisis púbica previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Hígado de volumen y morfología habituales, sin lesiones focales del parénquima.
Vesícula biliar distendida de aspecto usual.
La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
Páncreas sin alteración.
Bazo de volumen y morfología habituales sin lesiones focales.
Riñones que concentran y eliminan adecuadamente el medio de contraste sin lesiones focales del parénquima ni dilatación de los sistemas colectores.
Glándulas suprarrenales normales.
Vasos retroperitoneales normales.
Vejiga adecuadamente distendida de aspecto habitual.
No se identifican lesiones estenosantes ni compresiones extrínsecas a nivel intestinal.
No hay líquido libre intraabdominal.
No hay cámaras de neumoperitoneo.
Con ventana ósea se observa trazo de fractura a nivel de cuerpo vertebral de L4.

CONCLUSIÓN:
1. FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL DE L4. SE SUGIERE COMPLEMENTO CON TOMOGRAFÍA LUMBOSACRA.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:01

2026-03-05 15:29	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

PARACLINICOS

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl

RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O

GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h Pendiente
REPORTE FINAL SEC Pendiente

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg

INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-05 15:29	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

PARACLINICOS

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS

RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h Pendiente
REPORTE FINAL SEC Pendiente

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg

PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-05 17:02	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

*** NOTA DE TRANSFUSION ***

INICIO: 05/03/2026 HORA:13:15 H
TA: 138/68 MMHG FC:112 LPM, FR:25 RPM T:37 °C

1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO:
#1 No UNIDAD Y SELLO: 3137234 VOL. 232 CC

1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS:
#1: No UNIDAD Y SELLO: 26020253 VOL. 265 CC

FINALIZA: 16:30 HORAS
TA: 141/37 MMHG FC: 75 LPM, FR:20 RPM T:36.8 °C

FINALIZA PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES O REACCIONES TRANSFUSIONALES

2026-03-05 17:14	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

PARACLINICOS

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0

NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h Pendiente
REPORTE FINAL SEC ??
??

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11

DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2

LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-05 17:32	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

*** NOTA MEDICA ***

PACIENTE CON DIAGNOSTICOS ANOTADOS, EN TC DE ABDOMEN SE DESCRIBE FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL DE L4, SE COMENTA A CIRUGIA DE COLUMNA (DR ORDOÑEZ) QUIEN SOLICITA RESONANCA MAGNETICA SIMPLE DE COLUMNA LUMBOSACRA PARA DEFINIR CONDUCTAS.

SE SOLICITA ESTUDIO BAJO SEDACION

2026-03-05 20:01	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

PARACLINICOS

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg

pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4

MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO
REPORTE FINAL SEC ??
??

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-05 20:12	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

** REPORTE DE IMAGENES DIAGNOSTICAS **

.- ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

DLP 0.499 mGy.cm
Proyección única frontal.
HALLAZGOS:
Opacidades alveolointersticiales difusas en el tercio superior del hemitorax derecho; podría ser de etiología inflamatoria/infecciosa.
Tráquea y bronquios fuentes centrales y permeables.
Ensanchamiento mediastinal superior con un diámetro máximo de 9.1cm, sin lograr descartar lesión ocupante de espacio.
No hay cámaras de neumotórax.
Ángulos costofrénicos libres.
No se observan opacidades consolidativas ni masas en ambos hemitorax.
Engrosamiento cisural derecho.

Tórax óseo con evidencia de fracturas de IV arco costal izquierdo en su sector posterolateral.
Elementos de monitoria externa.

Informe firmado electrónicamente por:
ADRIANA LUCIA MONTENEGRO
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 25292493
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 14:26

.- ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

Estudio realizado el 05/03/2026.
1. Situs solitus atrial y visceral. Levoapex.
2. Retornos venosos pulmonar y sistémico normales.
3. Septo interauricular e interventricular sin defectos. No se visualiza ductus arterioso.
4. Conexiones aurícula ventriculares concordantes. Válvula Tricúspide con insuficiencia leve con radiante rejugitante de 30 mm de mercurio le permite una calcular una una presión sistólica de arteria pulmonar de 40 mm de mercurio , sin estenosis, Válvula Mitral de aspecto normal, sin estenosis ni insuficiencia.
5. Conexiones ventrículo arteriales concordantes. Válvula pulmonar de aspecto normal, sin estenosis, Válvula Aórtica de aspecto normal, trivalva, sin estenosis ni insuficiencia.
6. Ventrículo derecho de aspecto normal. Función sistólica normal. No hay obstrucción en el tracto desalida.
7. Ventrículo izquierdo de aspecto normal. Función sistodiastólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
8. Arteria Pulmonar de aspecto normal, ramas confluentes.
9. Arco aórtico izquierdo, no sitios de coartación.
10. Tercio proximal de arterias coronarias normal.
11. Pericardio normal.

Conclusión:
1. Corazón de estructura y función normal
2. Signos indirectos pulmonar leve probabilidad baja intermedia (fusión catéter ventricular normal no hay cardiopatía congénita estructural ni trombo ni vegetación ni derrame

Informe firmado electrónicamente por:
ERNESTO VALLEJO
CARDIÓLOGO
No. registro:
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 15:23

2026-03-05 21:52	**PROFESIONAL:** diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - PEDIATRIA - NOCHE
DRA. DIANA DONNEYS (MD ESPECIALISITA) - FRANCISCO QUINTERO P (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774
ENTIDAD:SAVIA SALUD
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UCIP: 04/03/2026

DIAGNOSTICOS:
1.ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1POLITRAUMATISMO
1.2TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3RABDOMIOLISIS
2.TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.0 FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.1CONTUSIÓN MIOCÁRDICA EN SEGUIMIENTO
2.1CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.3 MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
2.4RIESGO DE LESIÓN DE GRANDES VASOS
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
–FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4-TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5.TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2 AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3 POP ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC.
5.4 POP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA.

6.CHOQUE MIXTO HIPOVOLÉMICO GRADO IV +
7.FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 SECUNDARIA CHOQUE HIPOVOLÉMICO

CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO
.- SOPORTE VASOPRESOR DUAL
.- SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO
.- MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INVASIVA
.- MONITORIZACIÓN NEUROLÓGICA NIRS
.- REQUERIMIENTO HEMODINÁMICO TIPO STARLING

MONITORIA
.- GASTO CARDIACO NO INVASIVO: IVS: 48 - IGC: 2.9
.- MONITORIA NIRS : L: 93 - R: 67 / L: 93 - R: 68 / L: 81 - R: 67

SOPORTES:
- VMI MODO: MODO AC/VC+: VC+:270, PEEP:5.0, IE:1:2.5, FIOO2 40%, T.INSP 0.85 SEG, FR 20/21 RPM, CON VOL ESP 281, CO2 POR CAPNOGRAFIA: 60 PPICO 16, P.PLATO: 14, DP: 9, VME 7.3

INFUSIONES
- NOREPINEFRINA 0.05 ug/kg/min
- VASOPRESINA 0.3 UI/KG/HR
- KETAMINA 30 UG/KG/MIN
- DEXMEDETOMIDINA 1 UG/KG/ HR

TRASFUSIONES:
2 UNIDADES DE GLÓBULOS ROJOS + 2 DE PLASMA 04/03/2026
1 UNIDAD DE GLÓBULOS ROJOS +1 PLASMA 05/03/2026

* INVASIONES
.- INTUBACIÓN TRAQUEAL TOT 6,5 CON NEUMOTAPÓNADOR FIJO 21 CM 04/03/2026
.- SONDA VESICAL 05/03/2026
.- CATÉTER VENOSO CENTRAL SUBCLAVIO DERECHO - 05/03/2026
.- LINEA ARTERIAL FEMORAL DERECHA - 05/03/2026
.- CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO MSD - 04/03/2026
.- CATETER VENOSO PERIFERICO MSI - 04/03/2023

EXAMEN FÍSICO:
SE VALORA A PACIENTE CON AUTORIZACIÓN FAMILIAR, CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 139/80 MMHG TAM:99 MMHG
FRECUENCIA CARDIACA: 59 L/MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 20/MIN
SO2: 100 % CON BAJO - VMI
TEMPERATURA: 36.8 °C AFEBRIL EN 9 HORAS
BALANCE HÍDRICO EN 12 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 4020.1 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 660 CC
BALANCE DEL DIA: 3360.1 + CC
BALANCE ANTERIOR: + 620 CC
GU: 1.3 CC/KG/H
METABÓLICO: SIN NET, GLUCOMETRIA: 141 -144 MG/DL, SIN DEPOSICIÓN EN LAS ULTIMAS 12 HORAS

- HEMODINÁMICO: SOPORTE VASOACTIVO CON NOREPINEFRINA + VASOPRESINA MEJOR CONTROL DE FRECUENCIAS CARDIACAS , NO FRIALDAD DISTAL, LLENADO CAPILAR DE 3 SEGUNDOS, PULSOS SIMÉTRICOS REGULARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS
- RESPIRATORIO: AMBOS CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS, TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA PARÁMETROS PROTECTORES.
- GASTROINTESTINAL: ABDOMEN NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN LLANTO A LA PALPACIÓN, NO IRRITACIÓN PERITONEAL. TRANSAMINASAS ELEVADAS EN VIGILANCIA
- RENAL:ADECUADO RITMO DIURÉTICO , ORINA CLARA, NO EDEMAS. CPK 2299 EN DESCENSO EN COMPARACION A PREVIA CONTINUA CON HIPERHIDRATACIÓN, ELECTROLITOS CON HIPOCALCEMIA. RESTO NORMALES
- METABOLICO: TOLERANDO VIA ORAL, NO EMESIS, GLUCOMETRIA MG/DL
- HEMATOLÓGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS, CHOQUE HIPOVOLÉMICO GRADO IV HA REQUERIDO 2 TRASFUSIONES DE GLÓBULOS ROJOS Y PLASMA , ÚLTIMOS INR PROLONGADO, PT Y PTT FUERA DE METAS, NO SANGRADO ACTIVO, NO OTRO SIGNOS DE COAGULOPATÍA POR TRAUMA .
- INFECCIOSO: NO PICOS FEBRILES, MANEJO ANTIBIOTICO CON AMPICILINA / SULACTAM
- NEUROLÓGICO:BAJO EFECTOS DE SEDOANALGESIA CON DEXMEDETOMEDINA , KETAMINA, RASS -4, PIUPILAS REACTIVAS DE 1 MM.
-PIEL: MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN LESION N°1 TORAX POSTERIOR EN REGION MEDIA DE APROXIMADAMENTE 10 CM, LESION N° 2 QUEMADURA POR FRICCIÓN EN HEMITÓRAX POSTERIOR IZQUIERDO DE APROXIMADAMENTE 15 CM BORDES IRREGULARES, LESIÓN N° 3 QUEMADURA POR FRICCIÓN EXTENSA QUE COMPROMETE REGION LUMBAR, SACRA Y DORSAL IZQUIERDA
-OSTEOMUSCULAR: MII CON VENDAJE QUIRÚRGICO ELASTICO

* CULTIVOS
.- 05/03/2026 - CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO - EN PROCESO

* ANTIBIOTICO:
.- AMPICILINA SULBCATAM - FI: 04/03/2026

-ANALISIS:
PACIENTE DE 10 AÑOS CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, AHORA CON LOS SIGUEINTES PROBLEMAS
*HEMODINÁMICO: SOPORTE VASOACTIVO CON NOREPINEFRINA + VASOPRESINA, EN PLAN DE TITULACIÓN PACIENTE CON CHOQUE

HIPOVOLÉMICO EN FASE DE OPTIMIZACIÓN DADO COMPORTAMIENTO FISIOPATOLÓGICO PREDOMINANTEMENTE VASODILATADO ALTA SOSPECHA DE CHOQUE MIXTO CON CHOQUE MEDULAR ASOCIADO. DEBE CONTINUAR OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES MACRO Y MICRO HEMODINÁMICAS AHORA SIN SIGNOS DE BAJO GASTO. SE SOLICITA GASES VENOSOS PARA VIGILAR SATURACIÓN VENOSA CENTRAL. MONITOREO STARLING EN METAS. ULTIMAS TROPONINAS DE CONROL EN DESCENSO CON RESPECTO A PREVIAS , ECOCARDIOGRAMA SIN SIGNOS DE CONTUSIÓN MIOCÁRDICA
*RESPIRATORIO: TAC DE TÓRAX SIN ALTERACIONES. AMBOS CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS NO RUIDOS SOBREAGREGADOS, EN VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA PARÁMETROS PROTECTORES ECOCARDIOGRAMA CON SIGNOS INDIRECTOS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR , LOGRANDO METAS DE OXIGENACIÓN.
*ABDOMEN : TAC DE ABDOMEN SIN EVIDENCIA DE LESIONES EN VÍSCERA SOLIDA, SE SOLICITA VALORACION POR NUTIRCION PAR AINICO DE VIA ENTERAL TEMPRANA
* RENAL ADECUADO RITMO DIURÉTICO, ÚLTIMOS ELECTROLITOS CON HIPOCALCEMIA EN REPOSICIÓN SE AJUSTA DOSIS DE LA MISMA, RESTO NORMALES, RABDOMIOLISIS POST TRAUMÁTICA EN MANEJO CON HIPERHIDRATACIÓN ULTIMAS CREATININA Y AZOADOS EN METAS , SIN DETERIOR EN FUNCION RENAL
*HEMATOLÓGICO: CHOQUE HIPOVOLEMICO HEMORRAGIA GRADO IV CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS, ULTIMO HEMOGRAMA CON HB EN METAS, PLAQUETAS EN RANGOS DE SEGURIDAD, TIEMPOS DE COAGULACIÓN PROLONGADO SE INCIA MANEJO CON VITAMINA K , SIN SANGRADO EVIDENTE, NO EN RANGO DE REQUERIMIENTO DE TRANSFUSIÓN DE PLASMA ALTO RIESGO DE COAGULOPATÍA POST TRAUMÁTICA.
*OSTEOMUSCULAR: PELVIS FRACTURA DE RAMA ISQUIOPÚBICA NO SE EVIDENCIA EN CORPO TAC LIQUIDO EN PELVIS LIBRE SIN DATOS DE HEMOPERITONEO, EL ANILLO PÉLVICO NO SE VE COMPROMETIDO ORTOPEDIA INDICA MANEJO DE SEGUIMIENTO MEDICO , SIN CONTRAINDICACIÓN PARA FUTURO REQUERIMIENTO DE ANTICOAGULACION . ADICIONALMENTE OP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA. EN PROCESO ARTERIOGRAFÍA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.
NEUROLÓGICO SIN LESIONES EN TAC DE CRANEO DE INGRESO, SEDACIÓN CON KETAMINA + DEXMEDETOMIDINA, RASS -4, SE EVIDENCIA FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL L4, COMENTADO CON CIRUGÍA DE COLUMNA QUIEN INDICA TOMA DE IRM COLUMNA LUMBOSACRA LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO. POR AHORA SE DEBE PRIORIZAR LA MOVILIZACIÓN EN BLOQUE. CON PROTOCOLO DE MÍNIMA MOVILIZACIÓN.

SE EXPLICA A LA MAMA EL CUADRO CLÍNICO ACTUAL RIESGO DE COMPLICACIONES GRAVES INCLUSO DE FALLECER

PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,1 A 1 MCG / K / H
KETAMINA 2 000 MG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 8 MCG / K / MIN INFUSION ENTRE 5 A 30 MCG / K / MIN
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV. ***NUEVO***
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HROAS ** NUEVO **
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE SOLICITA
GASES VENOSOS, HEMOGRAMA , PT, PTT , LACTATO, ELECTROLITOS COMPLETOS, CPK, FIBRINOGENO
SE SOLICITA VALORACION POR NUTRICION

EN PROCESO
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION PROFUNDA RASS DE -4
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 80 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PROTECTOR
--NORMOXEMIA , HIPERCAPNIA PERMISIVA
--VT 4 A 6 ML / K DP MENOR DE 15 CMH20 PRESION MESETA MENOR DE 28 CMH20
--PEEP OPTIMO CON METAS HEMODINAMICAS INCREMENTAR EL PEEP PROGRESIVAMENTE HASTA 8 CMH2O
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
--CADA 12 HORA GASES ARTERIOVENOSOS CALCULAR SHUNT INTRAPULMONAR META DELTA DE CO2 MENOR DE 10 MMHG ARTERIOVENOSO CUANDO SE TOME LOS GASES REGISTRAR CAPNOGRAFIA Y SO2 N ESE MOMENTO
GI METABOLICO
--INICIAR MAÑANA SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE 0, 8 Y 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2

2026-03-05 21:55	**PROFESIONAL:** marruino - MARIA CAMILA RUIZ NOGUERA	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

EVOLUCION DE FISIOTERAPIA
TERAPIA RESPIRATORIA
YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO

SE INGRESA AL CUBÍCULO SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y EL PREVIO LAVADO DE MANOS SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL. PACIENTE DE SEXO FEMENINO DE 10 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ANOTADOS PREVIAMENTE EN HISTORIA CLÍNICA

A LA REVISIÓN POR SISTEMAS

*SISTEMA NEUROLÓGICO: PACIENTE BAJO SEDOANALGESIA CON KETAMINA Y DEXMEDETOMIDINA, CON UN ESTADO NEUROLÓGICO CON UNA PUNTUACIÓN DE -4 SEGÚN ESCALA RASS.
*SISTEMA CARDIOVASCULAR PULMONAR: SE ENCUENTRA HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE CON REQUERIMIENTO DE VASOPRESOR DUAL DADO POR NOREPINEFRINA Y VASOPRESINA, CON SIGNOS VITALES:
- FRECUENCIA CARDIACA 62 LATIDOS POR MINUTO
- TENSIÓN ARTERIAL 128/65 MILÍMETROS DE MERCURIO
- SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO 99%
- FRECUENCIA RESPIRATORIA 20 RESPIRACIONES POR MINUTO
SE ENCUENTRA CON UN PATRÓN VENTILATORIO COSTODIAFRAGMÁTICO, CON EXCURSIÓN TORÁCICA CONSERVADA. A LA AUSCULTACIÓN SE ENCUENTRA MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES, SIN SOBREAGREGADOS PULMONARES. NO SE OBSERVAN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI ASINCRONÍAS VENTILATORIAS
PACIENTE SE ENCUENTRA CON VÍA AÉREA ARTIFICIAL TOT #6.5, FIJO A 21 CM EN ARCADA DENTAL, CONECTADO A LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN MODO AC VC+, CON PARÁMETROS PROGRAMADOS DE:
- VC 270 ML
- FIO2 DE 40%
- PEEP DE 5.0 CMH2O
- SENSIBILIDAD DE 2.0 LPM
- FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 20 RPM
- T. INSP 0.85 SEG
CON PARÁMETROS RESULTANTES DE:
- PRESIÓN PICO DE 22 CMH2O
- PRESIÓN MESETA DE 18 CMH28
- PRESIÓN MEDIA DE LA VÍA AÉREA DE 9 CMH2O
- VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO DE 257 ML
- FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL DE 21 RESPIRACIONES POR MINUTO
- VOLUMEN MINUTO 5.3
- ETCO2 DE 67 MMHG
- DP DE 13
- IE DE 1:2.5 SEG
- PRESIÓN DE NEUMOTAPONADOR: 30 CMH2O
PACIENTE EN SINCRONÍA CON LA VENTILACIÓN MECÁNICA, CON PRESIONES Y VOLÚMENES EN RANGOS DE PROTECCIÓN PULMONAR.

OBJETIVOS
- PREVENIR COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
- MANTENER OXÍMETRÍA >92%
- FAVORECER PERMEABILIZACIÓN DE LA VÍA AÉREA

INTERVENCION
- MONITORÍA RESPIRARTORIA
- POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER CON CABECERA DE CAMA A 30°
- ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO LENTO COMO TÉCNICA DE DESOBSTRUCCIÓN BRONQUIAL SIN MOVILIZAR SECRECIONES
- SE REALIZA HIGIENE BRONQUIAL CON TÉCNICA DE SUCCIÓN CERRADA POR TUBO OROTRAQUEAL, OBTENIENDO ESCASAS SECRECIONES HIALINAS CON TRAZOS HEMÁTICOS, POSTERIORMENTE SE REALIZA HIGIENE EN CAVIDAD ORAL, SE OBTIENEN MODERADAS SECRECIONES MUCOHIALINAS CON TRAZOS HEMÁTICOS. QUEDA VÍA AÉREA PERMEABLE, A LA AUSCULTACIÓN MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES, SIN SOBREAGREGADOS PULMONARES.
- NO SE REALIZAN CAMBIOS EN EL VENTILADOR MECÁNICO
SE DEJA PACIENTE ESTABLE DENTRO DE SU CONDICIÓN CLÍNICA. SE DEJA CAMA A 30°, CON BARANDAS ARRIBA.

2026-03-06 05:58	**PROFESIONAL:** marruino - MARIA CAMILA RUIZ NOGUERA	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA MADRUGADA
TERAPIA RESPIRATORIA
YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO

SE INGRESA AL CUBÍCULO SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y EL PREVIO LAVADO DE MANOS SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL. PACIENTE DE SEXO FEMENINO DE 10 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ANOTADOS PREVIAMENTE EN HISTORIA CLÍNICA

A LA REVISIÓN POR SISTEMAS

*SISTEMA NEUROLÓGICO: PACIENTE BAJO SEDOANALGESIA CON KETAMINA Y DEXMEDETOMIDINA, CON UN ESTADO NEUROLÓGICO CON UNA PUNTUACIÓN DE -4 SEGÚN ESCALA RASS.
*SISTEMA CARDIOVASCULAR PULMONAR: SE ENCUENTRA HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE CON REQUERIMIENTO DE VASOPRESOR DUAL DADO POR NOREPINEFRINA Y VASOPRESINA, CON SIGNOS VITALES:
- FRECUENCIA CARDIACA 73 LATIDOS POR MINUTO
- TENSIÓN ARTERIAL 109/58 MILÍMETROS DE MERCURIO
- SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO 100%
- FRECUENCIA RESPIRATORIA 20 RESPIRACIONES POR MINUTO
SE ENCUENTRA CON UN PATRÓN VENTILATORIO COSTODIAFRAGMÁTICO, CON EXCURSIÓN TORÁCICA CONSERVADA. A LA AUSCULTACIÓN SE ENCUENTRA MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES, SIN SOBREAGREGADOS PULMONARES. NO SE OBSERVAN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI ASINCRONÍAS VENTILATORIAS
PACIENTE SE ENCUENTRA CON VÍA AÉREA ARTIFICIAL TOT #6.5, FIJO A 21 CM EN ARCADA DENTAL, CONECTADO A LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN MODO AC VC+, CON PARÁMETROS PROGRAMADOS DE:
- VC 270 ML
- FIO2 DE 40%
- PEEP DE 5.0 CMH2O
- SENSIBILIDAD DE 2.0 LPM
- FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 20 RPM
- T. INSP 0.85 SEG
CON PARÁMETROS RESULTANTES DE:
- PRESIÓN PICO DE 18 CMH2O
- PRESIÓN MESETA DE 16 CMH28
- PRESIÓN MEDIA DE LA VÍA AÉREA DE 8.8 CMH2O
- VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO DE 289 ML
- FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL DE 21 RESPIRACIONES POR MINUTO
- VOLUMEN MINUTO 6.5
- ETCO2 DE 74 MMHG
- DP DE 11
- IE DE 1:2.5 SEG
- PRESIÓN DE NEUMOTAPONADOR: 30 CMH2O
PACIENTE EN SINCRONÍA CON LA VENTILACIÓN MECÁNICA, CON PRESIONES Y VOLÚMENES EN RANGOS DE PROTECCIÓN PULMONAR.

OBJETIVOS
- PREVENIR COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
- MANTENER OXÍMETRÍA >92%
- FAVORECER PERMEABILIZACIÓN DE LA VÍA AÉREA

INTERVENCION
- MONITORÍA RESPIRARTORIA
- POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER CON CABECERA DE CAMA A 30°
- ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO LENTO COMO TÉCNICA DE DESOBSTRUCCIÓN BRONQUIAL SIN MOVILIZAR SECRECIONES
- SE REALIZA HIGIENE BRONQUIAL CON TÉCNICA DE SUCCIÓN CERRADA POR TUBO OROTRAQUEAL, OBTENIENDO ESCASAS SECRECIONES HIALINAS CON TRAZOS HEMÁTICOS, POSTERIORMENTE SE REALIZA HIGIENE EN CAVIDAD ORAL, SE OBTIENEN MODERADAS SECRECIONES MUCOHIALINAS CON TRAZOS HEMÁTICOS. QUEDA VÍA AÉREA PERMEABLE, A LA AUSCULTACIÓN MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES, SIN SOBREAGREGADOS PULMONARES.
- PACIENTE AGITADA, POR LO QUE SE NOTIFICA A ENFERMERÍA Y SE OPTIMIZA SEDACIÓN
- A PARTIR DEL CO2 EXHALADO, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: VC DE 295 ML (6.5 ML / KG), FR 22 RPM, T INSP DE 0.78 SEG, OBTENIENDO UN CO2 EXHALADO DE 67 MMHG
SE DEJA PACIENTE ESTABLE DENTRO DE SU CONDICIÓN CLÍNICA. SE DEJA CAMA A 30°, CON BARANDAS ARRIBA.

2026-03-06 07:05	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

SE REINSERTA REPORTE DE PARACLINICOS POR AJUSTE EN DIGITACION

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314

PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA

SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00

DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3

INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-06 08:39	**PROFESIONAL:** evidurqu - EVIS ZIOMARA DURANGO QUINTERO	**ESPECIALIDAD:** CIRUGIA VASCULAR

CIRUGIA VASCULAR - DRA. DURANGO

PACIENTE CON ANTECEDENTE DE TRAUMA SEVERO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO POST OPERATORIO DE REVASCULARIZACION VASCULAR, LAVADO Y DESBRIDAMIENTO DE LA EXTREMIDAD. SE ENCUENTRA ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, SIN SOPORTE VASO ACTIVO Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO. SE EVALUA EXTREMIDAD DISTAL (MII) EL CUAL SE EVIDENCIA ADECUADA PERFUSION DISTAL, LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS. PULSOS DISTALES NO PALPABLES.

CONDUCTA: PACIENTE QUIEN REQUIERE REALIZACION DE ARTERIOGRAFIA MII PARA EVALUAR VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD LA CUAL SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TENGA ESTABLIDAD HEMODINAMICA Y VENTILATORIA.

2026-03-06 09:04	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

MAGENES
ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05

ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Estudio realizado el 05/03/2026.
1. Situs solitus atrial y visceral. Levoapex.
2. Retornos venosos pulmonar y sistémico normales.
3. Septo interauricular e interventricular sin defectos. No se visualiza ductus arterioso.
4. Conexiones aurícula ventriculares concordantes. Válvula Tricúspide con insuficiencia leve con radiante rejugitante de 30 mm de mercurio le permite una calcular una una presión sistólica de arteria pulmonar de 40 mm de mercurio , sin estenosis, Válvula Mitral de aspecto normal, sin estenosis ni insuficiencia.
5. Conexiones ventrículo arteriales concordantes. Válvula pulmonar de aspecto normal, sin estenosis, Válvula Aórtica de aspecto normal, trivalva, sin estenosis ni insuficiencia.
6. Ventrículo derecho de aspecto normal. Función sistólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
7. Ventrículo izquierdo de aspecto normal. Función sistodiastólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
8. Arteria Pulmonar de aspecto normal, ramas confluentes.
9. Arco aórtico izquierdo, no sitios de coartación.
10. Tercio proximal de arterias coronarias normal.
11. Pericardio normal.
Conclusión:
1. Corazón de estructura y función normal
2. Signos indirectos pulmonar leve probabilidad baja intermedia (fusión catéter ventricular normal no hay cardiopatía congénita estructural ni trombo ni vegetación ni derrame)
ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Paciente: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO Página 1 de 2
Informe firmado electrónicamente por:
ERNESTO VALLEJO
CARDIÓLOGO
No. registro:
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 15:23

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL 2026-03-05 HORA 09 0 7

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

DLP 0.499 mGy.cm
Proyección única frontal.
HALLAZGOS:
Opacidades alveolointersticiales difusas en el tercio superior del hemitorax derecho; podría ser de etiología inflamatoria/infecciosa.
Tráquea y bronquios fuentes centrales y permeables.
Ensanchamiento mediastinal superior con un diámetro máximo de 9.1cm, sin lograr descartar lesión ocupante de espacio.
No hay cámaras de neumotórax.
Ángulos costofrénicos libres.
No se observan opacidades consolidativas ni masas en ambos hemitorax.
Engrosamiento cisural derecho.
Tórax óseo con evidencia de fracturas de IV arco costal izquierdo en su sector posterolateral.
Elementos de monitoria externa.

ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales finos desde la base del cráneo hasta C7 con reconstrucciones

multiplanares y volumétricas evidenciando:
HALLAZGOS:
No se demuestran alteraciones en los cuerpos vertebrales ni en los elementos posteriores.
Tampoco hay trastornos de la alineación.
Las facetas articulares y las articulaciones uncovertebrales presentan aspecto corriente.
No se demuestran particularidades en los discos intervertebrales ni en los agujeros de conjugación.
No hay lesiones líticas ni blásticas.
El canal raquídeo y los recesos lo mismo que los agujeros intervertebrales son amplios y suficientes.
No se demuestran lesiones compresivas ni erosivas.
La médula espinal tiene morfología y densidad normales.
No hay colecciones anormales ni alteraciones epi o subdurales.
Los tejidos blandos paravertebrales no muestran alteraciones.
CONCLUSIÓN:
1. EL PRESENTE ESTUDIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Paciente: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO Página 1 de 2
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se obtienen cortes axiales finos desde la base del cráneo al vértex.
HALLAZGOS:
En la ventana ósea no se identifican trazos radiolúcidos de fracturas desplazadas ni deprimidas.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En la ventana para parénquima cerebral, se identifica adecuada diferenciación entre corteza y sustancia blanca.
Línea media central.
El volumen y la morfología del sistema ventricular es normal.
Núcleos basales normales.
Cisternas basales libres.
Cerebelo y tallo cerebral de aspecto habitual.
No se identifican colecciones endocraneanas hiperdensas que sugieran hematomas intra ni extraaxiales de carácter agudo.
OPINIÓN:
1. ESTUDIO NEGATIVO PARA SIGNOS DE LESIÓN TRAUMÁTICA ENDOCRANEANA
DE CARÁCTER AGUDO.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE TORAX CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del cuello hasta el hemiabdomen superior previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Corazón de tamaño normal.
Aorta y el origen de los vasos supraaórticos son normales.
Vasos pulmonares normales.
Tráquea y bronquios fuente de aspecto normal.
No hay masas ni colecciones mediastinales.
Espacios pleurales libres.
No hay cámaras de neumotórax.

En la ventana pulmonar no se identifican áreas de consolidación ni atelectasia.
La densidad del parénquima pulmonar es normal.
No hay masas ni colecciones pulmonares.
Estructuras de la pared torácica de aspecto usual.
CONCLUSIÓN:
1. ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:00

ESTUDIO: TOMOGRAFIA 3D
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:33

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales en los miembros inferiores, posterior a la administración de medio de contraste endovenoso en fase de adquisición arterial y venosa, identificándose:
HALLAZGOS:
Lo visualizado de ambas arterias ilíacas comunes, internas y externas, conserva realce normal con el contraste, sin extravasación, al igual que las venas adyacentes.
Se identifican fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Núcleos epifisarios presentes, no fusionados.
Parcialmente, se identifica fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
MIEMBRO INFERIOR DERECHO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, sus ramas, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal, sin trombosis, sin extravasación del contraste.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal.
Se observa extravasación del medio de contraste en la cara lateral del muslo entre el tercio medio y tercio distal, proveniente de la arteria femoral profunda, sin afectar ramas principales; corresponden a ramas intramusculares, identificándose zona de extravasación de aprox. 4cm, que se extiende a lo largo de la cara lateral del resto del muslo y la rodilla en el lado izquierdo, por sangrado agudo activo. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Se identifica distorsión del tercio medio y distal del músculo cuádriceps, tanto en su parte anterior, como en su parte lateral, en relación con lesión muscular con mayor afectación del vasto del cuádriceps; también hay distorsión de la parte más inferior del músculo bíceps femoral, por lo que se sospecha lesión parcial del mismo, la mayoría del sangrado es en el interior del vasto lateral del cuádriceps, con pérdida de tejido en la parte anterior extensa que sugiere exposicion mucular, asociado a algunas imagenes densas puntiformes que sugiren cuerpos extraños.
Enfisema subcutáneo generalizado.
En el muslo no se definen fracturas.
Núcleos epifisarios presentes, conservados.
Derrame articular en la rodilla.

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL

Distorsión de los tejidos blandos anteriores de la rodilla, tanto medial como lateral, que sugiere solución de continuidad extensa.
No se definen fracturas.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
CONCLUSIÓN:
Sangrado agudo activo abundante, con extravasación del medio de contraste en la cara lateral del tercio medio y distal del muslo izquierdo, secundario a lesión vascular de arterias musculares, ramas de la arteria femoral profunda izquierda. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Edema y distorsión, mal definición de los tejidos blandos de la cara lateral del tercio medio y distal del muslo, también de la rodilla de predominio anterior, que sugiere solución de continuidad extensa con exposición muscular.
Irregularidad del tercio medio y distal del músculo cuádriceps en el lado izquierdo en relación con lesión muscular que afecta sobre todo el vasto lateral del cuadriceps.
Distorsión de la parte inferior del músculo bíceps femoral izquierdo que sugiere lesion parcial del mismo.
En forma adicional, en lo visualizado de la pelvis se identifica: fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:34

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TORAX
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 0.499 mGy.
HALLAZGOS:
Silueta cardiomediastínica normal.
La vascularización pulmonar es normal.
La transparencia pleuropulmonar es satisfactoria.
Estructuras óseas normales.
CONCLUSIÓN:
ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:06

ESTUDIO: TAC DE ABDOMEN TOTAL CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del tórax hasta la sínfisis púbica previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Hígado de volumen y morfología habituales, sin lesiones focales del parénquima.
Vesícula biliar distendida de aspecto usual.
La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
Páncreas sin alteración.
Bazo de volumen y morfología habituales sin lesiones focales.
Riñones que concentran y eliminan adecuadamente el medio de contraste sin lesiones focales del parénquima ni dilatación de los sistemas colectores.
Glándulas suprarrenales normales.
Vasos retroperitoneales normales.
Vejiga adecuadamente distendida de aspecto habitual.
No se identifican lesiones estenosantes ni compresiones extrínsecas a nivel intestinal.
No hay líquido libre intraabdominal.
No hay cámaras de neumoperitoneo.
Con ventana ósea se observa trazo de fractura a nivel de cuerpo vertebral de L4.
CONCLUSIÓN:
1. FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL DE L4. SE SUGIERE COMPLEMENTO CON TOMOGRAFÍA LUMBOSACRA.
Informe firmado electrónicamente por:

GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:01

2026-03-06 09:07	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE REINSERTA REPORTE DE PARACLINICOS POR AJUSTE EN DIGITACION

ORDEN 202603060147
INR Pendiente 1.77 **********
902045 TIEMPO DE PROTROMBINA Pendiente 8.9 - 11.9 17.9 seg
902049 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL Pendiente**********

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0

EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7

FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3

MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg

PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-06 09:50	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - PEDIATRIA HORA DE EVOLUCION 07 30 HORAS
MILTON MOLANO TRUJILLLO INTENSIVISTA PEDIATRA - DR. MONTES V. (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774
ENTIDAD:SAVIA SALUD
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO : 04/03/2026

DIAGNOSTICOS:
1.ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1 POLITRAUMATISMO
1.2 TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3 RABDOMIOLISIS
2.TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1 FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2 CONTUSIÓN MIOCÁRDICA EN SEGUIMIENTO
2.3 CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4 MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
2.5 RIESGO DE LESIÓN DE GRANDES VASOS
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POP ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)
6. CHOQUE MIXTO HIPOVOLÉMICO GRADO IV EN RESOLUCION
7. FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 SECUNDARIA CHOQUE HIPOVOLÉMICO

CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
.- SOPORTE VASOPRESOR DUAL
.- SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO
.- MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INVASIVA
.- MONITORIZACIÓN NEUROLÓGICA NIRS
.- REQUERIMIENTO HEMODINÁMICO TIPO STARLING

EVENTOS
—INESTABILIDAD HEMODINÁMICA CHOQUE DE RESISTENCIAS VASCULARES BAJAS
—REQUIRIÓ VOLUMEN DE REANIMACIÓN MAYOR DE 2 000 CON HEMODERIVADOS
–.REQUIRIÓ DOBLE SOPORTE VASOPRESOR
–DESTETE DE VASOPRESORES
–COAGULOPATÍA POR TRAUMA

MONITORIA
.- GASTO CARDIACO NO INVASIVO: IVS: 48 - IGC: 3,2
.- MONITORIA NIRS : L: 87 -SOMATICO DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO 68

SOPORTES:
-SOPORTE VENTILATORIO MODO ASISTIDO CONTROLADO MODO AC VC+ VT 270 ML PCO2 76 MMHG FR 20 X´ PEEP 5 CMH20 PRESION MEDIA 8,4 MCH20 PRESION MESETA 15 CMH20 SENSIBILIDAD DE 2 L / MIN TI 0, 85 SEG

INFUSIONES
- NOREPINEFRINA 0.05 ug/kg/min
- VASOPRESINA 0.18 UI/KG/HR
- KETAMINA 30 UG/KG/MIN
- DEXMEDETOMIDINA 0.6 UG/KG/ HR

TRASFUSIONES:
2 UNIDADES DE GLÓBULOS ROJOS + 2 DE PLASMA 04/03/2026
1 UNIDAD DE GLÓBULOS ROJOS +1 PLASMA 05/03/2026
6 / 03 / 26 SE INDICA GRE 1 UNIDAD

* INVASIONES
.- INTUBACIÓN TRAQUEAL TOT 6,5 CON NEUMOTAPÓNADOR FIJO 21 CM 04/03/2026
.- SONDA VESICAL 05/03/2026
.- CATÉTER VENOSO CENTRAL SUBCLAVIO DERECHO - 05/03/2026 SALAS DE CIRUGIA
.- LINEA ARTERIAL FEMORAL DERECHA - 05/03/2026 UCIPED

.- CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO MSD - 04/03/2026
.- CATETER VENOSO PERIFERICO MSI - 04/03/2023

EXAMEN FÍSICO:
SE VALORA A PACIENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 110 / 66 MMHG TAM 83MMHG
FRECUENCIA CARDIACA: 66 L/MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 20/MIN
SO2: 100 % CON BAJO - VMI
TEMPERATURA: 36.8 °C AFEBRIL
BALANCE HÍDRICO EN 24 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS:5503 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 1040 CC
BALANCE DEL DIA4463+ CC
BALANCE ANTERIOR: + 5L CC
GU:1 CC/KG/H

METABÓLICO: SIN NET, GLUCOMETRIA: 144 –124 MG/DL, SIN DEPOSICIÓN EN LAS ULTIMAS 24HORAS
.- CABEZA Y CUELLO: PRESENTA HERIDA DE APROXIMADAMENTE 3 CM QUE COMPROMETE PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO, SIN SANGRADO ACTIVO, CON QUEMADURA POR FRICCIÓN, EN REGION FRONTAL IZQUIERDA.
.- NEUROLÓGICO: PUPILAS MIOTICAS SEDACION KETAMINA DEXMEDETOMIDINA
-OTORRINOLARINGOLÓGICO: INTUBACION TRAQUEAL SIN SANGRADO POR TUBO SIN ESCAPE POR EL TOT
.- TÓRAX : MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN DORSO LESION N°1 TORAX POSTERIOR EN REGION MEDIA DE APROXIMADAMENTE 10 CM, LESION N° 2 QUEMADURA POR FRICCIÓN EN HEMITÓRAX POSTERIOR IZQUIERDO DE APROXIMADAMENTE 15 CM BORDES IRREGULARES, LESIÓN N° 3 QUEMADURA POR FRICCIÓN EXTENSA QUE COMPROMETE REGION LUMBAR, SACRA Y DORSAL IZQUIERDA , INTUBACIÓN TRAQUEAL EXPANSIÓN SIMÉTRICA , CLARO PULMONAR DISMINUIDO EN LAS BASES SINCRÓNICO CON EL SOPORTE VENTILATORIO PARAMETROS DE PROTECCION PULMONAR
.- CARDIOVASCULAR: TAQUICARDIA SINUSAL, PULSOS DEBILES DISTALES , LLENADO CAPILAR 53 SEGUNDOS SIN GRADIENTE TERMICO.
.- ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO, SIN DISTENSION,
-RENAL: DIURESIS MENOS COLURICA
-HEMATOLOGICO: NO HAY SANGRADO VISIBLE ANEMIA
-OSTEOMUSCULAR: MII CON VENDAJE QUIRURGICO ELASTICO

-ANALISIS:

FASE DEL TRAUMA INICIA FASE DE DESREANIMACION

PACIENTE EN CONDICIÓN CRITICA

++POLITRAUMA TRAUMA POR APLASTAMIENTO
++CON TRAUMA TORAX PREDOMINAN LESIONES EN REGION DE DORSO CON RIESGO DE EVOLUCION A SDRA , MEJOIRA DE LOS INDICES DE OXIGENACION , INTUBACION TRAQUEAL POR FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 EN RESOLUCION CON INDICACION DE INICIAR PROTOCOLO DE EXTUBACION POSTERIOR A EVENTO QUIRURGICO DE CIRUGIA PLASTICA L SE REALIZA NUEVA VALORACION POCUS
—-TORAX , EN LOS 8 CUADRANTES VALORADOS DE 3 A 4 LINEAS B NO TIENE SIGNOS DE AUMENTO DEL AGUA EXTRAVASCULAR PULMONAR ASOCIADA A VOLUMEN DE REANIMACION
—CARDIOVASCULAR DOPLER PEDIO NORMAL CORAZON INSUFIENCIA LEVE TRICUSPIDEA SIN CAMBIOS RESPECTO A LA –VALORACION DE CARDIOLOGIA , MOVIMIENTO NORMAL DE PAREDES VENTRICULARES POR AREA CALCULO POR –FORMULA FRACCOION DE ACORTAMIENTO DE 38 PARA UNA FE DE 76 MEJORIA DEL ESTADO DE HIPERDINAMIA
—VALORACION DE NERVIO OPTICO NORMAL
—VALORACION DEL VENA CAVA SUPERIOR CONTRACCION DEL 23%
++ABDOMEN SIN TRAUMA EVIDENTE
++RENAL RIESGO DE LESIÓN RENAL AGUDA RIESGO DE CURSAR A INSUFICIENCIA RENAL NO TIENE DATOS CLINICOS ACTUALES DE SINDROME DE REPERFUSION NI DE RABDOMIOLISIS
++METABOLICO CON METAS METABOLICA
++HEMATOLOGICO, RIESGO DE EVENTOS TROMBOEMBOLICOS POR EVENTO QUIRURGICO NO SE INDICA AUN ENOXAPARINA , ANEMIA SE INDICA TRANSFUSION DE GLOBULOS ROJOS
++PELVIS FRACTURA DE RAMA ISQUIOPUBICA NO SE EVIDENCIA EN CORPO TAC LIQUIDO EN PELVIS LIBRE SIN DATOS DE HEMOPERITONEO, EL ANILLO PELVICO NO SE VE COMPROMETIDO ORTOPEDIA INDICA MANEJO DE SEGUIMIENTO MEDICO
++NEUROLOGICO SIN LESIONES EN TAC DE CRANEO , SE DOCUMENTO ALTERACION DEL ESTADO CONCIENCIA A SU INGRESO SECUNDARIO A CHOQUE ACTUALMENTE CON SEDACION CONCIENTE EN PLAN DE LIBERACION DE LA VENTILACION MECANICA
++PIEL LESIONES EN EL DORSO HERIDAS COMPLEJA EN LA CARA EN SEGUIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN PLAN DE LLEVAR A ESCARETOMIA
RIESGOS
—EVOLUCION A DISFUNCION DE MULTIPLES ORGANOS
—CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION
--RIESGO DE EVOLUCION A SDRA
--RIESGO DE FALLA RENAL
CURSANDO CON SINDROME POSTREPERFUSION
SE EXPLICA A LA MAMA EL CUADRO CLÍNICO ACTUAL RIESGO DE COMPLICACIONES GRAVES INCLUSO DE FALLECER

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,1 A 1 MCG / K / H
KETAMINA 2 000 MG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 8 MCG / K / MIN INFUSION ENTRE 5 A 30 MCG / K / MIN
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV.
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HROAS
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
INMOVILIZACION TERAPÉUTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SS PT PTT INR
PASAR AL LLAMADO A CIRUGIA PLASTICA
CONFIRMAR RESERVA DE GRE
TRANSFUNDIR 1 UNIDAD DE GRE AHORA

EN PROCESO
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION PROFUNDA RASS DE -4
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 80 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PROTECTOR
--NORMOXEMIA , HIPERCAPNIA PERMISIVA
--VT 4 A 6 ML / K DP MENOR DE 15 CMH20 PRESION MESETA MENOR DE 28 CMH20
--PEEP OPTIMO CON METAS HEMODINAMICAS INCREMENTAR EL PEEP PROGRESIVAMENTE HASTA 8 CMH2O
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
--CADA 12 HORA GASES ARTERIOVENOSOS CALCULAR SHUNT INTRAPULMONAR META DELTA DE CO2 MENOR DE 10 MMHG ARTERIOVENOSO CUANDO SE TOME LOS GASES REGISTRAR CAPNOGRAFIA Y SO2 N ESE MOMENTO
GI METABOLICO
--INICIAR MAÑANA SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE 0, 8 Y 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2

GRACIAS!

2026-03-06 10:05	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

REPORTE DE PARACLINICOS POR AJUSTE EN DIGITACION

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO

FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00

BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9

ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³

HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR

MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL

PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-06 10:07	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

NOTA DE UNIDAD
PACIENTE COMENTADO CON ANESTESIOLOGO
CONSIDERA ACTUALMENTE EN CONJUNTO CON CIRUGIA PLASTICA SEGUIMIENTO CLINICO
SE OPTIMIZARA CON HEMODERIVADOS

SE INDICA PROCESO DE LIBERACION DE LA VENTILACION MECANCA

2026-03-06 10:07	**PROFESIONAL:** marmulta - MARIA GISELL MURILLO TAMAYO	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

TERAPIA RESPIROATIRA DIA

SE INGRESA CON PREVIO LAVADO DE MANOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL.

PACIENTE YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO DE SEXO FEMENINO DE 10 AÑOS DE EDAD, SE ENCUENTRA EN COMPAÑIA DE FAMILIAR (MADRE), EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, EN DECUBITO SUPINO. BAJO EFECTOS DE SEDOANALGESIA PERO EN DESTETE (MIDAZOLAM Y FENTANYL) RASS -3, PUPILAS ISOCORICAS REACTIVAS, REFLEJO CARINAL Y NAUSEOSO PRESENTES, SE OBSERVA QUE EL PACIENTE PRESENTA ASISTENCIA A LA VENTILACION MECANICA, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE CON SOPORTE VASOACTIVO, CON SOPORTE DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS, SIGNOS VITALES: FC: 112 LPM, FR 18 RPM, T°: 36.2°, TA: 133/78 MMHG, TAM 98 MMHG, SATO2: 97%, SE ECNUENTRA CON VIA AEREA ARTIFICIAL DADA POR TUBO ENDOTRAQUEAL # 6.5 (05.06.2026), EN MODO VOLUMEN CONTROL PLUS, FIO2: 40%, SAT:99%, PEEP:5.0, FR:20/20, VC: 320, VE: 970, P.PICO: 15, VME: 5.8, C.DIN: 42, CO2E: 75.
PACIENTE QUIEN ASISTE A LA VENTILACION MECANICA CON 2 VENTILACIONES POR ENCIMA DE LAS PROGRAMADAS, PRESIONES EN METAS DE SEGURIDAD, Y VOLUEMENES ADECUADOS SIN SOBREDISTENSION, ADECUADA DISTENSIBILIDAD PULMONAR, BAJA ELASTANCIA, NO SE OBSERVA HISTERESIS EN ASA ESPIRATORIA, ESCASAS TURBULENCIAS EN CURVAS Y BUCLES VENTILATORIOS. OXIMETRIAS EN METAS DE OXIGENACION, NO SE OBSERVAN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, TÓRAX CON EXPANSIBILIDAD CONSERVADA, TORÁX SIMÉTRICO, SIN ESFUERZO INSPIRATORIO, A LA AUSCULTACIÓN MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, SIN RUIDOS SOBREAGREGADOS, A LA PALPACIÓN NO SE ENCUENTRA ENFISEMA SUBCUTANEO, NI CREPITACIONES.

INDICACIÓN DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA MEJORIA DE LA VENTILACION, EVITAR DESACOPLE VETILATORIO Y EVITAR ATELECTASIAS POR OBSTRUCCION BRONQUIAL, TECNICAS DE DESOBSTRUCCION BRONQUIAL PARA MANTENER UNA ADECUADA VENTILACION Y OXIGENACION

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA:

.-POSICIONAMIENTO EN SEMIFOWLER EN CAMA
.-FISIOTERAPIA DE TORAX CON MOVILIZACIÓN DE REJA COSTAL
.-ACELERACION DEL FLUJO ESPIRATORIO SIN MOVILIZAR SECRECIONES
.-PERMEABILIZACION DE VIA AEREA POR MEDIO DE TECNICA DE SUCCION CERRADA MOVILIZANDO ESCASAS SECRECIONES MUCOIDES, SE INSTILA CON SOLUCION SALINA PARA EVITAR ADHERENCIAS
.-ASPIRACION DE OROFARINGE OBTENIENDO MODERADAS SECRECIONES HIALINAS
.-SIN CAMBIOS VENTILATORIOS POR EL MOMENTO POR EL MOMENTO
.-SE AJUSTA PRESION DEL NEUMOTAPONADOR EN 26CMH2O

PACIENTE TOLERA INTERVENCIÓN SIN COMPLICACIONES, QUEDA ESTABLE SEGÚN CUADRO CLÍNICO, EN COMPAÑIA DE FAMILIAR.

2026-03-06 12:21	**PROFESIONAL:** juarodsa - JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANTOS	**ESPECIALIDAD:** ANESTESIOLOGIA

NOTA RETROPECTIVA 10: 00 AM

PACIENTE DE 10 AÑOS

DIAGNOSTICOS:
1.ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1 POLITRAUMATISMO
1.2 TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3 RABDOMIOLISIS
2.TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1 FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2 CONTUSIÓN MIOCÁRDICA EN SEGUIMIENTO
2.3 CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4 MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
2.5 RIESGO DE LESIÓN DE GRANDES VASOS
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POP ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)
6. CHOQUE MIXTO HIPOVOLÉMICO GRADO IV EN RESOLUCION

7. FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 SECUNDARIA CHOQUE HIPOVOLÉMICO

PTE CON VENTILACION MECANICA ACIDEMIA METABOLICA - DOBLE SOPORTE VASOPRESOR - COAGULOAPTIA - REQUERIMIENTO DE HEMODERIVADOS
SE COMENTA PACIENTE CON MEDICO DE UCI - CIRUGIA PLASTICA TRATANTE
PROCEDIMIENTO ESCARECTOMIA DORSAL AMPLIA CON ALTO DE RIESGO DE SANGRADO

CIRUGIA PLASTICA REFIERE OPTIMIZAR PRIMIERO HB, MEJORIA HEMODINAMICA PREVIO A PROCEDIMIENTO

SE DEBE RESERVA DE 2 U DE GR
TIENE FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL L4
PROCEDIMIENTO REQUIERE POSICION EN PRONO AUTORIZACION POR CIRUGIA DE COLUMNA
SE ESTARA ATENTO A EVOLUCION
AVISAR CAMBIOS
SE QUEDA ATENTO PARA MODIFICAR CONDUCTA

2026-03-06 12:41	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

NOTA DE UNIDAD HORA 12 20 HORAS
PACIENTE CON RESOLUCION DE EVENTO QUE LA LLEVO A FALLA RESPIRATORIA , CHOQUE HIPOVOLEMICO RESUELTO, PROTOCOLO DE EXTUBACION
SE REALIZA LISTA DE CHEQUEO
NO REQUIERE DEXAMETASONA
SE TRANSFUNDION GRE SIN EVENTOS
SE SUSPENDIO NOREPINEFRINA
VASOPRESINA 0,1 8 U / K / H
TEST DE VENTILACION ESPONTANEA DE 30 MINUTOS
SE TOMA GASES ARTERIALES REPORTE SO2 NORMAL , LACTATO DEPURADO , BASE EXCESO NORMAL
TEST ´POSITIVO
ESCAPE DE AIERE DEL 30 %
CONDICION NEUROLOGICA
HACE CONTACTO CON EL EXAMINADOR
PATENCIA DE REFLEJOS PROTECTORES DE VIA AEREA SUPERIOR
ESTABILIDAD HEMODINAMICA CON MINIMO SOPÓRTE VASOPRESOR
FRECUENCIA CARDIACA NORMAL
VOLUMENES CORRIENTES ESPIRADOS DE 6 A 8 ML / K
SE INDICA EXTUBACION
COMO TECNICA DE RETIRO DE LA VENTILACION SE PASA A VENTILACION MECANICA NO INVASIVA CON CANULA DE ALTO FLUJO
EN PROCESO TOMA DE RADIOGRAFIA DE TORAX

HORA 1240
EXTUBADA
--TOS EFECTIVA
--SO2 98 % FIO2 DE 0, 28
--FRECUENCIAS RESPIRATORIA DE 24 SIN AUMENTO DEL TRABAJO RESPIRATORIO
--DIURESIS DE 300 CC

SE FAVORECE FASE DE DESREANIMACION

2026-03-06 12:53	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

REPORTE DE PARACLINICOS POR AJUSTE EN DIGITACION

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC

pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L

mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL

PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2

LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-06 14:04	**PROFESIONAL:** josordca - JORGE ALBERTO ORDONEZ CASTILLO	**ESPECIALIDAD:** NEUROCIRUGIA

NEUROCIRUGIA

PACIENTE CON POLITRAUMA POR ACCIDENTE DE TRANSITO, BAJO SEDOANALGESIA, MULTIPLES COMORBILIDADES, CON REPORTA DE TAC DE ABDOMEN CON FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL DE L4 LA CUAL REQUIERE RMN LUMBOSACRA SIMPLE PARA CARACTERIZAR LESION Y DEFINIR CONDUCTA, ESTAREMOS ATENTOS A IMAGEN Y LECTURA PARA DEFINIR MANEJO POR NEUROCIRUGIA, LA IMAGEN SE DEBE REALIZAR CUANDO SU CONDICION CLINICA LO PERMITA

2026-03-06 14:47	**PROFESIONAL:** anggomga - ANGELA MARIA GOMEZ GARCIA	**ESPECIALIDAD:** ORTOPEDIA PEDIATRICA

ORTOPEDIA INFANTIL

PACIENTE FEMENINA DE 10 AÑOS CON DX DE:
1. POLITRAUMATISMO
1.1 TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.2 RABDOMIOLISIS
2. FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
3. CONTUSIÓN MIOCÁRDICA EN SEGUIMIENTO
4. CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
5. MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
6. FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
7. EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA MACERADA
8. FRACTURA RAMA ILIOPUBICA IZQUIERDA

PACIENTE EN COMPAÑIA DE LA MADRE, CON SEDOANALGESIA, YA FUE EXTUBADA, EN EL MOMENTO SIN SIGNOS DE DIFICULTAD REPSIRATORIA, SONDA NASOGASTRICA, SONDA VESICAL A CISTOFLO.

QUEMADURAS POR FRICCION EN REGION FRONTOPARIETAL IZQUIERDA CUBIERTAS
QUEMADURAS POR FRICCION EN DORSO
PELVIS ESTABLE
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CON SISTEMA VAC EN MUSLO FUNCIONANTE CON SANGRADO ESCASO EN CANISTER, QUEMADURAS POR FRICICON EN DORSO DE PIE Y TERCIO DISTAL DE LA PIERNA CUBIERTAS.

PACIENTE POLITRAUMATIZADA SECUNDARIO A TRAUMA POR APLASTAMIENTO, A LA ESPERA DE REALIZACION DE RNM PARA EVALUAR FRACTURA EN L4 Y TRAUMA RAQUIMEDULAR. TAMBIEN SE ENCUENTRA PENDIENTE ARTERIORGRAFIA PARA EVALUAR VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD DADA LA SEVERIDAD DEL TRAUMA DE TEJIDOS BLANDOS EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. POR ORTOPEDIA INFANTIL SE ENCUENTRA PENDIENTE TOMA DE RX DE RODILLA Y TAC DE RODILLA PARA EVLUAR LESION EN CONDILO FEMORAL EXTERNO Y PLATILLO TIBIAL LATERAL. SE CARGA TURNO QUIRURGICO PARA NUEVO LAVADO QUIRURGICO CON EL FIN DE CONTROLAR POTENCIAL INFECCION DE TEJIDOS BALNDOS DADA LA GRA CARGA DE MATERIAL CONTAMIENTE EN LOS MISMOS POR MECANISMO DE TRAUMA.
CONTINUA MANEJO MEDICO INSTAURADO INTERDISCIPLINARIO EN UCI

2026-03-06 15:07	**PROFESIONAL:** marmulta - MARIA GISELL MURILLO TAMAYO	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

TERAPIA RESPIROATIRA DIA

SE INGRESA CON PREVIO LAVADO DE MANOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL.

PACIENTE YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO DE SEXO FEMENINO DE 10 AÑOS DE EDAD, SE ENCUENTRA EN COMPAÑIA DE FAMILIAR (MADRE), EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, EN DECUBITO SUPINO. BAJO EFECTOS DE SEDOANALGESIA PERO EN DESTETE (MIDAZOLAM Y FENTANYL) RASS -3, PUPILAS ISOCORICAS REACTIVAS, REFLEJO CARINAL Y NAUSEOSO PRESENTES, SE OBSERVA QUE EL PACIENTE PRESENTA ASISTENCIA A LA VENTILACION MECANICA, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE CON SOPORTE VASOACTIVO, CON SOPORTE DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS, SIGNOS VITALES: FC: 112 LPM, FR 18 RPM, T°: 36.2°, TA: 133/78 MMHG, TAM 98 MMHG, SATO2: 97%, SE ECNUENTRA CON VIA AEREA ARTIFICIAL DADA POR TUBO ENDOTRAQUEAL # 6.5 (05.06.2026), EN MODO VOLUMEN CONTROL PLUS, FIO2: 40%, SAT:99%, PEEP:5.0, FR:20/20, VC: 320, VE: 970, P.PICO: 15, VME: 5.8, C.DIN: 42, CO2E: 75.
PACIENTE QUIEN ASISTE A LA VENTILACION MECANICA CON 2 VENTILACIONES POR ENCIMA DE LAS PROGRAMADAS, PRESIONES EN METAS DE SEGURIDAD, Y VOLUEMENES ADECUADOS SIN SOBREDISTENSION, ADECUADA DISTENSIBILIDAD PULMONAR, BAJA ELASTANCIA, NO SE OBSERVA HISTERESIS EN ASA ESPIRATORIA, ESCASAS TURBULENCIAS EN CURVAS Y BUCLES VENTILATORIOS. OXIMETRIAS EN METAS DE OXIGENACION, NO SE OBSERVAN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, TÓRAX CON EXPANSIBILIDAD CONSERVADA, TORÁX SIMÉTRICO, SIN ESFUERZO INSPIRATORIO, A LA AUSCULTACIÓN MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, SIN RUIDOS SOBREAGREGADOS, A LA PALPACIÓN NO SE ENCUENTRA ENFISEMA SUBCUTANEO, NI CREPITACIONES.

TEST DE VENTILACION ESPONTANEA DE 30 MINUTOS, SE TOMA GASES ARTERIALES REPORTE SO2 NORMAL , 12:20 PM SE INICIA PROTOCOLO DE EXTUBACION SIN COMPPLICACION QUEDADNO EN EL SISTEMA PULMONAR SE ENCUENTRA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA. CON INTERFAZ A CANULA RAM, CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS MODO VENTILATORIO SIMV + PS: 8 CMH2O, PI: 15 CMH2O, PEEP: 5.0 CMH2O, FIO2: 30%, FR: 20-28 RPM, VTE: 6.5 ML P.PICO 20, VME: 0.9 SATURANDO ENTRE 94-97 A LA AUSCULTACION SE ENCUENTRA MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, SIN RUIDOS SOBREAGREGADOS, TORAX SIMETRICO

NORMOEXPANSIBLE, PATRON RESPIRATORIO RITMICO TORACOABDOMINAL SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

INDICACIÓN DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA MEJORIA DE LA VENTILACION, EVITAR DESACOPLE VETILATORIO Y EVITAR ATELECTASIAS POR OBSTRUCCION BRONQUIAL, TECNICAS DE DESOBSTRUCCION BRONQUIAL PARA MANTENER UNA ADECUADA VENTILACION Y OXIGENACION

OBJETIVOS:
FAVORECER LA REEXPANSION PULMONAR.
MITIGAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA
--MONITORIA RESPIRATORIA
--POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER A 45°
--FISIOTERAPIA RESPIRARTORIA CON MOVILIZACIÓN DE REJA COSTAL
--ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO LENTO COMO TECNICA DE DESOBTRUCCION BRONQUIAL, LOGRANDO MOVILIZAR MODERADA CANTIDAD DE SECRECIONES MUCOIDES
-- HIGUIENE NASAL

PACIENTE TOLERA INTERVENCIÓN SIN COMPLICACIONES, QUEDA ESTABLE SEGÚN CUADRO CLÍNICO, EN COMPAÑIA DE FAMILIAR.

2026-03-06 15:35	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

NOTA MEDICA DE TRANSFUSION 06/03/2026

GLOBULOS ROJOS FILTRADOS
VOLUMEN 322 CC
NUMERO DE UNIDAD Y SELLO 3232984
FECHA DE VENCIMIENTO 02/04/2026
HEMOCLASIFICACIÓN: GRUPO O, RH +

FECHA DE INICIO 06/03/2026 HORA DE INICIO 09:28 H
FECHA DE FINALIZACIÓN 06/03/2026 HORA DE FINALIZACIÓN 13:10 H

SIGNOS VITALES AL INICIO FC: 92 LAT/MIN FR: 20 RESP/MIN PA 109/54 MMHG TEMPERATURA 36 ºC
SIGNOS VITALES DURANTE LA TRANSFUSION FC: 105 LAT/MIN FR: 23 RESP/MIN PA 110/58 MMHG TEMPERATURA 35.7 ºC
SIGNOS VITALES FINAL FC: 124 LAT/MIN FR: 20 RESP/MIN PA 101/58 MMHG TEMPERATURA 35.9 ºC
TRANSFUSIÓN SIN COMPLICACIONES, CONTINUA SEGUIMIENTO CLINICO ESTRICTO.

2026-03-06 15:58	**PROFESIONAL:** eriherva - ERIKA JULIETH HERRERA VALLEJO	**ESPECIALIDAD:** NUTRICION Y DIETETICA

*** INTERCONSULTA DE NUTRICIONAL ***

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774

DIAGNOSTICOS:
1.ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1 POLITRAUMATISMO
1.2 TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3 RABDOMIOLISIS
2.TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1 FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2 CONTUSIÓN MIOCÁRDICA EN SEGUIMIENTO
2.3 CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4 MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
2.5 RIESGO DE LESIÓN DE GRANDES VASOS
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POP ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)
6. CHOQUE MIXTO HIPOVOLÉMICO GRADO IV EN RESOLUCION
7. FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 SECUNDARIA CHOQUE HIPOVOLÉMICO

PACIENTE QUE REQUIERE INICIAR MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR NUTRICION Y DIETETICA A LA VALORACION NUTRICIONAL SE EVIDENCIA PACIENTE EN CAMA, CON SOPORTE VENTILATORIO EN COMPAÑIA DE FAMILIAR (MADRE)
VALORACION DE LA INGESTA: PACIENTE QUE NECESITA INICIAR SOPORTE ENTERAL POR SONDA OROYEYUNAL COMO UNICA VIA DE ALIMENTACION YA QUE POR SU CONDICION CLINICA IMPIDE SU PROCESO DE AUTOALIMENTACION Y CON ALTO RIESGO DE BRONCOASPIRACION
LA ENFERMEDAD Y SU RELACION CON LAS NECESIDADES NUTRICIONALES CON TEJIDO MUSCULAR Y PANICULO GRASO EN PARAMETROS NORMALES A NIVEL GENERAL AL MOMENTO DE LA VALORACION
CABEZA Y CUELLO: PRESENTA HERIDA DE APROXIMADAMENTE 3 CM QUE COMPROMETE PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO, SIN SANGRADO ACTIVO, CON QUEMADURA POR FRICCIÓN, EN REGION FRONTAL IZQUIERDA.
OTORRINOLARINGOLÓGICO: INTUBACION TRAQUEAL SIN SANGRADO POR TUBO SIN ESCAPE POR EL TOT
TÓRAX : MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN DORSO LESION N°1 TORAX POSTERIOR EN REGION MEDIA DE APROXIMADAMENTE 10

CM, LESION N° 2 QUEMADURA POR FRICCIÓN EN HEMITÓRAX POSTERIOR IZQUIERDO DE APROXIMADAMENTE 15 CM BORDES IRREGULARES, LESIÓN N° 3 QUEMADURA POR FRICCIÓN EXTENSA QUE COMPROMETE REGION LUMBAR, SACRA Y DORSAL IZQUIERDA , INTUBACIÓN TRAQUEAL EXPANSIÓN SIMÉTRICA , CLARO PULMONAR DISMINUIDO EN LAS BASES SINCRÓNICO CON EL SOPORTE VENTILATORIO PARAMETROS DE PROTECCION PULMONAR
ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO, SIN DISTENSION,
RENAL: DIURESIS MENOS COLURICA
HEMATOLOGICO: NO HAY SANGRADO VISIBLE ANEMIA
OSTEOMUSCULAR: MII CON VENDAJE QUIRURGICO ELASTICO
PARACLINICOS: 2026-03-06 CLORO 108.0 mmol/L NORMAL CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO. FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL SODIO 136.0 mmol/L NORMAL TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL) TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL) FUNCION RENAL (CONSERVADO) NITROGENO UREICO 13.0 CREATININA SERICA 0.50

ANTROPOMETRIA:

PESO ACTUAL: 40 KILOS; TALLA: 1,52 CM;

TALLA/EDAD: > -1 TALLA ADECUADA PARA LA EDAD
IMC/EDAD: >-1 A<+1 IMC ADECUADO PARA LA EDAD
ANALISIS:

PACIENTE CON POLITRAUMATISMO SEVERO, RABDOMIÓLISIS, TRAUMA TORÁCICO, MÚLTIPLES CIRUGÍAS Y CHOQUE HIPOVOLÉMICO EN RESOLUCIÓN, CONDICIONES QUE GENERAN ALTO ESTRÉS METABÓLICO E HIPERCATABOLISMO
PACIENTE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO DE HIPERCATABOLISMO Y DETERIORO NUTRICIONAL AGUDO DEBIDO AL ESTRÉS METABÓLICO SEVERO ASOCIADO AL TRAUMA MAYOR, CIRUGÍA RECIENTE, LESIONES TISULARES EXTENSAS, PROCESO INFLAMATORIO SISTÉMICO Y RABDOMIÓLISIS, CONDICIONES QUE INCREMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE LOS REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS Y PROTEICOS
PACIENTE QUE REQUIERE INCIAR SOPORTE NUTRICIONAL CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN APORTE NUTRICIONAL ADECUADO QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS Y PROTEICOS DE LA PACIENTE EN ESTADO HIPERCATABÓLICO SECUNDARIO A POLITRAUMATISMO, CON EL FIN DE PRESERVAR LA MASA MUSCULAR, FAVORECER LA CICATRIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS TEJIDOS LESIONADOS, APOYAR LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA Y CONTRIBUIR A LA ESTABILIDAD METABÓLICA DURANTE LA FASE CRÍTICA DE LA HOSPITALIZACIÓN.

PLAN DE MANEJO NUTRICIONAL

1. INICIAR SOPORTE ENTERAL CON ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES PARA EL MANEJO NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 2 A 13 AÑOS, CON DESNUTRICION PROTEICO - CALORICA MODERADA O SEVERA ASOCIADA , QUE NO PUEDEN SUPLIR SUS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES CON UNA ALIMENTACION NORMAL O MODIFICADA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR APORTE DE NUTRIENTES, FRENAR COMORBILIDADES SECUNDARIAS A LA DESNUTRICION , COADYUDAR AL PROCESO DE LA CICATRIZACION COMO PARTE INTEGRAL DEL TRATAMIENTO MEDICO
PEDIASURE CLINICAL BOTELLA X 220ML NVIMA RSA-004217-2017 CODIGO MIPRES 170116
CALCULO NUTRICIONAL
CALORIAS POR KILOGRAMO DE PESO 49,5KCAL
CALORIAS EN 24 HORAS: 1980CAL
VOLUMEN EN 24 HORAS: 1320ML
VELOCIDAD DE INFUSION 55ML POR HORAS
PASAR 6 UNIDADES POR BOMBA DE INFUSION INICIAR A 10ML SI EL PCIENTE TOLERA AUMENTAR CADA 6 HORAS 10ML HASTA COMPLETAR VELOCIDAD DE INFUSION
VERIFICAR ALTERACIONES METABOLICAS O GASTROINTESTINALES CON EL INICO DE LA FORMULA
ESTE SERVICIO QUEDA ATENTO A EVOLCUION DE LA PACIENTE

Se diligencia procedimiento segun resolucion numero 2718 del 2024, por la cual se actualizan los servicios y tecnologias de salud financiados con recursos de la unidad de pago por capita (UPC)

2026-03-06 18:21	**PROFESIONAL:** milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO	**ESPECIALIDAD:** CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

REPORTE DE PARACLINICOS POR AJUSTE EN DIGITACION

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC

pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L

mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL

PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente A LA HORA ACTUAL SIN REPORTE DE 48 HORAS **********
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2

LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-06 22:29	**PROFESIONAL:** annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - PEDIATRIA NOCHE
DRA. ANNI QUIÑONES (MD ESPECIALISTA) - FABIAN CHANTRÉ (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774
ENTIDAD:SAVIA SALUD
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO : 04/03/2026

DIAGNOSTICOS:
1.ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1 POLITRAUMATISMO
1.2 TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3 RABDOMIOLISIS
2.TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1 FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2 CONTUSIÓN MIOCÁRDICA EN SEGUIMIENTO
2.3 CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4 MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
2.5 RIESGO DE LESIÓN DE GRANDES VASOS
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POP ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)
6. CHOQUE MIXTO HIPOVOLÉMICO GRADO IV EN RESOLUCION
7. FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 SECUNDARIA CHOQUE HIPOVOLÉMICO

CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
.- SOPORTE VASOPRESOR DUAL
.- SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO
.- MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INVASIVA
.- MONITORIZACIÓN NEUROLÓGICA NIRS
.- REQUERIMIENTO HEMODINÁMICO TIPO STARLING

EVENTOS
*DESTETE DE VASOPRESOR
*TOLERO EXTUBACIÓN PROGRAMADA
*COAGULOPATÍA POR TRAUMA
*CHOQUE HIPOVOLÉMICO RESPONDEDOR A CRISTALOIDES Y HEMODERIVADOS

MONITORIA
.- GASTO CARDIACO NO INVASIVO: IVS: 48 - IGC: 3,2
.- MONITORIA NIRS : L: 87 -SOMATICO DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO 68

SOPORTES:
- OXIGENO POR CANULA RAM FiO2 30%

INFUSIONES:
- VASOPRESINA 0.18 UI/KG/H
- DEXMEDETOMIDINA 0.6 UG/KG/ H

TRASFUSIONES:
2 UNIDADES DE GLÓBULOS ROJOS + 2 DE PLASMA 04/03/2026
1 UNIDAD DE GLÓBULOS ROJOS +1 PLASMA 05/03/2026
06/ 03/26 SE INDICA GRE 1 UNIDAD

* INVASIONES
.- INTUBACIÓN TRAQUEAL TOT 6,5 CON NEUMOTAPÓNADOR FIJO 21 CM 04/03/2026 FF 06/03/2026
.- SONDA VESICAL 05/03/2026
.- CATÉTER VENOSO CENTRAL SUBCLAVIO DERECHO - 05/03/2026 SALAS DE CIRUGÍA
.- LINEA ARTERIAL FEMORAL DERECHA - 05/03/2026 UCIPED
.- CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO MSD - 04/03/2026
.- CATETER VENOSO PERIFERICO MSI - 04/03/2023

EXAMEN FÍSICO:
SE VALORA A PACIENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 105/55 MMHG TAM: 71 MMHG
FRECUENCIA CARDIACA: 110 L/MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 21/MIN
SO2: 100 % CON CÁNULA RAM FiO2 30 %
TEMPERATURA: 36.6 °C AFEBRIL EN 12 HORAS
BALANCE HÍDRICO EN 12 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 1613 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 1854 CC
BALANCE DEL DIA - 240 CC
GU: 3.8 CC/KG/H
METABÓLICO: SIN NET, GLUCOMETRIAS: 102-96 MG/DL, SIN DEPOSICIÓN EN LAS ULTIMAS 12 HORAS

.- NORMOCONFIGURADA, EDEMA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO CON HERIDA CUBIERTA SIN SANGRADO ACTIVO, PUPILAS 3 MM REACTIVAS A LA LUZ. DOLOR A LA PALPACION. QUEMADURA POR FRICCIÓN, EN REGION FRONTAL IZQUIERDA.
.- HEMODINAMICO: TAQUICARDICA, PRESION ARTERIAL MEDIA >60. INFUSION DE VASOPRESIONA EN DESMONTE.
.- ORL MUCOSAS HUMEDAS ROSADAS . RINOSCOPIA ANTERIOR CANULA NASAL DE ALTO FLUJO.
.- TÓRAX : SIMETRICO, NORMOEXPANDIBLE, VENTILACION MECANICA INVASIVA. CAMPOS PULMONARES HIPOVENTILACIÓN BASAL BILATERAL.
.- ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO IMPRESIONA DOLOR NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL.
.- RENAL: BUEN RITMO DIURETICO. CPK 1469. AZOADOS NORMALES
.- HEMATOLÓGICO: SIN ESTIGMAS DE SANGRADO ACTIVO. ANEMIA MODERADA, PLAQUETAS 159.0000.
.-OSTEOMUSCULAR: MII CON VENDAJE ELASTICO, VAC FUNCIONAL A SUCCION. PERFUSION DISTAL CONSERVADA.
.- NEUROLÓGICO: SALVAS DE AGITACIÓN, SIN MOVIMIENTOS ANORMALES, BAJO EFECTO DE SEDACION CONSCIENTE, GLASGOW 15/15.
.- PIEL : MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN DORSO, LESION N°1 TORAX POSTERIOR EN REGION MEDIA DE APROXIMADAMENTE 10 CM, LESION N° 2 QUEMADURA POR FRICCIÓN EN HEMITÓRAX POSTERIOR IZQUIERDO DE APROXIMADAMENTE 15 CM BORDES IRREGULARES, LESIÓN N° 3 QUEMADURA POR FRICCIÓN EXTENSA QUE COMPROMETE REGION LUMBAR, SACRA Y DORSAL IZQUIERDA.

-ANALISIS:
YESHIA ESCOLAR DE 10 AÑOS HOSPITALIZADA EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO POR POLITRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO SECUNDARIO A ACCIDENTE DE TRANSITO CON LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:
-VARIABLES MACROHEMODINAMICAS EN METAS, TAQUICARDIA SE OPTIMIZA ANALGESIA. PRESION ARTERIAL MEDIA EN METAS, PRESION SISTODIASTOLICA ENTRE PERCENTIL 50 Y 90. SIN DATOS DE BAJO GASTO. GRADIENTE TERMICO. CONTINUA INFUSIÓN DE VASOPRESINA POR CHOQUE MIXTO HIPOVOLÉMICO GRADO IV, LACTATO EN LIMITE SUPERIOR, SE SOLICITA CONTROL.
-RESPIRATORIO: SE REALIZA EXTUBACIÓN PROGRAMADA SIN COMPLICACIONES, TOLERA VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA PARÁMETROS BASALES CONTINUA DESMONTE PROGRESIVO. ESTIGMAS DE TRAUMA DE TORAX CON TAC Y RADIOGRAFÍA EN RANGOS NORMALES. SAFI 333 SIN TRASTORNO DE OXIGENACIÓN.
-GASTROINTESTINAL: CONTINUA SIN VIA ORAL, EN PROCESO INICIAR NUTRICIÓN ENTERAL. NO DESCOMPENSACIÓN GASTROINTESTINAL. NO ESTIGMAS DE TRAUMA. TAC DE ABDOMEN SIN ALTERACIONES.
-METABÓLICO: BUEN CONTROL GLUCOMETRICO.
-RENAL: DIURESIS ESPONTÁNEA NO EDEMAS. AZOADOS EN METAS TFG 128 ML/MIN/1.73 M2, NO EDEMAS. RABDOMIOLISIS EN MANEJO CON HIPERHIDRATACIÓN EN PROCESO CONTROL.
-HEMATOLOGICO. NO SANGRADO ACTIVO. ANEMIA MODERADA EN TRATAMIENTO CON TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS CON INR PROLONGADO CONTINUA VITAMINA K. RIESGO DE EVENTOS TROMBOEMBOLICOS POR EVENTO QUIRÚRGICO CONTINUA DIFEREIDA ENOXAPARINA.
-OSTEOMUSCULAR Y PIEL : TRAUMA EN MIEMBRO INFERIOR DERECHO Y COLUMNA LUMBAR POR APLASTAMIENTO, CON
EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA MACERADA ESCALA DE MES INICIAL DE 9, EXTENSA LESIÓN DE TEJIDOS BLANDOS, CON PERDIDA DE COBERTURA ANTEROLATERAL DEL MUSLO Y PIERNA TERCIO PROXIMAL, AVULSIÓN DEL CÓNDILO FEMORAL EXTERNO, EXPOSICIÓN DEL TENDÓN DEL CUADRICEPS, ROTULA, CÓNDILO FEMORAL EXTERNO Y PLATILLO TIBIAL EXTERNO, PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL, PÉRDIDA DE FASCIA LATA Y MASA MUSCULAR ANTEROLATERAL, GRAN CONTAMINACIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS, SIN EVIDENCIA INTRAQUIRÚRGICA DE LESIÓN VASCULAR DE GRANDES VASOS, PROCEDIMIENTO REALIZADO ORTOPEDIA CON CIRUGÍA VASCULAR SIN COMPLICACIONES, ESCORIACIONES EN CARA ANTEROLATERAL DE PIERNA IZQUIERDA Y DORSO DE PIE DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y BOLSILLO CUTÁNEO EN PIERNA TERCIO PROXIMAL EN PROCESO MANEJO QUIRÚRGICO POR PLASTICA PARA ESCARECTOMIAS. EN PROCESO RMN POR TRAUMA RAQUIMEDULAR PARA EVALUAR FRACTURA EN L4 Y ARTERIOGRAFÍA PARA EVALUAR VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD DADA LA SEVERIDAD DEL TRAUMA DE TEJIDOS BLANDOS EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. EN PROCESO RX DE RODILLA Y TAC DE RODILLA IZQUIERDA SOLICITADA POR ORTOPEDIA INFANTIL PARA DOCUMENTAR LESION EN CONDILO FEMORAL EXTERNO Y PLATILLO TIBIAL LATERAL, EN PROCESO TURNO QUIRURGICO PARA NUEVO LAVADO QUIRÚRGICO CON EL FIN DE CONTROLAR POTENCIAL INFECCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS DADA LA CARGA DE MATERIAL CONTAMINANTE EN LOS MISMOS POR MECANISMO DE TRAUMA. FRACTURA DE RAMA ISQUIOPUBICA SIN COMPROMISO DEL ANILLO PELVICO EN MANEJO CONSERVADOR.
-NEUROLOGICO: ESTADO PSICOTICO AGUDO CON ALUCINACIONES, CON INFUSION DE SEDACION CONSCIENTE RASS +3 SE INICIA MANEJO CON ANTIPSICÓTICO, CONTINUA EN VIGILANCIA. SE OPTIMIZA ANALGESIA. TAC DE CRANEO SIN LESIONES INTRACRANEALES SE DESCARTO COMPONENTE HEMORRAGICO Y OSEO, SIN CRISIS COMICIALES. TRAUMA RAQUIMEDULAR CON FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4 EN PROCESO RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA PARA DOCUMENTAR TIPO DE FRACTURA Y CONDUCTAS ADICIONALES.

PACIENTE CON RIESGO DE FALLA MULTIORGÁNICA CON PRONOSTICO RESERVADO CONTINUA EN VIGILANCIA CLINICA EN LA UNIDAD DE

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO. SE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A LA MADRE.

ORDENES CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
PESO APROX: 40 KG. AHH 70 CC / H AJUSTAR

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
NUTRICION ENTERAL CONTINUA A 10 CC / H META 30 CC/H
NADA POR VIA ORAL.
SOPORTE VENTILATORIO MECANICA NO INVASIVO CON CANULA RAM PROTOCOLO INSTITUCIONAL
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,2 MCG / K / H
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H *DESMONTE PROGRESIVO*
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS *SUSPENDER*
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (2 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV. *SUSPENDER *
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HORAS
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
FUROSEMIDA 10 MG IV CADA 6 HORAS
LEVOMEPROMAZINA 7 MG POR SONDA CADA 8 HORAS *NUEVO* (0.5MG/KG/DIA)
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
INMOVILIZACION TERAPÉUTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE SOLICITA
HEMOGRAMA, TIEMPOS DE COAGULACION, CPK, ELECTROLITOS COMPLETOS Y ACIDO LACTICO 07.03.26

EN PROCESO
CIRUGIA PLASTICA
EN PROCESO LECTURA OFICIAL DE RADIOGRAFIA DE TORAX PORTATIL
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE DES REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 65 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO

GI METABOLICO
--INICIAR SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE MAYOR DE 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO METAS (TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI ESTA FUERA DE METAS)
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR DE 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 1,3

GRACIAS!

2026-03-07 05:50	**PROFESIONAL:** yurherri - YURY NATHALYA HERNANDEZ RINCON	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

NOTA FISIOTERAPIA TURNO MADRUGADA

SE INGRESA CON PREVIO LAVADO DE MANOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN PROTOCOLO INSTITUCIONAL.

PACIENTE FEMENINA DE 10 AÑOS CON DIAGNOSTICOS MEDICOS DE CHOQUE HIPOVOLÉMICO GRADO IV, TRAUMA COMPLEJO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO Y DEMAS DIAGNOSTICOS PREVIAMENTE ANOTADOS, PACIENTE CON SEDOANALGESIA RASS 0, SE ENCUENTRA HEMODINAMICAMENTE SOPORTADA CON VASOPRESINA CON SIGNOS VITALES: FRECUENCIA CARDIACADA 101 LATIDOS POR MINUTO , FRECUENCIA RESPIRATORIA 18RESPIRACIONES POR MINUTO, TENSION ARTERIAL: 111/61 MMHG, SATURANDO 100%. TOLERANDO EXTUBACION PROGRAMADA EL DIA DE HOY.

CONECTADA A VENTILACION MECANICA NO INVASIVA CON INTERFAZ DE CANULA RAM, EN MODO SIMV CON PARAMETROS FR:18/21RPM ; PI: 15; TI:0.85SEG; R I:E: 1:2.9; FIO2:30%; PEEP:5.0CMH2O; VSEN: 1.5L/MIN. CON MECANICA VENTILATORIA PIP: 20 CMH2O; PMEAN: 8.8CMH2O; DENTRO DE LIMITE PROTECTOR; CON CURVAS Y BUCLES ADECUADOS, ESCASA TUBRULENCIA EN ASA ESPIRATORIA, EN EL MOMENTO CON ACOPLE VENTILATORIO, CON ASISTENCIA SIN ASINCRONIA, NO SE OBSERVAN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, TORAX SIMETRICO Y NORMOEXPASIBLE, PATRON RESPIRATORIO ABDOMINAL, SIN SIGNOS DE ESFUERZO INSPIRATORIO, A LA AUSCULTACION MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPO, BUENA EXCURSION RESPIRATORIA, SIN SOBRE AGREGADOS.

OBJETIVOS TERAPEUTICOS

* OXIMETRIAS >92%
* MANTENER ACOPLE VENTILATORIO
* VENTILACION DENTRO DE RANGOS DE PROTECCION PULMONAR
* PREVENIR FORMACION DE TAPONES DE MOCO QUE ALTEREN LA RESISTENCIA DE LA VIA AEREA.

INTERVENCION TERAPEUTICA

* MODIFICACIONES VENTILATORIAS:PROGRESIVAMENTE SE DESMONTAN PARAMETROS DE LA VENTILACION NO INVASIVA, FIO2: 24%; PI: 13 PS: 6; DEMAS IGUALES PARAMETROS.
* DRENAJE POSTURAL, POSICIONAMIENTO EN CAMA A 30°.
* KINESIOLOGIA DE TORAX + AFE COMO TECNICA DE DESOBSTRUCCION BROQUIAL.
* VENTILACION MECANICA DINAMICA, MONITORIA RESPIRATORIA.

SE FINALIZA SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS, SE CONTINUA VIGILANCIA HEMODINAMICA Y RESPIRATORIA.

2026-03-07 06:54	**PROFESIONAL:** annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

REPORTE DE PARACLINICOS

REPORTE DE PARACLINICOS ORDEN DE SERVICIO 202603070100
HEMOGRAMA LEUCOCITOS 6630 HB 9.0 HTO 26.8 N 3510 L 2080 MON 890 EOS 50 BASOFILOS 10 PLAQUETAS 147.000
TIEMPOS DE COAGULACION INR 1.44 TP 14.8 TPT 38.7
CLORO 102 CPK 1311 FOSFORO 3.6 POTASIO 3.0 SODIO 138

ORDEN DE SERVICIO 202603070099
ACIDO LACTICO 0.94 CALCIO 1.17

PACIENTE HOSPITALIZADA EN LA UNIDAD CON DIAGNOSTICOS ANOTADOS.
HEMODINAMIA ESTABLE, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO. EN PROCESO DE DESTETE DE VASOPRESOR, CON TAM EN METAS PARA LA EDAD. DURANTE LA NOCHE PRESENTA EPISODIO DE AGITACIÓN, REQUIRIENDO INCREMENTO DE SEDACIÓN CONSCIENTE, POSTERIOR A LO CUAL PRESENTA DESCENSO TENSIONAL HASTA P5, POR LO QUE SE AJUSTA INFUSIÓN. CON LACTATO DEPURADO SE DECIDE SUSPENDER VASOPRESINA; SIN EMBARGO, ANTE NUEVAS CIFRAS TENSIONALES VENTILACION MECANICA NO INVASIVA CON CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OPTIFLOW PARAMETROS BASALES PERMITIENDO DESCENSO DE PARAMETROS CON OXIMETRIAS EN METAS EN PLAN DE DESTETE PROGRESIVO.
CONTINUA EN AYUNO EN PROCESO LLAMADO DE CIRUGIA PARA PROCEDIMIENTO DE ESCARECTOMIA POR CIRUGIA PLASTICA, SIN EVENTOS EMETICOS.
GASTO URINARIO 3.4CC/KG/H EN 24 HORAS EN METAS CON HIPOKALEMIA LEVE RESTO DE ELECTROLITOS EN METAS CURSA CON RABDOMIOLISIS, CPK EN DESCENSO PROGRESIVO.
HEMATOLOGICO SIN ESTIGMAS DE SANGRADO ACTIVO, REQUIRIO TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS CON HEMOGLOBINA DE CONTROL EN METAS. PLAQUETAS CON DISCRETA TROMBOCITOPENIA CON INR LIMITROFE CONTINUA VITAMINA K.
NEUROLOGICO ALERTA, SIN CRISIS. LOGRA CONCILIAR EL SUEÑO, CONTINUA SEDACION CONSCIENTE Y MANEJO CON ANTIPSICOTICO.

PACIENTE CONTINUA EN CONDICION CRITICA, ALTO RIESGO DE DESCOMPENSACION HEMODINAMCIA.

2026-03-07 13:57	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

EVOLUCION UCIP-DIA
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774
ENTIDAD:SAVIA SALUD
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO : 04/03/2026

*ESTANCIA: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
*CRITERIO DE ESTANCIA: SOPORTE VASOPRESOR, SOPORTE VENTILATORIO MECANICO. MONITORIA NEUROLÓGICA NIRS. MONITORIA HEMODINÁMICA STARLING.

DIAGNOSTICOS:
1. ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).

1.1. POLITRAUMATISMO
1.2. TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3. RABDOMIOLISIS TRAUMATICA
2. TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1. FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2. CONTUSIÓN MIOCÁRDICA
2.3. CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4. MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)
6. CHOQUE MIXTO DISTRIBUTIVO E HIPOVOLÉMICO.
7. FALLA RESPIRATORIA TIPO-1

*INFUSIONES:
-DEXMEDETOMIDINA A 0.3 MCG/KG/H, IV.
-VASOPRESINA A 0.03 UD/KG/H, IV.

*SUBJETIVO: YESHIA SE VE TRANQUILA, ALERTABLE. PERMANECE AFEBRIL. SOPORTADA CON VENTILACION NO INVASIVA.

*OBJETIVO:
FC: 107/MIN. TA: 93/54/67. FR: 22/MIN. SO2: 98%. T: 36.2. GLUCOMETRIA: 92 MG/DL.
CRANEO Y CARA: NORMOCEFALO. HERIDA FRONTAL IZQUIERDA CUBIERTA CON GASAS Y MICROPORE.
NEUROLOGICO: SEDACION CONSCIENTE, RASS EN 0. ALERTABLE. PUPILAS A 3 MM REACTIVAS. SIN FOCALIZACION NI SIGNOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA. TONO MUSCULAR NORMAL.
ORL: SIN ALETEO NASAL, QUEJIDO NI ESTRIDOR. BOCA HUMEDA.
CUELLO: LLENADO YUGULAR NORMAL. SIN MASAS.
TORAX: EXPANSIBILIDAD SIMETRICA, SIN RETRACCIONES.
PULMONES: MURMULLO VESICULAR NORMAL, SIN RUIDOS AGREGADOS.
VNI EN MODO SIMV-PC CON PP: 18, PS: 6, PM: 8, PEEP: 5, FR: 18/MIN, FIO2: 24%
CARDIOVASCULAR: TAQUICARDIA SINUSAL, SIN SOPLOS, PULSOS NORMALES, LL. CAPILAR 2S. NORMOTENSA. SIN GRADIENTE TERMICO.
ABDOMEN: PERISTALTISMO NORMAL. BLANDO, INDOLORO. SIN DISTENSION, ASCITIS, MASAS NI MEGLIAS.
RENAL: HIDRATADA, EUVOLEMICA, SONDA VESICAL DRENANDO ORINA CLARA. GU-24H: 3.9 CC/KG/H. BH-24H: -1917.
METABOLICO: TOLERA LA NUTRICION ENTERAL. EUGLUCEMICA.
PH: 7.43, HCO3: 22.3. PaCO2: 32.1, PvCO2: 37.1. SVO2: 78%. LACTATO: 0.99. DELTA CO2: 5. REO: 21%. PAFI: 398.
HEMATOLOGICO: SIN SANGRADO ACTIVO NI SIGNOS DE COAGULOPATIA.
INMUNOLOGICO: RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA ACTIVADA.
OSTEOMUSCULAR: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CUBIERTO CON VENDAJE ELASTICO, LLENADO CAPILAR DISTAL IPSLATERAL EN 2 S, PULSOS NO VALORABLES POR PRESENCIA DE VENDAJE. .
PIEL: ESPALDA CUBIERTA CON COMPRESAS ADHERIDAS CON MICROPORE.

*ANALISIS: YESHIA ESTA ESTABLE. CON SEDACION CONSCIENTE, ALERTABLE, MODULANDO EL DOLOR. AFEBRIL, HIDRATADA, EUVOLEMICA. SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, SOPORTADA CON VENTILACION MECANICA NO INVASIVA. SO2 NORMAL. CON GASTO CARDIACO Y PERFUSION SISTEMICA NORMALES. SIN ABDOMEN AGUDO. FUNCION RENAL CONSERVADA. POLIURICA CON BALANCE HIDRICO NEGATIVO. SIN COAGULOPATIA. RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA EN PROCESO DE REGULACION. YESHIA ESTA EN CONDICION CLINICA CRITICA, EN FASE DE ESTABILIZACION, CURSANDO CON CHOQUE DISTRIBUTIVO COMPENSADO. SIN COAGULOPATIA DESCOMPENSADA, SIGNOS DE COMPRESION MEDULAR NI DE HIPOPERFUSION DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. GASES ARTERIOVENOSOS MUESTRAN EQULIBRIO ACIDOBASE CON PERFUSION SISTEMICA Y EXTRACCION DE OXIGENO NORMALES, SIN TRASTORNO DE LA OXIGENACION. CONTINUAMOS CON SEDOANALGESIA, SOPORTE VASOPRESOR, PROFILAXIS PARA HEMORRAGIA DIGESTIVA, SOPORTE DIURETICO Y ANTIBIOTICOTERAPIA. LE EXPLICO A LA MADRE EL ESTADO ACTUAL DE SALUD DE LA NIÑA, RIESGOS Y PLAN TERAPEUTICO.

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20° Y 30°
NUTRICION ENTERAL A 10 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. (META: 30 CC/H). MANTENER SUSPENDIDA HASTA NUEVA ORDEN.
LACTATO DE RINGER PARA COMPLETAR APORTE HIDRICO IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 MCG/KG/H. A 0,3 MCG/KG/H, IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. 1 CC = 0,1 UD/KG/H. INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-3/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/6H, IV.
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
SOPORTE VENTILATORIO MECANICO NO INVASIVO CON CANULA RAM.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA

MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAPÉUTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
EN PROCESO: CIRUGIA PLASTICA. REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS. ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO (07/03/2026).

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

JOSE GERMAN NARVAEZ B.
PEDIATRA INTENSIVISTA. RM 52305/2000 - 76319436

2026-03-07 14:39	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

NOTA MEDICA.
YESHIA SE ESTA A PESAR DE LA SEDOANALGESIA QUE ACTUALMENTE RECIBE SE ESTA QUEJANDO DE MUCHO DOLOR (EVA: 9-10).
PLAN: FENTANIL A 0.5 MCG/KG/H. IV.

2026-03-07 14:45	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

NOTA MEDICA.
SE TRASLADA A QUIROFANO PARA SER INTERVENIDA POR PARTE DE CIRUGIA PLASTICA.
FC: 116/MIN. TA: 104/62/76. FR: 22/MIN. SO2: 98%. T: 36 °C.
ALERTABLE, SIN FOCALIZACION
HEMODINAMICAMENTE ESTABLE
SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA.
CON SOPORTE DE OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
SOPORTADA CON VASOPRESINA.

2026-03-07 16:18	**PROFESIONAL:** danzapna - DANY MATILDE ZAPATA NAVARRO	**ESPECIALIDAD:** ANESTESIOLOGIA

ANESTESIOLOGIA****
VALORACIÓN PREANESTESICA
YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
PT 7527774

DIAGNOSTICOS:
1. ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1. POLITRAUMATISMO
1.2. TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3. RABDOMIOLISIS TRAUMATICA
2. TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1. FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2. CONTUSIÓN MIOCÁRDICA
2.3. CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4. MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y

SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)
6. CHOQUE MIXTO DISTRIBUTIVO E HIPOVOLÉMICO.
7. FALLA RESPIRATORIA TIPO-1

PROGRAMADO PARA LAVADO + ESCARECTOMIA + DESBRIDAMIENTO DE QUEMADURAS POR FRICCION

NTECEDENTES PERSONALES:
** PATOLOGICOS: NIEGA
** QUIRURGICOS: LAS DESCRITAS EN DIAGNOSTICOS BAJO ANESTESIA GENERAL
** ALERGICOS: NIEGA
** TOXICOS: NIEGA

O/ PACIENTE EN CAMILLA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES CON TA:111/75 MMHG, FC: 88 LPM, FR: 14 RPM, SAO2: 98%, FIO2 21
CONCIENTE OREINTADO, GLASGOW 15/15
APERTURA BUCAL MAYOR DE 3.5 CM, MALLAMPATI GII
CUELLO MOVIL NO HAY MASA
TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE
CUELLO MOVIL NO MASAS

A/ASA II, CHOQUE
CUMPLE AYUNO
NIEGA DISNEA O DOLOR TORACICO

SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA ANESTESICA A FAMILIAR, PROBABLES COOMPLICACIONES REALIZAR Y SUS RIESGOS, REFIERE ENTENDER.

P/1. PROGRAMAR
2.NADA VIA ORAL.

2026-03-07 16:48	**PROFESIONAL:** carburen - CAROLINA BURBANO ENRIQUEZ	**ESPECIALIDAD:** CIRUGIA PLASTICA

PACIENTE CON MULTIPLES TRAUMATISMOS DESCRITOS A CONTINUACION:

-QUEMADURA POR FRICCION GRADO IIB - III EN REGION DORSAL Y LUMBAR QUE COMPROMETE UN 18%SCT
-QUEMADURA POR FRICCION GRADO IIB EN HOMBRO IZQUIERDO QUE COMPROMETE UN 2%SCT
-QUEMADURA POR FRICCION GRADO IIA EN REGION MALAR IZQ Y DERECHA QUE COMPROMETE UN 2%SCT
-HERIDA DE 4 CM EN REGIÓN FRONTAL IZQUIERDA CON AVULSIÓN DE TEJIDOS PROFUNDOS, PÉRDIDA DE TEJIDOS Y DEFECTO DE COBERTURA, EXPOSICIÓN MUSCULAR, SIN SIGNOS DE INFECCION

PLAN: SE PASA A CIRUGÍA PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TRAUMATISMOS. SE HABLA Y EXPLICA TODO AL FAMILIAR QUIEN ENTIENDE, ACEPTA Y FIRMA.

2026-03-07 16:58	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

ORDEN 202603070122
GASES VENOSOS
pH 7.399
PCO2 37.1 mmHg
pO2 35.8 mmol/L
HCO3act 22.4 mmol/L
BE(B) -2.1 mmol/L
SO2 70.8 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2, DELTA DE CO2 5 MMHG NORMAL

ORDEN 202603070121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 08:44
GASES ARTERIALES
pH 7.436
PCO2 32.1 mmHg
pO2 78.9 mmHG
HCO3act 21.1 mmol/L
BE(B) -2.6 mmol/L
SO2 95.6 %
pO2/FiO2 3.29 mmHg
FIO2 24.0 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, HIPOCAPNIA LEVE, NORMOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR.

ORDEN 202603070100
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:54
CLORO 102.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1311.0 U/L ELEVADA, PERO EN DESCENSO RESPECTO A LA PREVIA.
FOSFORO 3.60 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.50 mg/dl HIPOMAGNESEMIA LEVE
POTASIO 3.00 mmol/L HIPOCALEMIA LEVE, SE INICIA REPOSICION CON KATROL 15 MEQ EN INFUSION DE LEV.
SODIO 138.0 mmol/L NORMAL

INR 1.44
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.7 seg
INR EN LIMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD, PT Y PTT LIGERAMENTE PROLONADOS.

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 86.0 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 33.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.2 um3
RDW CV 14.4 %
MPV 9.2 um3
NEUTROFILOS Abs 3.51
LINFOCITOS Abs 2.08
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.05
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 53.0 %
LINFOCITOS % 31.3 %
MONOCITOS % 13.4 %
EOSINOFILOS % 0.8 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.8 %
HEMOGLOBINA 9.0 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 6.63 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 147 X10³/mm³
TROMBOCITOPENIA LEVE, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL

ORDEN 202603070099
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:51
ACIDO LACTICO 0.94 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.17 mmol/L NORMAL

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1

PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52

RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----

pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS

RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-07 17:00	**PROFESIONAL:** carburen - CAROLINA BURBANO ENRIQUEZ	**ESPECIALIDAD:** CIRUGIA PLASTICA

PACIENTE VUELVE A LA UCI, CONTINUA CON MISMO MANEJO Y MEDIDAS INSTAURADAS
REQUIERE NUEVO LAVADO QUIRURGICO DE LA ESPALDA EN 2-3 DIAS. SE SOLICITA TENER PARA LA CURACION AQUACEL, GRACIAS

FAVOR NO MOJAR LAS CURACIONES DE LA ESPALDA, EL RESTO SE PUEDE CAMBIAR Y CURAR POR ENFERMERIA
RETIRO DE PUNTOS DE LA CARA EN 8 DIAS

2026-03-07 17:27	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

NOTA MEDICA DE REINGRESO.
YESHIA REINGRESA EN POSTQUIRURGICO INMEDIATO DE CIRUGIA PLASTICA.
FC: 138/MIN. TA: 134/80. FR: 24/MIN. SO2: 96% CON FIO2 DEL 24%. T: 35.6°C.
BAJO EFECTOS RESIDULAES DE ANESTESIA GENERAL.
EXTUBADA, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA.
HEMODINAMICAMENTE ESTABLE.
PLAN: CONTINUA CON EL MANEJO INSTAURADO.

2026-03-07 20:29	**PROFESIONAL:** marmulta - MARIA GISELL MURILLO TAMAYO	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

TERAPIA RESPIRATORIA NOCHE

PACIENTE YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO DE GENERO FEMENINO DE 10 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICOS MEDICOS ANOTADOS PREVIAMENTE EN LA HISTORIA CLINICA, ENCUENTRO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES DE SALUD EN GENERAL, HEMODINAMICAMENTE INESTABLE, SOPORTADA CON VASOPRESINA, CON SEDACION CONSCIENTE, DAD POR PRECEDEX EN EL SISTEMA NEUROLOGICO SE ENCUENTRA, SIN SIGNOS DE FOCALIZACIÓN NEUROLÓGICA, EN EL SISTEMA CARDIVASCULAR SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES SIGNOS VITALES: TA 100/65, FC 112, FR 21, EN EL SISTEMA PULMONAR SE ENCUENTRA CON CANULA NASAL SIMPLE FIO2: 24%, SATURANDO ENTRE 97-99 A LA AUSCULTACION SE ENCUENTRA MRMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, SIN RUIDOS SOBREAGREGADOS, TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE, PATRON RESPIRATORIO RITMICO TORACOABDOMINAL SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

OBJETIVOS:
FAVORECER LA REEXPANSION PULMONAR.
MITIGAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA

--MONITORIA RESPIRATORIA
--POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER A 45°
--FISIOTERAPIA RESPIRARTORIA CON MOVILIZACIÓN DE REJA COSTAL
--ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO LENTO COMO TECNICA DE DESOBTRUCCION BRONQUIAL

PACIENTE TOLERA INTERVENCION, QUEDA ESTABLE DENTRO DE SU CUADRO CLÍNICO.

2026-03-07 22:56	**PROFESIONAL:** diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO - PEDIATRIA - NOCHE
DRA DIANA DONNEYS (MD. ESPECIALISTA)

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774
ENTIDAD:SAVIA SALUD
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO : 04/03/2026

DIAGNOSTICOS:
1.ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1 POLITRAUMATISMO
1.2 TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3 RABDOMIOLISIS
2.TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1 FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2 CONTUSIÓN MIOCÁRDICA EN SEGUIMIENTO
2.3 CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4 MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
2.5 QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIB - III EN REGION DORSAL Y LUMBAR QUE COMPROMETE UN 18%SCT -QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIB EN HOMBRO IZQUIERDO QUE COMPROMETE UN 2%SCT -QUEMADURA POR FRICCION GRADO IIA EN REGION MALAR IZQ Y DERECHA QUE COMPROMETE UN 2%SCT
2.6 POP DE LAVADO + DECRIBDAMIENTO 07/03/2026 DRA BURBANO
2.5 RIESGO DE LESIÓN DE GRANDES VASOS
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POP ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)
6. CHOQUE MIXTO HIPOVOLÉMICO GRADO IV EN RESOLUCIÓN
7. FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 SECUNDARIA CHOQUE HIPOVOLÉMICO RESUELTA

CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
.- SOPORTE VASOPRESOR
.- MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INVASIVA

.- MONITORIZACIÓN NEUROLÓGICA NIRS
.- REQUERIMIENTO HEMODINÁMICO TIPO STARLING

EVENTOS
*DESTETE DE VASOPRESOR
*COAGULOPATÍA POR TRAUMA
*CHOQUE HIPOVOLÉMICO RESPONDEDOR A CRISTALOIDES Y HEMODERIVADOS

MONITORIA
.- GASTO CARDIACO NO INVASIVO: IVS: 26- IGC: 2.6
.- MONITORIA NIRS : L: 81 -SOMATICO DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO 95

SOPORTES:
- OXIGENO POR CANULA RAM FiO2 30%

INFUSIONES:
- VASOPRESINA 0.01 UI/KG/H
- DEXMEDETOMIDINA 0.2 UG/KG/ H
- FENTANIL 0.5 MG/KG/HORA

TRASFUSIONES:
2 UNIDADES DE GLÓBULOS ROJOS + 2 DE PLASMA 04/03/2026
1 UNIDAD DE GLÓBULOS ROJOS +1 PLASMA 05/03/2026
06/ 03/26 SE INDICA GRE 1 UNIDAD

* INVASIONES
.- INTUBACIÓN TRAQUEAL TOT 6,5 CON NEUMOTAPÓNADOR FIJO 21 CM 04/03/2026 FF 06/03/2026
.- SONDA VESICAL 05/03/2026
.- CATÉTER VENOSO CENTRAL SUBCLAVIO DERECHO - 05/03/2026 SALAS DE CIRUGÍA
.- LINEA ARTERIAL FEMORAL DERECHA - 05/03/2026 UCIPED
.- CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO MSD - 04/03/2026
.- CATETER VENOSO PERIFERICO MSI - 04/03/2023

EXAMEN FÍSICO:
SE VALORA A PACIENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 100/56 MMHG TAM: 71 MMHG
FRECUENCIA CARDIACA: 102 L/MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 20 /MIN
SO2: 100 % CON CÁNULA NASAL FiO2 24 %
TEMPERATURA: 36.6 °C AFEBRIL EN 12 HORAS
TALLA 152 CM
BALANCE HÍDRICO EN 12 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 769 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 1350 CC
BALANCE DEL DIA - 580 CC
BALNCE ACUMULADO : +3666
GU: 2.8 CC/KG/H
METABÓLICO: SIN NET, GLUCOMETRIAS: 102-96 MG/DL, SIN DEPOSICIÓN EN LAS ULTIMAS 12 HORAS

.- NORMOCONFIGURADA, EDEMA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO CON HERIDA CUBIERTA SIN SANGRADO ACTIVO, PUPILAS 3 MM REACTIVAS A LA LUZ. DOLOR A LA PALPACIÓN. QUEMADURA POR FRICCIÓN, EN REGION FRONTAL IZQUIERDA.
.- HEMODINÁMICA:TAQUICARDIA CON MEJORIA DE CIFRA TENSIONALES Y FRECUENCIAS CARDIACAS POSTERIOR A INCIO DE VASOPRESOR A DOSIS BAJOS , ÚLTIMOS GASES VENOSOS CON SATURACIÓN VENOSA CENTRAL ALTA, ÁCIDO LACTICO DEPURADO
.- TÓRAX : SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, AMBOS CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS NO RUIDOS SOBREAGREGADOS, SOPORTE POR CÁNULA NASAL SAFI 416 SIN TRASTORNO DE OXIGENAC
.- ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO IMPRESIONA DOLOR NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. SE INCIARA ALIMENTACIÓN ENTERAL
.- RENAL: BUEN RITMO DIURÉTICO. CPK 1311 EN PLAN DE HIPERHIDRATACIÓN. ELECTROLITOS CON HIPOKALEMIA LEVE EN REPOSICIÓN POR LEV MANTENIMIENTO
.- HEMATOLÓGICO: SIN ESTIGMAS DE SANGRADO ACTIVO.
.-OSTEOMUSCULAR: MII CON VENDAJE ELÁSTICO, VAC FUNCIONAL A SUCCIÓN. PERFUSION DISTAL CONSERVADA.
.- NEUROLÓGICO:GLASGOW 15/15, MEJOR MODULACIÓN DEL DOLOR, INFUSIÓN DE FENTANY. PUPILAS ISOCÓRICAS Y REACTIVAS
.- PIEL : QUEMADURAS EN DORSOS Y CARA CUBIERTO POR APOSITOS

-ANALISIS:
PACIENTE DE 10 AÑOS, CON POLITRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO CON LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
*HEMODINÁMICAS: FRECUENCIA CARDIACA ELEVADAS,GASTO POR MONITOREO STARLING LIMITROFES, TENSIONES ARTERIALES EN LIMITE INFERIOR, SE INDICO INCIO DE VASOPRESINA POSTERIOR A ESTO CON MEJORIA DE VARIABLE S MACRO HEMODINÁMICAS, LLAMA A TENSIÓN STALING AUN CON GASTOS LIMÍTROFES CON CLÍNICA DE CHOQUE VASODILATADOR ALTA SOSPECHA DE CHOQUE NEUROGENICO. POR LO QUE SE INDICA TOMAD E PARACLÍNICOS DE CONTROL. TROPONINAS NEGATIVAS, ECOCARDIOGRAMA SIN DATOS DE CONTUSIÓN MIOCÁRDICA.
*RESPIRATORIO: AMBOS CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS NO RUIDOS SOBREAGREGADOS, TAC DE INGRESO CON DENTRO DE LIMITES DE NORMALIDAD, RADIOGRAFÍA DE CONTROL POST EXTUBACIÓN DENTRO DE LIMITES DE NORMALIDAD. SE ENCONTRABA EN MANEJO CON VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA ADECUADA EVOLUCIÓN, SE INDICA RETIRO PAULATINO DE ESTE AHORA CON CÁNULA NASAL SAFI: 416 SIN TRASTORNO DE OXIGENACIÓN
* METABÓLICO: SE INICIA VIA ENTERAL POR SONDA NASOGASTRICA VIGILANDO TOLERANCIA.
*RENAL: ADECUADO RITMO DIURÉTICO MANEJO CON FUROSEMIDA SE AJUSTA DOSIS ,EN PLAN DE BALANCES NEUTROS, EN FASE DE DES REANIACION DE CHOQUE HIPOVOLÉMICO. ELECTROLITOS CON HIPOKALEMIA EN MANEJO CON LEV DE MANTENIMIENTO RESTO NORMAL . CPK ELEVADA EN VIGILANCIA SIN COMPROMISO EN FUNCION RENAL
* NEUROLÓGICO: GLASGOW 15/15, DURANTE LA TARDE EVA 8/10 POR LO QUE SE INCIO INFUSION DE FENTANYL POSTERIOR CON

DETERIOR HEMODINÁMICO, POR LO QUE SE SUSPENDE ESTE Y SE INCIA MANEJO MULTIMODAL PARA EL DOLOR CON KETAMINA VIGILANDO CIFRAS TENSIONA Y CONTROL DEL DOLOR. NO SIGNOS DE FOCALIZACIÓN
*PIEL: PACIENTE CON QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIB - III EN REGION DORSAL Y LUMBAR QUE COMPROMETE UN 18%SCT -QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIB EN HOMBRO IZQUIERDO QUE COMPROMETE UN 2%SCT -QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIA EN REGION MALAR IZQ Y DERECHA QUE COMPROMETE UN 2%SCT. AHORA EN SU POP INMEDIATO DE LAVADO + DESCUBRIMIENTO . CON INDICACIÓN POR CIRUGÍA PLÁSTICA DE NUEVO LAVADO EN 2-3 DIAS.
*OSTEOMUSCULAR: NE PROCESO REALIZACIÓN DE RNM PARA EVALUAR FRACTURA EN L4 Y TRAUMA RAQUIMEDULAR. EN PROCESO ARTERIOGRAFÍA PARA EVALUAR VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD DADA LA SEVERIDAD DEL TRAUMA DE TEJIDOS BLANDOS EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. SEGUIMIENTO POR ORTOPEDIA INFANTIL SE ENCUENTRA EN PROCESO TOMA DE RX DE RODILLA Y TAC DE RODILLA PARA EVALUAR LESIÓN EN CÓNDILO FEMORAL EXTERNO Y PLATILLO TIBIAL LATERAL. POR AHORA CON MEJOR MODULACIÓN DEL DOLOR

PACIENTE EN CONDICIÓN CRITICA ALTO RIESGO DE COMPLICACIONES Y PÉRDIDA DE AUTORIDAD.EN PROCESO DE REMISIÓN POR PARTE DE SU EPS. SE EXPLICA A LA MADRE.

PESO: 40 KG

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
OXIGENO POR CANULA NASAL
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20° Y 30°
REINICIAR NUTRICION ENTERAL A 10 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. REALIZAR INCREMENTOS SEGUN LO ESTIPULADO POR NUTRICIONSTA (META: 55 CC/H).
LACTATO DE RINGER 1000 CC + CLORURO DE POTASIO 7.5 CC, PARA COMPLETAR APORTE HIDRICO IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9% 1 CC = 0,1 MCG/KG/H. A 0,3 MCG/KG/H, IV.
FENTANILO 1000 MCG/100 C SSN0.9%, PASAR A 0.5 MCG/KG/H, IV. ** SUSPENDER*
KETAMINA 500 MG EN 100 CC (1CC/HORA =2 MCG/KG/MIN) PASAR A 1-4 MCG/KG/MIN *** NUEVO ***
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. 1 CC = 0,1 UD/KG/H. INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-3/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. *** CAMBIO **
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAPÉUTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO:
CIRUGIA PLASTICA. REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO (07/03/2026).
PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 3 DIAS
TAC DE RODILLA Y RX DE RODILLA

GRACIAS!

2026-03-08 05:40	**PROFESIONAL:** diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

REPORTE DE PARACLINICOS

ORDEN: 202603080040
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:44
ACIDO LACTICO 1.12 DEPURADO
CALCIO IONICO 1.13
PH: 7.32, PCO2: 35, CO2: 47.7, HCO3: 17.9M SO2: 79.8, GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICA , SATURACION VENOSA CENTRAL ALTA , CHOQUE VASODILATADO EN MANEJO CON VASOPRESINA.

#ORDEN 202603080039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:43
ELECTROLIOS EN RANGO DE NORMALIDAD
CLORO 104.0
FOSFORO 5.50
POTASIO 3.60
SODIO 140.0

HEMGORAMA SIN LEUCOCITOISS NI NEUTROFIA, HB ESTABLE POSTERIOR A PROCEDIMIENTO, PLAQUETAS EN RANGO DE SEGURIDAD.
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.15
MCV 86.4
MCH 29.0
MCHC 33.5
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9
RDW SD 45.1
RDW CV 14.3
MPV 9.1
NEUTROFILOS Abs 4.19

LINFOCITOS Abs 0.81
MONOCITOS Abs 0.28
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 78.4
LINFOCITOS % 15.2
MONOCITOS % 5.3
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 27.2
HEMOGLOBINA 9.1
RECUENTO DE LEUCOCITOS 5.34
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 177

ORDEN 202603070122
GASES VENOSOS
pH 7.399
PCO2 37.1 mmHg
pO2 35.8 mmol/L
HCO3act 22.4 mmol/L
BE(B) -2.1 mmol/L
SO2 70.8 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2, DELTA DE CO2 5 MMHG NORMAL

ORDEN 202603070121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 08:44
GASES ARTERIALES
pH 7.436
PCO2 32.1 mmHg
pO2 78.9 mmHG
HCO3act 21.1 mmol/L
BE(B) -2.6 mmol/L
SO2 95.6 %
pO2/FiO2 3.29 mmHg
FIO2 24.0 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, HIPOCAPNIA LEVE, NORMOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR.

ORDEN 202603070100
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:54
CLORO 102.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1311.0 U/L ELEVADA, PERO EN DESCENSO RESPECTO A LA PREVIA.
FOSFORO 3.60 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.50 mg/dl HIPOMAGNESEMIA LEVE
POTASIO 3.00 mmol/L HIPOCALEMIA LEVE, SE INICIA REPOSICION CON KATROL 15 MEQ EN INFUSION DE LEV.
SODIO 138.0 mmol/L NORMAL

INR 1.44
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.7 seg
INR EN LIMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD, PT Y PTT LIGERAMENTE PROLONADOS.

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 86.0 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 33.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.2 um3
RDW CV 14.4 %
MPV 9.2 um3
NEUTROFILOS Abs 3.51
LINFOCITOS Abs 2.08
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.05
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 53.0 %
LINFOCITOS % 31.3 %
MONOCITOS % 13.4 %
EOSINOFILOS % 0.8 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.8 %
HEMOGLOBINA 9.0 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 6.63 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 147 X10³/mm³
TROMBOCITOPENIA LEVE, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL

ORDEN 202603070099
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:51
ACIDO LACTICO 0.94 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.17 mmol/L NORMAL

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3

MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 $X10^3/mm^3$
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 $X10^3/mm^3$
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8

pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %

FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L

NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

TIPO DE MUESTRA Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h Pendiente
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19

CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-08 09:17	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

EVOLUCION UCIP-DIA
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774
ENTIDAD:SAVIA SALUD
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO : 04/03/2026

*ESTANCIA: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
*CRITERIO DE ESTANCIA: SOPORTE VASOPRESOR, SOPORTE VENTILATORIO MECANICO. MONITORIA NEUROLÓGICA NIRS. MONITORIA HEMODINÁMICA STARLING.

DIAGNOSTICOS:
1. ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1. POLITRAUMATISMO
1.2. TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3. RABDOMIOLISIS TRAUMATICA
2. TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1. FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2. CONTUSIÓN MIOCÁRDICA
2.3. CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4. MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)

6. CHOQUE MIXTO DISTRIBUTIVO E HIPOVOLÉMICO.
7. FALLA RESPIRATORIA TIPO-1

*INFUSIONES:
-DEXMEDETOMIDINA A 0.2 MCG/KG/H, IV.
-KETAMINA A 9 MCG/KG/MIN, IV.
-VASOPRESINA A 0.02 UD/KG/H, IV.

*SUBJETIVO: YESHIA SE VE TRANQUILA, ALERTABLE. PERMANECE AFEBRIL Y SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA.

*OBJETIVO:
FC: 94/MIN. TA: 107/61/76. FR: 20/MIN. SO2: 99% CON FIO2 DEL 24%. T: 36.2. GLUCOMETRIA: 128 MG/DL.
CRANEO Y CARA: NORMOCEFALO. HERIDA FRONTAL IZQUIERDA CUBIERTA CON GASAS Y MICROPORE.
NEUROLOGICO: SEDADA, RASS EN 0. ALERTABLE. PUPILAS A 3 MM REACTIVAS. SIN FOCALIZACION NI SIGNOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA. TONO MUSCULAR NORMAL.
ORL: SIN ALETEO NASAL, QUEJIDO NI ESTRIDOR. BOCA HUMEDA.
CUELLO: LLENADO YUGULAR NORMAL. SIN MASAS.
TORAX: EXPANSIBILIDAD SIMETRICA, SIN RETRACCIONES. CATETER VENOSO CENTRAL SUBCLAVIO DERECHO SANO.
PULMONES: MURMULLO VESICULAR NORMAL, SIN RUIDOS AGREGADOS.
CARDIOVASCULAR: EUCARDICA, EN SINUSAL, SIN SOPLOS, PULSOS NORMALES, LL. CAPILAR 2S. NORMOTENSA. SIN GRADIENTE TERMICO. IGC: 2.6.
ABDOMEN: PERISTALTISMO NORMAL. BLANDO, INDOLORO. SIN DISTENSION, ASCITIS, MASAS NI MEGLIAS.
RENAL: HIDRATADA, EUVOLEMICA, SONDA VESICAL DRENANDO ORINA CLARA. GU-24H: 3.4 CC/KG/H. BH-24H: -1686.
METABOLICO: TOLERA LA NUTRICION ENTERAL. EUGLUCEMICA.
HEMATOLOGICO: SIN SANGRADO ACTIVO NI SIGNOS DE COAGULOPATIA.
INMUNOLOGICO: RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA ACTIVADA.
OSTEOMUSCULAR: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CUBIERTO CON VENDAJE ELASTICO, LLENADO CAPILAR DISTAL IPSLATERAL EN 2 S, PULSOS NO VALORABLES POR PRESENCIA DE VENDAJE. CON OLOR FETIDO Y PRESENCIA DE MATERIAL NEGRO EN VENDAJES Y SABANA.
PIEL: ESPALDA CUBIERTA CON COMPRESAS ADHERIDAS CON MICROPORE.

*ANALISIS: YESHIA CONTINUA EN ESTADO CRITICO. CON SEDACION CONSCIENTE, MODULANDO EL DOLOR. AFEBRIL, HIDRATADA, EUVOLEMICA. SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA, SO2 NORMAL CON OXIGENOTERAPIA POR SISTEMA DE BAJO FLUJO. GASTO CARDIACO Y PERFUSION SISTEMICA CONSERVADOS. SIN ABDOMEN AGUDO. FUNCION RENAL EN RIESGO. POLIURICA CON BALANCE HIDRICO NEGATIVO. SIN COAGULOPATIA. RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA ACTIVADA. YESHIA ESTA EN CONDICION CLINICA CRITICA, CURSANDO CON CHOQUE DISTRIBUTIVO. SIN COAGULOPATIA, COMPRESION MEDULAR NI HIPOPERFUSION DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. PREOCUPA EL OLOR FETIDO QUE EMANA DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. POR AHORA CONTINUAMOS CON EL MANEJO MEDICO INSTARUADO. SOLICITO HEMOCULTIVOS PERIFERICO Y CENTRAL Y PROCALCITONINA PARA DEFINIR PERTINENCIA DE ESCALONAMIENTO ANTIBIOTICO. LE EXPLICO A LA MADRE EL ESTADO ACTUAL DE SALUD DE LA NIÑA, RIESGOS Y PLAN TERAPEUTICO.

LABORATORIOS DEL 08/03/2026 (1:43 H).
LEUCOCITOS: 5.340, N: 78.4%, L: 15.2%. HGB: 9.1, PLT: 177.000. (TENDENCIA A LA LEUCOPENIA, ANEMIA LEVE QUE NO AMERITA CORRECCION AGUDA, PLAQUETAS NORMALES).
SODIO: 140 (NORMAL). POTASIO: 3.6 (NORMAL), FOSFORO: 5.5 (NORMAL). CLORO: 104 (NORMAL). CALCIO IONICO: 1.13 (NORMAL).
GASES VENOSOS: PH: 7.32, PCO2: 35, PO2: 47.7, HCO3: 17.9. SO2: 79.8%. (ACIDOSIS METABOLICA, EXTRACCION DE OXIGENO NORMAL).
ACIDO LACTICO: 1.12 (NORMAL).

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20° Y 30°
NUTRICION ENTERAL A 20 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. REALIZAR INCREMENTOS SEGUN LO ESTIPULADO POR NUTRICIONSTA (META: 55 CC/H).
LACTATO DE RINGER 1000 CC + CLORURO DE POTASIO 7.5 CC, PARA COMPLETAR APORTE HIDRICO IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,3 MCG/KG/H, IV.
KETAMINA 500 MG/100 CC SN0.9% (1 CC/H=2 MCG/KG/MIN) PASAR A 3-10 MCG/KG/MIN. IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-4/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV.
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAPÉUTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
REALIZAR PROCALCITONINA Y HEMOCULTIVOS PERIFERICO Y CENTRAL.
EN PROCESO: REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS. ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 2 DIAS.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA

--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

JOSE GERMAN NARVAEZ B.
PEDIATRA INTENSIVISTA. RM 52305/2000 - 76319436

2026-03-08 11:19	**PROFESIONAL:** juapraoj - JUAN SEBASTIAN PRADO OJEDA	**ESPECIALIDAD:** ORTOPEDIA PEDIATRICA

**PACIENTE QUE SUFRIO POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, DONDE SUFRE TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9, DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL, AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA, POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026), POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026). POR LO ANTEIROR SE SOLICITA AHORA NUEVA INTERVENCION DE LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO MAS CAMBIOS TERAPIA VAC COMO URGENCIA VITAL.

2026-03-08 14:42	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

REPORTE DE LABORATORIO.
ORDEN 202603080168
FECHA: 08/03/2026-12:02 H
PROCALCITONINA: 1.88 (ELEVADA DISCRETAMENTE).
PLAN: POR AHORA CONTINUAR CON AMPICILINA SULBACTAM.

2026-03-08 16:15	**PROFESIONAL:** marruino - MARIA CAMILA RUIZ NOGUERA	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA TARDE
TERAPIA RESPIRATORIA
YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO

SE INGRESA AL CUBÍCULO SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y EL PREVIO LAVADO DE MANOS SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL. PACIENTE DE SEXO FEMENINO DE 10 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ANOTADOS PREVIAMENTE EN LA HISTORIA CLÍNICA

A LA REVISIÓN POR SISTEMAS

*SISTEMA NEUROLÓGICO: PACIENTE SIN SEDOANALGESIA, CON UN ESTADO NEUROLÓGICO CON UNA PUNTUACIÓN DE 15/15 SEGÚN ESCALA GLASGOW. ÁLGIDA, COLABORADORA
*SISTEMA CARDIOVASCULAR PULMONAR: SE ENCUENTRA HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE SIN REQUERIMIENTO DE VASOPRESOR, CON SIGNOS VITALES:
- FRECUENCIA CARDIACA 86 LATIDOS POR MINUTO
- TENSIÓN ARTERIAL 99/58 MILÍMETROS DE MERCURIO
- SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO 100%
- FRECUENCIA RESPIRATORIA 20 RESPIRACIONES POR MINUTO
SE ENCUENTRA CON UN PATRÓN VENTILATORIO COSTODIAFRAGMÁTICO, CON EXCURSIÓN TORÁCICA CONSERVADA. A LA AUSCULTACIÓN SE ENCUENTRA MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN TODOS LOS CAMPOS PULMONARES, SIN SOBREAGREGADOS PULMONARES. NO SE OBSERVAN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
PACIENTE SE ENCUENTRA CON SOPORTE DE OXÍGENO SUPLEMENTARIO DADO POR CÁNULA NASAL, FIO2 DE 24%

OBJETIVOS
- PREVENIR COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
- MANTENER OXÍMETRÍA >92%
- PROMOVER EJERCICIOS DE EXPANSIÓN PULMONAR
- REEDUCACIÓN DE MECÁNICA VENTILATORIA.

INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA
- POSICIONAMIENTO EN CAMA CON CABECERA DE CAMA A 25°

- MONITORÍA RESPIRARTORIA
- EJERCICIOS DE RE EXPANSIÓN TORÁCICA
- SE REALIZA TERAPIA RESPIRATORIA ENTRENAMIENTO DIAFRAGMÁTICO
- SE REALIZA EJERCICIOS RESPIRATORIOS CON MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES SINCRÓNICOS CON FASES DE LA RESPIRACIÓN.

SE DEJA PACIENTE ESTABLE DENTRO DE SU CONDICIÓN CLÍNICA. SE DEJA CAMA A 25°, CON BARANDAS ARRIBA.

2026-03-08 19:38	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

DE ORDEN 202603080170
HEMOCULTIVO #2 MSD
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080169
HEMOCULTIVO#1 LINEA ARTERIAL FEMORAL
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080168
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:14
PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO 1.88 ng/ml ELEVADA DISCRETAMENTE. PLAN: POR AHORA CONTINUAR CON AMPICILINA SULBACTAM.

ORDEN: 202603080040
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:44
ACIDO LACTICO 1.12 DEPURADO
CALCIO IONICO 1.13 LIMITE INFERIOR
PH: 7.32, PCO2: 35, CO2: 47.7, HCO3: 17.9M SO2: 79.8, GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICA , SATURACION VENOSA CENTRAL ALTA , CHOQUE VASODILATADO EN MANEJO CON VASOPRESINA.

#ORDEN 202603080039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:43
ELECTROLIOS EN RANGO DE NORMALIDAD
CLORO 104.0
FOSFORO 5.50
POTASIO 3.60
SODIO 140.0

HEMGORAMA SIN LEUCOCITOISS NI NEUTROFIA, HB ESTABLE POSTERIOR A PROCEDIMIENTO, PLAQUETAS EN RANGO DE SEGURIDAD.
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.15
MCV 86.4
MCH 29.0
MCHC 33.5
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9
RDW SD 45.1
RDW CV 14.3
MPV 9.1
NEUTROFILOS Abs 4.19
LINFOCITOS Abs 0.81
MONOCITOS Abs 0.28
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 78.4
LINFOCITOS % 15.2
MONOCITOS % 5.3
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 27.2
HEMOGLOBINA 9.1
RECUENTO DE LEUCOCITOS 5.34
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 177

ORDEN 202603070122
GASES VENOSOS
pH 7.399
PCO2 37.1 mmHg
pO2 35.8 mmol/L
HCO3act 22.4 mmol/L
BE(B) -2.1 mmol/L
SO2 70.8 %

EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2, DELTA DE CO2 5 MMHG NORMAL

ORDEN 202603070121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 08:44
GASES ARTERIALES
pH 7.436
PCO2 32.1 mmHg
pO2 78.9 mmHG
HCO3act 21.1 mmol/L
BE(B) -2.6 mmol/L
SO2 95.6 %
pO2/FiO2 3.29 mmHg
FIO2 24.0 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, HIPOCAPNIA LEVE, NORMOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR.

ORDEN 202603070100
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:54
CLORO 102.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1311.0 U/L ELEVADA, PERO EN DESCENSO RESPECTO A LA PREVIA.
FOSFORO 3.60 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.50 mg/dl HIPOMAGNESEMIA LEVE
POTASIO 3.00 mmol/L HIPOCALEMIA LEVE, SE INICIA REPOSICION CON KATROL 15 MEQ EN INFUSION DE LEV.
SODIO 138.0 mmol/L NORMAL

INR 1.44
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.7 seg
INR EN LIMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD, PT Y PTT LIGERAMENTE PROLONADOS.

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 86.0 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 33.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.2 um3
RDW CV 14.4 %
MPV 9.2 um3
NEUTROFILOS Abs 3.51
LINFOCITOS Abs 2.08
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.05
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 53.0 %
LINFOCITOS % 31.3 %
MONOCITOS % 13.4 %
EOSINOFILOS % 0.8 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.8 %
HEMOGLOBINA 9.0 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 6.63 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 147 X10³/mm³
TROMBOCITOPENIA LEVE, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL

ORDEN 202603070099
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:51
ACIDO LACTICO 0.94 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.17 mmol/L NORMAL

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg

AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg

pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50

NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

REPORTE FINAL NEGATIVO
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h NEGATIVA
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9

EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-08 19:53	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

IMAGENES

2026-03-06 13:16:37 RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-06
ENTIDAD: PARTICULAR
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 0.499 mGy.
TÉCNICA:
Proyección única AP.
HALLAZGOS:
Engrosamiento del intersticio peribroncovascular.
Cardiomegalia global.
Hilios pulmonares y patrón de flujo sin alteración.
Tráquea central.
Catéter subclavio derecho con extremo distal en unión cavoatrial.
Sonda enteral con extremo distal por debajo del hemidiafragma izquierdo.
Elementos de monitoria externa.
Informe firmado electrónicamente por:
CRISTIAN ANDRES QUINTERO RIVAS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 19309197
Fecha y hora de firma: 06-03-2026 16:47

ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Estudio realizado el 05/03/2026.
1. Situs solitus atrial y visceral. Levoapex.
2. Retornos venosos pulmonar y sistémico normales.
3. Septo interauricular e interventricular sin defectos. No se visualiza ductus arterioso.
4. Conexiones aurícula ventriculares concordantes. Válvula Tricúspide con insuficiencia leve con radiante rejugitante de 30 mm de mercurio le permite una calcular una una presión sistólica de arteria pulmonar de 40 mm de mercurio , sin estenosis, Válvula Mitral de aspecto normal, sin estenosis ni insuficiencia.
5. Conexiones ventrículo arteriales concordantes. Válvula pulmonar de aspecto normal, sin estenosis, Válvula Aórtica de aspecto normal, trivalva, sin estenosis ni insuficiencia.
6. Ventrículo derecho de aspecto normal. Función sistólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
7. Ventrículo izquierdo de aspecto normal. Función sistodiastólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
8. Arteria Pulmonar de aspecto normal, ramas confluentes.
9. Arco aórtico izquierdo, no sitios de coartación.
10. Tercio proximal de arterias coronarias normal.
11. Pericardio normal.
Conclusión:
1. Corazón de estructura y función normal
2. Signos indirectos pulmonar leve probabilidad baja intermedia (fusión catéter ventricular normal no hay cardiopatía congénita estructural ni trombo ni vegetación ni derrame)
ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05

ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Paciente: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO Página 1 de 2
Informe firmado electrónicamente por:
ERNESTO VALLEJO
CARDIÓLOGO
No. registro:
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 15:23

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL 2026-03-05 HORA 09 0 7

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

DLP 0.499 mGy.cm
Proyección única frontal.
HALLAZGOS:
Opacidades alveolointersticiales difusas en el tercio superior del hemitorax derecho; podría ser de etiología inflamatoria/infecciosa.
Tráquea y bronquios fuentes centrales y permeables.
Ensanchamiento mediastinal superior con un diámetro máximo de 9.1cm, sin lograr descartar lesión ocupante de espacio.
No hay cámaras de neumotórax.
Ángulos costofrénicos libres.
No se observan opacidades consolidativas ni masas en ambos hemitorax.
Engrosamiento cisural derecho.
Tórax óseo con evidencia de fracturas de IV arco costal izquierdo en su sector posterolateral.
Elementos de monitoria externa.

ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales finos desde la base del cráneo hasta C7 con reconstrucciones multiplanares y volumétricas evidenciando:
HALLAZGOS:
No se demuestran alteraciones en los cuerpos vertebrales ni en los elementos posteriores.
Tampoco hay trastornos de la alineación.
Las facetas articulares y las articulaciones uncovertebrales presentan aspecto corriente.
No se demuestran particularidades en los discos intervertebrales ni en los agujeros de conjugación.
No hay lesiones líticas ni blásticas.
El canal raquídeo y los recesos lo mismo que los agujeros intervertebrales son amplios y suficientes.
No se demuestran lesiones compresivas ni erosivas.
La médula espinal tiene morfología y densidad normales.
No hay colecciones anormales ni alteraciones epi o subdurales.
Los tejidos blandos paravertebrales no muestran alteraciones.
CONCLUSIÓN:
1. EL PRESENTE ESTUDIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Paciente: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO Página 1 de 2
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se obtienen cortes axiales finos desde la base del cráneo al vértex.
HALLAZGOS:
En la ventana ósea no se identifican trazos radiolúcidos de fracturas desplazadas ni deprimidas.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En la ventana para parénquima cerebral, se identifica adecuada diferenciación entre corteza y sustancia blanca.
Línea media central.
El volumen y la morfología del sistema ventricular es normal.
Núcleos basales normales.
Cisternas basales libres.
Cerebelo y tallo cerebral de aspecto habitual.
No se identifican colecciones endocraneanas hiperdensas que sugieran hematomas intra ni extraaxiales de carácter agudo.
OPINIÓN:
1. ESTUDIO NEGATIVO PARA SIGNOS DE LESIÓN TRAUMÁTICA ENDOCRANEANA
DE CARÁCTER AGUDO.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE TORAX CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del cuello hasta el hemiabdomen superior previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Corazón de tamaño normal.
Aorta y el origen de los vasos supraaórticos son normales.
Vasos pulmonares normales.
Tráquea y bronquios fuente de aspecto normal.
No hay masas ni colecciones mediastinales.
Espacios pleurales libres.
No hay cámaras de neumotórax.
En la ventana pulmonar no se identifican áreas de consolidación ni atelectasia.
La densidad del parénquima pulmonar es normal.
No hay masas ni colecciones pulmonares.
Estructuras de la pared torácica de aspecto usual.
CONCLUSIÓN:
1. ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:00

ESTUDIO: TOMOGRAFIA 3D
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:33

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales en los miembros inferiores, posterior a la administración de medio de contraste endovenoso en fase de adquisición arterial y venosa, identificándose:
HALLAZGOS:
Lo visualizado de ambas arterias ilíacas comunes, internas y externas, conserva realce normal con el contraste, sin extravasación, al igual que las venas adyacentes.
Se identifican fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Núcleos epifisarios presentes, no fusionados.
Parcialmente, se identifica fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
MIEMBRO INFERIOR DERECHO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, sus ramas, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal, sin trombosis, sin extravasación del contraste.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal.
Se observa extravasación del medio de contraste en la cara lateral del muslo entre el tercio medio y tercio distal, proveniente de la arteria femoral profunda, sin afectar ramas principales; corresponden a ramas intramusculares, identificándose zona de extravasación de aprox. 4cm, que se extiende a lo largo de la cara lateral del resto del muslo y la rodilla en el lado izquierdo, por sangrado agudo activo. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Se identifica distorsión del tercio medio y distal del músculo cuádriceps, tanto en su parte anterior, como en su parte lateral, en relación con lesión muscular con mayor afectación del vasto del cuádriceps; también hay distorsión de la parte más inferior del músculo bíceps femoral, por lo que se sospecha lesión parcial del mismo, la mayoría del sangrado es en el interior del vasto lateral del cuádriceps, con pérdida de tejido en la parte anterior extensa que sugiere exposicion mucular, asociado a algunas imagenes densas puntiformes que sugiren cuerpos extraños.
Enfisema subcutáneo generalizado.
En el muslo no se definen fracturas.
Núcleos epifisarios presentes, conservados.
Derrame articular en la rodilla.

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

Distorsión de los tejidos blandos anteriores de la rodilla, tanto medial como lateral, que sugiere solución de continuidad extensa.
No se definen fracturas.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
CONCLUSIÓN:
Sangrado agudo activo abundante, con extravasación del medio de contraste en la cara lateral del tercio medio y distal del muslo izquierdo, secundario a lesión vascular de arterias musculares, ramas de la arteria femoral profunda izquierda. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Edema y distorsión, mal definición de los tejidos blandos de la cara lateral del tercio medio y distal del muslo, también de la rodilla de predominio anterior, que sugiere solución de continuidad extensa con exposición muscular.
Irregularidad del tercio medio y distal del músculo cuádriceps en el lado izquierdo en relación con lesión muscular que afecta sobre todo el vasto lateral del cuadriceps.
Distorsión de la parte inferior del músculo bíceps femoral izquierdo que sugiere lesion parcial del mismo.
En forma adicional, en lo visualizado de la pelvis se identifica: fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:34

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TORAX
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO

DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 0.499 mGy.
HALLAZGOS:
Silueta cardiomediastínica normal.
La vascularización pulmonar es normal.
La transparencia pleuropulmonar es satisfactoria.
Estructuras óseas normales.
CONCLUSIÓN:
ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:06

ESTUDIO: TAC DE ABDOMEN TOTAL CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del tórax hasta la sínfisis púbica previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Hígado de volumen y morfología habituales, sin lesiones focales del parénquima.
Vesícula biliar distendida de aspecto usual.
La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
Páncreas sin alteración.
Bazo de volumen y morfología habituales sin lesiones focales.
Riñones que concentran y eliminan adecuadamente el medio de contraste sin lesiones focales del parénquima ni dilatación de los sistemas colectores.
Glándulas suprarrenales normales.
Vasos retroperitoneales normales.
Vejiga adecuadamente distendida de aspecto habitual.
No se identifican lesiones estenosantes ni compresiones extrínsecas a nivel intestinal.
No hay líquido libre intraabdominal.
No hay cámaras de neumoperitoneo.
Con ventana ósea se observa trazo de fractura a nivel de cuerpo vertebral de L4.
CONCLUSIÓN:
1. FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL DE L4. SE SUGIERE COMPLEMENTO CON TOMOGRAFÍA LUMBOSACRA.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:01

2026-03-08 22:31	**PROFESIONAL:** diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS- PEDIATRIA - NOCHE
DR. DIANA DONNEYS (MD ESPECIALISTA) -SEBASTIAN MONTES (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
EDAD: 10 AÑOS
DOCUMENTO: PT 7527774
ENTIDAD:SAVIA SALUD
ACUDIENTE: SIN ACUDIENTE AL MOMENTO DE INGRESO
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 04/03/2026
FECHA INGRESO A UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO : 04/03/2026

DIAGNOSTICOS:
1.ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA ENERGÍA CINÉTICA (04/03/2026).
1.1 POLITRAUMATISMO
1.2 TRAUMA POR APLASTAMIENTO
1.3 RABDOMIOLISIS
2.TRAUMA DE TORAX CERRADO
2.1 FRACTURAS DE IV ARCO COSTAL IZQUIERDO EN SU SECTOR POSTEROLATERAL.
2.2 CONTUSIÓN MIOCÁRDICA EN SEGUIMIENTO
2.3 CONTUSIÓN PULMONAR BILATERAL
2.4 MÚLTIPLES QUEMADURAS POR FRICCIÓN EN REGION DEL DORSO TORACOLUMBAR
2.5 QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIB - III EN REGION DORSAL Y LUMBAR QUE COMPROMETE UN 18%SCT -QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIB EN HOMBRO IZQUIERDO QUE COMPROMETE UN 2%SCT -QUEMADURA POR FRICCION GRADO IIA EN REGION MALAR IZQ Y DERECHA QUE COMPROMETE UN 2%SCT
2.6 POP DE LAVADO + DECRIBDAMIENTO 07/03/2026 DRA BURBANO
2.5 RIESGO DE LESIÓN DE GRANDES VASOS

3. TRAUMA RAQUIMEDULAR
– FRACTURA CUERPO VERTEBRAL L4
4. TRAUMA DE PELVIS ESTABLE
5. TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9
5.1. DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL
5.2. AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA
5.3. POP ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACIÓN DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026)
5.4. POP CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACIÓN Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPLÍTEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCIÓN. TROMBECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACIÓN VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOFÁSICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACIÓN DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACIÓN DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPLÍTEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026)
6. CHOQUE MIXTO HIPOVOLÉMICO GRADO IV EN RESOLUCIÓN
7. FALLA RESPIRATORIA TIPO 1 SECUNDARIA CHOQUE HIPOVOLÉMICO RESUELTA

CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
.- SOPORTE VASOPRESOR
.- MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INVASIVA
.- MONITORIZACIÓN NEUROLÓGICA NIRS
.- REQUERIMIENTO HEMODINÁMICO TIPO STARLING

EVENTOS
*DESTETE DE VASOPRESOR
*CHOQUE HIPOVOLÉMICO RESPONDEDOR A CRISTALOIDES Y HEMODERIVADOS
*MEJOR MODULACIÓN DEL DOLOR

MONITORIA
.- GASTO CARDIACO NO INVASIVO: IVS: 29- IGC: 3.0
.- MONITORIA NIRS : L: 82M-SOMÁTICO DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO 90

SOPORTE
CÁNULA NASAL CONVENCIONAL FIO2: 24%

INFUSIONES:
- VASOPRESINA 0.01 UI/KG/H
- DEXMEDETOMIDINA 0.2 UG/KG/ H
- KETAMINA 5 MCG/KG/MIN

TRASFUSIONES:
2 UNIDADES DE GLÓBULOS ROJOS + 2 DE PLASMA 04/03/2026
1 UNIDAD DE GLÓBULOS ROJOS +1 PLASMA 05/03/2026
1 UNIDAD DE GLÓBULO ROJO 06/ 03/26

* INVASIONES
.- SONDA VESICAL 05/03/2026
.- CATÉTER VENOSO CENTRAL SUBCLAVIO DERECHO - 05/03/2026 SALAS DE CIRUGÍA
.- LINEA ARTERIAL FEMORAL DERECHA - 05/03/2026 UCIPED
.- CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO MSD - 04/03/2026
.- CATETER VENOSO PERIFERICO MSI - 04/03/2023
- INTUBACIÓN TRAQUEAL TOT 6,5 CON NEUMOTAPÓNADOR FIJO 21 CM 04/03/2026 FF 06/03/2026

EXAMEN FÍSICO:
SE VALORA A PACIENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDICADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 100/56 MMHG TAM: 71 MMHG
FRECUENCIA CARDIACA: 102 L/MIN
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 20 /MIN
SO2: 100 % CON CÁNULA NASAL FiO2 24 %
TEMPERATURA: 36.6 °C AFEBRIL EN 12 HORAS
TALLA 152 CM
BALANCE HÍDRICO EN 12 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 1308CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 1320 CC
BALANCE DEL DIA - 811.2 CC
BALANCE ACUMULADO : +1980.7
GU: 2.7 CC/KG/H
METABÓLICO: SIN NET, GLUCOMETRIAS: 112 MG/DL, SIN DEPOSICIÓN EN LAS ULTIMAS 12 HORAS

.- NORMOCONFIGURADA, EDEMA PALPEBRAL, PUPILAS 3 MM REACTIVAS A LA LUZ. DOLOR A LA PALPACIÓN. QUEMADURA POR FRICCIÓN, EN REGION FRONTAL IZQUIERDA. CUBIERTAS POR APOSITOS.
.- HEMODINÁMICA SOPORTE VASOPRESOR CON VASOPRESINA A DOSIS BAJAS , CON FRECUENCIA CARDIACA Y TENSIONES ARTERIALES EN METAS , ÚLTIMOS GASES VENOSOS CON SATURACIÓN VENOSA ALTA EN VIGILANCIA, LACTATO DEPURADO.
.- TÓRAX : SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, AMBOS CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS NO RUIDOS SOBREAGREGADOS, SOPORTE POR CÁNULA NASAL SAFI 416 SIN TRASTORNO DE OXIGENACIÓN
.- ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO IMPRESIONA DOLOR NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. SE INICIA ALIMENTACIÓN ENTERAL
.- RENAL: BUEN RITMO DIURÉTICO. CPK 1311 EN PLAN DE HIPERHIDRATACIÓN. ELECTROLITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD
.- HEMATOLÓGICO: SIN ESTIGMAS DE SANGRADO ACTIVO.
.-OSTEOMUSCULAR: MII CON VENDAJE ELÁSTICO, VAC FUNCIONAL A SUCCIÓN. PERFUSION DISTAL CONSERVADA.
.- NEUROLÓGICO:GLASGOW 15/15, MEJOR MODULACIÓN DEL DOLOR, INFUSIÓN DE FENTANY. PUPILAS ISOCÓRICAS Y REACTIVAS
.- PIEL : QUEMADURAS EN DORSOS Y CARA CUBIERTO POR APOSITOS

ANTIBIOTICO
AMPICILINA /SULBACTAM FI 04/03/2026

CULTIVOS
05/03/2026 CULTIVO DE SECRECIÓN DE MUSLO IZQUIERDO NEGATIVO
08/03/2026: HEMOCULTIVOS #1 EN PROCESO
08/03/2026: HEMOCULTIVO # 2 NEGATIVO

-ANALISIS:
PACIENTE DE 10 AÑOS, CON POLITRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO CON LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
*HEMODINÁMICA: SOPORTE VASOPRESOR CON VASOPRESINA A DOSIS BAJAS , CON FRECUENCIA CARDIACA Y TENSIONES ARTERIALES EN METAS , LACTATO DEPURADO. MONITOREO STARLING EN METAS , LLAMA LA ATENCION SATURACION VENOSA CENTRAL ALTA , ALTA SOSPECHA DE CHOQUE NEUROGÉNICO , SE SOLICITA GASES DE CONTROL EN PLAN DE DESTETE DE VASOPRESOR
*RESPIRATORIO: AMBOS CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS NO RUIDOS SOBREAGREGADOS, SOPORTE CON CÁNULA NASAL SAFI: 416 SIN TRASTORNO DE OXIGENACIÓN, SE INDICA RETIRO DE ESTE. CONTINUAR MANEJO CON TERAPIA RESPIRATORIA .
* METABÓLICO: SE INICIA VIA ENTERAL POR SONDA NASOGASTRICA VIGILANDO TOLERANCIA.
*RENAL: ADECUADO RITMO DIURÉTICO MANEJO CON FUROSEMIDA SE AJUSTA DOSIS ,EN PLAN DE BALANCES NEUTROS, EN FASE DE DEREANIMACION DE CHOQUE HIPOVOLÉMICO. ULTIMOS ELECTROLITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD SE AJSUTA LIQUIDOS .
*HEMATOLÓGICO: SIN SANGRADO ACTIVO EN EL MOMENTO CURSO CON COAGULOPATIA POSTRAUMATICA, ULTIMOS TIEMPOS DE COAGULACIÓN EN RANGOS DE NORMALIDAD, SE INDICA SUSPENDER VITAMINA K, CON CRITERIO DE INCIO DE ENOXAPARINA DIFERIDA EN EL MOMENTO DADO PACIENTE PRESENTA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA EL DIA DE MAÑANA
*INFECCIOSO: CUBRIMIENTO ANTIBIÓTICO CON AMPICILINA /SULBACTAM, EL DIA DE HOY CON SECRECIÓN POR VAC CON OLOR FÉTIDO , NO FIEBRE , NO OTRO SIGNOS DE SIRS ACTIVO, POR LO CUAL SE INDICO TOMA DE REACTANTES PROCALCITONINA LEVEMENTE ELEVADA, HEMOCULTIVOS EN PROCESO CONTINUA CON MANEJO ANTIBIOTICO ACTUAL. EN PROCESO LAVADO Y REVISION DE VAC PARA EL DIA ED MAÑANA
* NEUROLÓGICO: GLASGOW 15/15, MANEJO MULTIMODAL PARA EL DOLOR CON KETAMINA + DEXMEDETOMIDINA CON MEJOR CONTROL DEL DOLOR, NO SIGNOS DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA. NO SIGNOS DE FOCALIZACIÓN
*PIEL: PACIENTE CON QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIB - III EN REGION DORSAL Y LUMBAR QUE COMPROMETE UN 18%SCT -QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIB EN HOMBRO IZQUIERDO QUE COMPROMETE UN 2%SCT -QUEMADURA POR FRICCIÓN GRADO IIA EN REGION MALAR IZQ Y DERECHA QUE COMPROMETE UN 2%SCT. AHORA EN SU POP INMEDIATO DE LAVADO + DESCUBRIMIENTO . CON INDICACIÓN POR CIRUGÍA PLÁSTICA DE NUEVO LAVADO EN 2-3 DIAS.
*OSTEOMUSCULAR: EN SEGUIMIENTO POR ORTOPEDIA PEDIÁTRICA QUIEN IDNICA LAVADO Y REVISION DE VAC PROGRAMADA PARA EL DIA DE MAÑANA EN PROCESO ARTERIOGRAFÍA PARA EVALUAR VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD DADA LA SEVERIDAD DEL TRAUMA DE TEJIDOS BLANDOS EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO Y NE PROCESO REALIZACIÓN DE RNM PARA EVALUAR FRACTURA EN L4 Y TRAUMA RAQUIMEDULAR.

PACIENTE EN CONDICIÓN CRITICA ALTO RIESGO DE COMPLICACIONES Y PÉRDIDA DE AUTORIDAD.EN PROCESO DE REMISIÓN POR PARTE DE SU EPS. SE EXPLICA A LA MADRE.

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20° Y 30°
NUTRICION ENTERAL A 20 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. SUSPENDER A LAS 00+00 HORAS
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV. DISMINUIR SEGUN TOLERANICA A ENTERAL ** CAMBIO**
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,3 MCG/KG/H, IV.
KETAMINA 500 MG/100 CC SN0.9% (1 CC/H=2 MCG/KG/MIN) PASAR A 3-10 MCG/KG/MIN. IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-4/5)
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA *** CAMBIO**
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV. *** SUSPENDER**
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLÓGICA CADA HORA
MOVILIZACIÓN EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAPÉUTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESIÓN
EDUCACIÓN A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO

EN PROCESO:
EN PROCESO CIRUGIA COMO URGENCIA VITAL
HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 2 DIAS.

GRACIAS!

2026-03-09 02:04	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

DE ORDEN 202603090039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:35
GASES VENOSOS
pH Pendiente
PCO2 Pendiente
pO2 Pendiente
HCO3act Pendiente
HCO3std Pendiente
BE(B) Pendiente
BE(ecf) Pendiente
ctCO2 Pendiente
SO2 Pendiente

DE ORDEN 202603090029
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:14
INR 0.87
TIEMPO DE PROTROMBINA 9.3 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 30.0 seg
TIEMPOS DE COAGULACION EN RANGOS DE NORMALIDAD

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 85.6 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 34.1 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.3 um3
RDW CV 14.3 %
MPV 8.7 um3
NEUTROFILOS Abs 3.78
LINFOCITOS Abs 2.66
MONOCITOS Abs 0.72
EOSINOFILOS Abs 0.07
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 51.0 %
LINFOCITOS % 35.8 %
MONOCITOS % 9.7 %
EOSINOFILOS % 1.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.7 %
HEMOGLOBINA 9.1 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 7.42 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 254 X10³/mm³
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA CON HGB ESTABLE.

DE ORDEN 202603080170
HEMOCULTIVO #2 MSD
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080169
HEMOCULTIVO#1 LINEA ARTERIAL FEMORAL
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080168
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:14
PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO 1.88 ng/ml ELEVADA DISCRETAMENTE. PLAN: POR AHORA CONTINUAR CON AMPICILINA SULBACTAM.

ORDEN: 202603080040
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:44
ACIDO LACTICO 1.12 DEPURADO
CALCIO IONICO 1.13 LIMITE INFERIOR
PH: 7.32, PCO2: 35, CO2: 47.7, HCO3: 17.9M SO2: 79.8, GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICA , SATURACION VENOSA CENTRAL ALTA , CHOQUE VASODILATADO EN MANEJO CON VASOPRESINA.

#ORDEN 202603080039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:43
ELECTROLIOS EN RANGO DE NORMALIDAD
CLORO 104.0
FOSFORO 5.50

POTASIO 3.60
SODIO 140.0

HEMGORAMA SIN LEUCOCITOISS NI NEUTROFIA, HB ESTABLE POSTERIOR A PROCEDIMIENTO, PLAQUETAS EN RANGO DE SEGURIDAD.
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.15
MCV 86.4
MCH 29.0
MCHC 33.5
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9
RDW SD 45.1
RDW CV 14.3
MPV 9.1
NEUTROFILOS Abs 4.19
LINFOCITOS Abs 0.81
MONOCITOS Abs 0.28
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 78.4
LINFOCITOS % 15.2
MONOCITOS % 5.3
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 27.2
HEMOGLOBINA 9.1
RECUENTO DE LEUCOCITOS 5.34
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 177

ORDEN 202603070122
GASES VENOSOS
pH 7.399
PCO2 37.1 mmHg
pO2 35.8 mmol/L
HCO3act 22.4 mmol/L
BE(B) -2.1 mmol/L
SO2 70.8 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2, DELTA DE CO2 5 MMHG NORMAL

ORDEN 202603070121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 08:44
GASES ARTERIALES
pH 7.436
PCO2 32.1 mmHg
pO2 78.9 mmHG
HCO3act 21.1 mmol/L
BE(B) -2.6 mmol/L
SO2 95.6 %
pO2/FiO2 3.29 mmHg
FIO2 24.0 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, HIPOCAPNIA LEVE, NORMOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR.

ORDEN 202603070100
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:54
CLORO 102.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1311.0 U/L ELEVADA, PERO EN DESCENSO RESPECTO A LA PREVIA.
FOSFORO 3.60 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.50 mg/dl HIPOMAGNESEMIA LEVE
POTASIO 3.00 mmol/L HIPOCALEMIA LEVE, SE INICIA REPOSICION CON KATROL 15 MEQ EN INFUSION DE LEV.
SODIO 138.0 mmol/L NORMAL

INR 1.44
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.7 seg
INR EN LIMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD, PT Y PTT LIGERAMENTE PROLONADOS.

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 86.0 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 33.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.2 um3
RDW CV 14.4 %
MPV 9.2 um3
NEUTROFILOS Abs 3.51
LINFOCITOS Abs 2.08
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.05
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 53.0 %
LINFOCITOS % 31.3 %
MONOCITOS % 13.4 %

EOSINOFILOS % 0.8 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.8 %
HEMOGLOBINA 9.0 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 6.63 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 147 X10³/mm³
TROMBOCITOPENIA LEVE, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL

ORDEN 202603070099
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:51
ACIDO LACTICO 0.94 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.17 mmol/L NORMAL

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR

EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22

ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %

EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

REPORTE FINAL NEGATIVO
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h NEGATIVA
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR

MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-09 05:30	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

DE ORDEN 202603090039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:35
GASES VENOSOS
pH 7.424
PCO2 38.8 mmHg
pO2 41.5 mmHg
HCO3act 24.8 mmol/L
BE(B) 0.5 mmol/L
SO2 77.3 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvCO2 NORMAL, PvO2 NORMAL, BICARBONATO NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2.

DE ORDEN 202603090029
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:14
INR 0.87
TIEMPO DE PROTROMBINA 9.3 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 30.0 seg
TIEMPOS DE COAGULACION EN RANGOS DE NORMALIDAD

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 85.6 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 34.1 g/dl

INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.3 um3
RDW CV 14.3 %
MPV 8.7 um3
NEUTROFILOS Abs 3.78
LINFOCITOS Abs 2.66
MONOCITOS Abs 0.72
EOSINOFILOS Abs 0.07
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 51.0 %
LINFOCITOS % 35.8 %
MONOCITOS % 9.7 %
EOSINOFILOS % 1.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.7 %
HEMOGLOBINA 9.1 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 7.42 $X10^3/mm^3$
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 254 $X10^3/mm^3$
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA CON HGB ESTABLE.

DE ORDEN 202603080170
HEMOCULTIVO #2 MSD
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080169
HEMOCULTIVO#1 LINEA ARTERIAL FEMORAL
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080168
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:14
PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO 1.88 ng/ml ELEVADA DISCRETAMENTE. PLAN: POR AHORA CONTINUAR CON AMPICILINA SULBACTAM.

ORDEN: 202603080040
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:44
ACIDO LACTICO 1.12 DEPURADO
CALCIO IONICO 1.13 LIMITE INFERIOR
PH: 7.32, PCO2: 35, CO2: 47.7, HCO3: 17.9M SO2: 79.8, GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICA , SATURACION VENOSA CENTRAL ALTA , CHOQUE VASODILATADO EN MANEJO CON VASOPRESINA.

#ORDEN 202603080039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:43
ELECTROLIOS EN RANGO DE NORMALIDAD
CLORO 104.0
FOSFORO 5.50
POTASIO 3.60
SODIO 140.0

HEMGORAMA SIN LEUCOCITOISS NI NEUTROFIA, HB ESTABLE POSTERIOR A PROCEDIMIENTO, PLAQUETAS EN RANGO DE SEGURIDAD.
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.15
MCV 86.4
MCH 29.0
MCHC 33.5
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9
RDW SD 45.1
RDW CV 14.3
MPV 9.1
NEUTROFILOS Abs 4.19
LINFOCITOS Abs 0.81
MONOCITOS Abs 0.28
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 78.4
LINFOCITOS % 15.2
MONOCITOS % 5.3
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 27.2
HEMOGLOBINA 9.1

RECUENTO DE LEUCOCITOS 5.34
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 177

ORDEN 202603070122
GASES VENOSOS
pH 7.399
PCO2 37.1 mmHg
pO2 35.8 mmol/L
HCO3act 22.4 mmol/L
BE(B) -2.1 mmol/L
SO2 70.8 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2, DELTA DE CO2 5 MMHG NORMAL

ORDEN 202603070121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 08:44
GASES ARTERIALES
pH 7.436
PCO2 32.1 mmHg
pO2 78.9 mmHG
HCO3act 21.1 mmol/L
BE(B) -2.6 mmol/L
SO2 95.6 %
pO2/FiO2 3.29 mmHg
FIO2 24.0 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, HIPOCAPNIA LEVE, NORMOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR.

ORDEN 202603070100
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:54
CLORO 102.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1311.0 U/L ELEVADA, PERO EN DESCENSO RESPECTO A LA PREVIA.
FOSFORO 3.60 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.50 mg/dl HIPOMAGNESEMIA LEVE
POTASIO 3.00 mmol/L HIPOCALEMIA LEVE, SE INICIA REPOSICION CON KATROL 15 MEQ EN INFUSION DE LEV.
SODIO 138.0 mmol/L NORMAL

INR 1.44
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.7 seg
INR EN LIMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD, PT Y PTT LIGERAMENTE PROLONADOS.

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 86.0 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 33.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.2 um3
RDW CV 14.4 %
MPV 9.2 um3
NEUTROFILOS Abs 3.51
LINFOCITOS Abs 2.08
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.05
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 53.0 %
LINFOCITOS % 31.3 %
MONOCITOS % 13.4 %
EOSINOFILOS % 0.8 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.8 %
HEMOGLOBINA 9.0 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 6.63 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 147 X10³/mm³
TROMBOCITOPENIA LEVE, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL

ORDEN 202603070099
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:51
ACIDO LACTICO 0.94 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.17 mmol/L NORMAL

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L

ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01

NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 $X10^3/mm^3$
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 $X10^3/mm^3$
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4

FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L

BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg

TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

REPORTE FINAL NEGATIVO
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h NEGATIVA
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³

MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-09 05:41	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE IMAGENES

2026-03-09 03:57 TAC DE RODILLA IZQUIERDA ***PENDIENTE REPORTE OFICIAL********** COMO OPINION PERSONAL NO SE EVIDENCIAN SOLUCIONES DE CONTINUIDAD, SI HAY COMPROMISO DE TEJIDOS BLANDOS, NO COMPROMISO DE RELACIONES ARTICULARES.

2026-03-09 03:56 RADIOGRAFIA DE RODILLA IZQUIERDA ***PENDIENTE REPORTE OFICIAL********** COMO OPINION PERSONAL NO SE EVIDENCIAN SOLUCIONES DE CONTINUIDAD, SI HAY COMPROMISO DE TEJIDOS BLANDOS, NO COMPROMISO DE RELACIONES ARTICULARES.

2026-03-06 13:16:37 RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-06
ENTIDAD: PARTICULAR
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 0.499 mGy.
TÉCNICA:
Proyección única AP.
HALLAZGOS:
Engrosamiento del intersticio peribroncovascular.
Cardiomegalia global.
Hilios pulmonares y patrón de flujo sin alteración.
Tráquea central.
Catéter subclavio derecho con extremo distal en unión cavoatrial.
Sonda enteral con extremo distal por debajo del hemidiafragma izquierdo.
Elementos de monitoria externa.
Informe firmado electrónicamente por:
CRISTIAN ANDRES QUINTERO RIVAS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 19309197
Fecha y hora de firma: 06-03-2026 16:47

ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Estudio realizado el 05/03/2026.
1. Situs solitus atrial y visceral. Levoapex.
2. Retornos venosos pulmonar y sistémico normales.

3. Septo interauricular e interventricular sin defectos. No se visualiza ductus arterioso.
4. Conexiones aurícula ventriculares concordantes. Válvula Tricúspide con insuficiencia leve con radiante rejugitante de 30 mm de mercurio le permite una calcular una una presión sistólica de arteria pulmonar de 40 mm de mercurio , sin estenosis, Válvula Mitral de aspecto normal, sin estenosis ni insuficiencia.
5. Conexiones ventrículo arteriales concordantes. Válvula pulmonar de aspecto normal, sin estenosis, Válvula Aórtica de aspecto normal, trivalva, sin estenosis ni insuficiencia.
6. Ventrículo derecho de aspecto normal. Función sistólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
7. Ventrículo izquierdo de aspecto normal. Función sistodiastólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
8. Arteria Pulmonar de aspecto normal, ramas confluentes.
9. Arco aórtico izquierdo, no sitios de coartación.
10. Tercio proximal de arterias coronarias normal.
11. Pericardio normal.
Conclusión:
1. Corazón de estructura y función normal
2. Signos indirectos pulmonar leve probabilidad baja intermedia (fusión catéter ventricular normal no hay cardiopatía congénita estructural ni trombo ni vegetación ni derrame)
ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Paciente: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO Página 1 de 2
Informe firmado electrónicamente por:
ERNESTO VALLEJO
CARDIÓLOGO
No. registro:
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 15:23

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL 2026-03-05 HORA 09 0 7
ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
DLP 0.499 mGy.cm
Proyección única frontal.
HALLAZGOS:
Opacidades alveolointersticiales difusas en el tercio superior del hemitorax derecho; podría ser de etiología inflamatoria/infecciosa.
Tráquea y bronquios fuentes centrales y permeables.
Ensanchamiento mediastinal superior con un diámetro máximo de 9.1cm, sin lograr descartar lesión ocupante de espacio.
No hay cámaras de neumotórax.
Ángulos costofrénicos libres.
No se observan opacidades consolidativas ni masas en ambos hemitorax.
Engrosamiento cisural derecho.
Tórax óseo con evidencia de fracturas de IV arco costal izquierdo en su sector posterolateral.
Elementos de monitoria externa.

ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales finos desde la base del cráneo hasta C7 con reconstrucciones multiplanares y volumétricas evidenciando:
HALLAZGOS:
No se demuestran alteraciones en los cuerpos vertebrales ni en los elementos posteriores.
Tampoco hay trastornos de la alineación.
Las facetas articulares y las articulaciones uncovertebrales presentan aspecto corriente.
No se demuestran particularidades en los discos intervertebrales ni en los agujeros de conjugación.
No hay lesiones líticas ni blásticas.
El canal raquídeo y los recesos lo mismo que los agujeros intervertebrales son amplios y suficientes.
No se demuestran lesiones compresivas ni erosivas.
La médula espinal tiene morfología y densidad normales.
No hay colecciones anormales ni alteraciones epi o subdurales.
Los tejidos blandos paravertebrales no muestran alteraciones.

CONCLUSIÓN:
1. EL PRESENTE ESTUDIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Paciente: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO Página 1 de 2
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se obtienen cortes axiales finos desde la base del cráneo al vértex.
HALLAZGOS:
En la ventana ósea no se identifican trazos radiolúcidos de fracturas desplazadas ni deprimidas.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En la ventana para parénquima cerebral, se identifica adecuada diferenciación entre corteza y sustancia blanca.
Línea media central.
El volumen y la morfología del sistema ventricular es normal.
Núcleos basales normales.
Cisternas basales libres.
Cerebelo y tallo cerebral de aspecto habitual.
No se identifican colecciones endocraneanas hiperdensas que sugieran hematomas intra ni extraaxiales de carácter agudo.
OPINIÓN:
1. ESTUDIO NEGATIVO PARA SIGNOS DE LESIÓN TRAUMÁTICA ENDOCRANEANA
DE CARÁCTER AGUDO.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE TORAX CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del cuello hasta el hemiabdomen superior previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Corazón de tamaño normal.
Aorta y el origen de los vasos supraaórticos son normales.
Vasos pulmonares normales.
Tráquea y bronquios fuente de aspecto normal.
No hay masas ni colecciones mediastinales.
Espacios pleurales libres.
No hay cámaras de neumotórax.
En la ventana pulmonar no se identifican áreas de consolidación ni atelectasia.
La densidad del parénquima pulmonar es normal.
No hay masas ni colecciones pulmonares.
Estructuras de la pared torácica de aspecto usual.
CONCLUSIÓN:
1. ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:00

ESTUDIO: TOMOGRAFIA 3D
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:33

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales en los miembros inferiores, posterior a la administración de medio de contraste endovenoso en fase de adquisición arterial y venosa, identificándose:
HALLAZGOS:
Lo visualizado de ambas arterias ilíacas comunes, internas y externas, conserva realce normal con el contraste, sin extravasación, al igual que las venas adyacentes.
Se identifican fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Núcleos epifisarios presentes, no fusionados.
Parcialmente, se identifica fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
MIEMBRO INFERIOR DERECHO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, sus ramas, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal, sin trombosis, sin extravasación del contraste.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal.
Se observa extravasación del medio de contraste en la cara lateral del muslo entre el tercio medio y tercio distal, proveniente de la arteria femoral profunda, sin afectar ramas principales; corresponden a ramas intramusculares, identificándose zona de extravasación de aprox. 4cm, que se extiende a lo largo de la cara lateral del resto del muslo y la rodilla en el lado izquierdo, por sangrado agudo activo. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Se identifica distorsión del tercio medio y distal del músculo cuádriceps, tanto en su parte anterior, como en su parte lateral, en relación con lesión muscular con mayor afectación del vasto del cuádriceps; también hay distorsión de la parte más inferior del músculo bíceps femoral, por lo que se sospecha lesión parcial del mismo, la mayoría del sangrado es en el interior del vasto lateral del cuádriceps, con pérdida de tejido en la parte anterior extensa que sugiere exposicion mucular, asociado a algunas imagenes densas puntiformes que sugiren cuerpos extraños.
Enfisema subcutáneo generalizado.
En el muslo no se definen fracturas.
Núcleos epifisarios presentes, conservados.
Derrame articular en la rodilla
Distorsión de los tejidos blandos anteriores de la rodilla, tanto medial como lateral, que sugiere solución de continuidad extensa.
No se definen fracturas.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
CONCLUSIÓN:
Sangrado agudo activo abundante, con extravasación del medio de contraste en la cara lateral del tercio medio y distal del muslo izquierdo, secundario a lesión vascular de arterias musculares, ramas de la arteria femoral profunda izquierda. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Edema y distorsión, mal definición de los tejidos blandos de la cara lateral del tercio medio y distal del muslo, también de la rodilla de predominio anterior, que sugiere solución de continuidad extensa con exposición muscular.
Irregularidad del tercio medio y distal del músculo cuádriceps en el lado izquierdo en relación con lesión muscular que afecta sobre todo el vasto lateral del cuadriceps.
Distorsión de la parte inferior del músculo bíceps femoral izquierdo que sugiere lesion parcial del mismo.
En forma adicional, en lo visualizado de la pelvis se identifica: fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:34

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TORAX
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 0.499 mGy.
HALLAZGOS:
Silueta cardiomediastínica normal.
La vascularización pulmonar es normal.
La transparencia pleuropulmonar es satisfactoria.
Estructuras óseas normales.
CONCLUSIÓN:
ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:06

ESTUDIO: TAC DE ABDOMEN TOTAL CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del tórax hasta la sínfisis púbica previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Hígado de volumen y morfología habituales, sin lesiones focales del parénquima.
Vesícula biliar distendida de aspecto usual.
La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
Páncreas sin alteración.
Bazo de volumen y morfología habituales sin lesiones focales.
Riñones que concentran y eliminan adecuadamente el medio de contraste sin lesiones focales del parénquima ni dilatación de los sistemas colectores.
Glándulas suprarrenales normales.
Vasos retroperitoneales normales.
Vejiga adecuadamente distendida de aspecto habitual.
No se identifican lesiones estenosantes ni compresiones extrínsecas a nivel intestinal.
No hay líquido libre intraabdominal.
No hay cámaras de neumoperitoneo.
Con ventana ósea se observa trazo de fractura a nivel de cuerpo vertebral de L4.
CONCLUSIÓN:
1. FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL DE L4. SE SUGIERE COMPLEMENTO CON TOMOGRAFÍA LUMBOSACRA.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:01

2026-03-09 14:06	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE IMAGENES

.- TOMOGRAFÍA DE RODILLA IZQUIERDA.
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 111.53 mGy.cm
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se realizan cortes de la rodilla izquierda, con reconstrucciones multiplanares.
HALLAZGOS:
Densidad ósea adecuada.
Se observa una pérdida de la morfología del cóndilo femoral externo izquierdo con un defecto óseo y aspecto lineal, con relación a cambios postraumáticos y con signos de fractura de la cortical lateral de la epífisis distal del fémur.
Se observa también extensa solución de continuidad en la piel y tejido celular subcutáneo de la región lateral del muslo, observando material de cobertura externo y sistema de drenaje con vacío.
Imagen hiperdensa que sugiere corresponder a un cuerpo extraño en la fisis proximal de la fíbula.
Edema y enfisema de los tejidos blandos.
Relaciones articulares congruentes.

OPINIÓN:
1. HALLAZGOS QUE SUGIEREN FRACTURA Y CAMBIOS DE LA MORFOLOGÍA DEL CÓNDILO FEMORAL EXTERNO YA VISUALIZADOS EN ESTUDIO PREVIO.
2. EXTENSO DEFECTO DE COBERTURA DE LOS TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN LATERAL DE LA RODILLA.
3. IMAGEN HIPERDENSA EN LA EPÍFISIS PROXIMAL DE LA FÍBULA QUE SUGIERE CORRESPONDER A UN CUERPO EXTRAÑO.

Informe firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH GIRALDO REYES
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 29927483
Fecha y hora de firma: 09-03-2026 12:03
ESTUDIO: TAC DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-09
ENTIDAD: SAVIA SALUD EPS

.- ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE RODILLA IZQUIERDA
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-09
ENTIDAD: SAVIA SALUD EPS

DLP 1.234 mGy.cm
TÉCNICA:
Proyecciones Ap y lateral.
HALLAZGOS:
Los núcleos de crecimiento epifisarios presentan aspecto habitual.
Estructura y densidad ósea normal.
Se conservan los espacios femorotibial lateral y medial, así como patelofemoral.
Los cóndilos femorales, las espinas y los platillos tibiales conservan su configuración.
Patela de configuración normal.
No se definen fracturas.
No hay lesiones líticas o blásticas.
Edema y distorsión de los tejidos blandos de la cara lateral del muslo y la rodilla que sugiere solución de continuidad.
Multiple clips quirurgicos.

Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 09-03-2026 12:56

2026-03-06 13:16:37 RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-06
ENTIDAD: PARTICULAR
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 0.499 mGy.
TÉCNICA:
Proyección única AP.
HALLAZGOS:
Engrosamiento del intersticio peribroncovascular.
Cardiomegalia global.
Hilios pulmonares y patrón de flujo sin alteración.
Tráquea central.
Catéter subclavio derecho con extremo distal en unión cavoatrial.
Sonda enteral con extremo distal por debajo del hemidiafragma izquierdo.
Elementos de monitoria externa.
Informe firmado electrónicamente por:
CRISTIAN ANDRES QUINTERO RIVAS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 19309197
Fecha y hora de firma: 06-03-2026 16:47

ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Estudio realizado el 05/03/2026.
1. Situs solitus atrial y visceral. Levoapex.
2. Retornos venosos pulmonar y sistémico normales.
3. Septo interauricular e interventricular sin defectos. No se visualiza ductus arterioso.
4. Conexiones aurícula ventriculares concordantes. Válvula Tricúspide con insuficiencia leve con radiante rejugitante de 30 mm de mercurio le permite una calcular una una presión sistólica de arteria pulmonar de 40 mm de mercurio , sin estenosis, Válvula Mitral de aspecto normal, sin estenosis ni insuficiencia.
5. Conexiones ventrículo arteriales concordantes. Válvula pulmonar de aspecto normal, sin estenosis, Válvula Aórtica de aspecto normal, trivalva, sin estenosis ni insuficiencia.

6. Ventrículo derecho de aspecto normal. Función sistólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
7. Ventrículo izquierdo de aspecto normal. Función sistodiastólica normal. No hay obstrucción en el tracto de salida.
8. Arteria Pulmonar de aspecto normal, ramas confluentes.
9. Arco aórtico izquierdo, no sitios de coartación.
10. Tercio proximal de arterias coronarias normal.
11. Pericardio normal.
Conclusión:
1. Corazón de estructura y función normal
2. Signos indirectos pulmonar leve probabilidad baja intermedia (fusión catéter ventricular normal no hay cardiopatía congénita estructural ni trombo ni vegetación ni derrame)
ESTUDIO: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Paciente: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO Página 1 de 2
Informe firmado electrónicamente por:
ERNESTO VALLEJO
CARDIÓLOGO
No. registro:
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 15:23

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL 2026-03-05 HORA 09 0 7
ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TÓRAX PORTATIL
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-05
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
DLP 0.499 mGy.cm
Proyección única frontal.
HALLAZGOS:
Opacidades alveolointersticiales difusas en el tercio superior del hemitorax derecho; podría ser de etiología inflamatoria/infecciosa.
Tráquea y bronquios fuentes centrales y permeables.
Ensanchamiento mediastinal superior con un diámetro máximo de 9.1cm, sin lograr descartar lesión ocupante de espacio.
No hay cámaras de neumotórax.
Ángulos costofrénicos libres.
No se observan opacidades consolidativas ni masas en ambos hemitorax.
Engrosamiento cisural derecho.
Tórax óseo con evidencia de fracturas de IV arco costal izquierdo en su sector posterolateral.
Elementos de monitoria externa.

ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales finos desde la base del cráneo hasta C7 con reconstrucciones multiplanares y volumétricas evidenciando:
HALLAZGOS:
No se demuestran alteraciones en los cuerpos vertebrales ni en los elementos posteriores.
Tampoco hay trastornos de la alineación.
Las facetas articulares y las articulaciones uncovertebrales presentan aspecto corriente.
No se demuestran particularidades en los discos intervertebrales ni en los agujeros de conjugación.
No hay lesiones líticas ni blásticas.
El canal raquídeo y los recesos lo mismo que los agujeros intervertebrales son amplios y suficientes.
No se demuestran lesiones compresivas ni erosivas.
La médula espinal tiene morfología y densidad normales.
No hay colecciones anormales ni alteraciones epi o subdurales.
Los tejidos blandos paravertebrales no muestran alteraciones.
CONCLUSIÓN:
1. EL PRESENTE ESTUDIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
Paciente: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO Página 1 de 2
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se obtienen cortes axiales finos desde la base del cráneo al vértex.
HALLAZGOS:
En la ventana ósea no se identifican trazos radiolúcidos de fracturas desplazadas ni deprimidas.
No hay lesiones óseas líticas ni blásticas.
En la ventana para parénquima cerebral, se identifica adecuada diferenciación entre corteza y sustancia blanca.
Línea media central.
El volumen y la morfología del sistema ventricular es normal.
Núcleos basales normales.
Cisternas basales libres.
Cerebelo y tallo cerebral de aspecto habitual.
No se identifican colecciones endocraneanas hiperdensas que sugieran hematomas intra ni extraaxiales de carácter agudo.
OPINIÓN:
1. ESTUDIO NEGATIVO PARA SIGNOS DE LESIÓN TRAUMÁTICA ENDOCRANEANA
DE CARÁCTER AGUDO.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 06:58

ESTUDIO: TAC DE TORAX CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del cuello hasta el hemiabdomen superior previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Corazón de tamaño normal.
Aorta y el origen de los vasos supraaórticos son normales.
Vasos pulmonares normales.
Tráquea y bronquios fuente de aspecto normal.
No hay masas ni colecciones mediastinales.
Espacios pleurales libres.
No hay cámaras de neumotórax.
En la ventana pulmonar no se identifican áreas de consolidación ni atelectasia.
La densidad del parénquima pulmonar es normal.
No hay masas ni colecciones pulmonares.
Estructuras de la pared torácica de aspecto usual.
CONCLUSIÓN:
1. ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:00

ESTUDIO: TOMOGRAFIA 3D
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:33

ESTUDIO: TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
ANGIOTC DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales en los miembros inferiores, posterior a la administración de medio de contraste endovenoso en fase de adquisición arterial y venosa, identificándose:
HALLAZGOS:
Lo visualizado de ambas arterias ilíacas comunes, internas y externas, conserva realce normal con el contraste, sin extravasación, al igual que las venas adyacentes.
Se identifican fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Núcleos epifisarios presentes, no fusionados.
Parcialmente, se identifica fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
MIEMBRO INFERIOR DERECHO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, sus ramas, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal, sin trombosis, sin extravasación del contraste.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO:
Hay adecuado realce de las arterias femoral común, superficial, profunda, poplítea, tibial anterior, posterior, peronea y pedia, con flujos normales hasta distal.
Se observa extravasación del medio de contraste en la cara lateral del muslo entre el tercio medio y tercio distal, proveniente de la arteria femoral profunda, sin afectar ramas principales; corresponden a ramas intramusculares, identificándose zona de extravasación de aprox. 4cm, que se extiende a lo largo de la cara lateral del resto del muslo y la rodilla en el lado izquierdo, por sangrado agudo activo. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Se identifica distorsión del tercio medio y distal del músculo cuádriceps, tanto en su parte anterior, como en su parte lateral, en relación con lesión muscular con mayor afectación del vasto del cuádriceps; también hay distorsión de la parte más inferior del músculo bíceps femoral, por lo que se sospecha lesión parcial del mismo, la mayoría del sangrado es en el interior del vasto lateral del cuádriceps, con pérdida de tejido en la parte anterior extensa que sugiere exposicion mucular, asociado a algunas imagenes densas puntiformes que sugiren cuerpos extraños.
Enfisema subcutáneo generalizado.
En el muslo no se definen fracturas.
Núcleos epifisarios presentes, conservados.
Derrame articular en la rodilla
Distorsión de los tejidos blandos anteriores de la rodilla, tanto medial como lateral, que sugiere solución de continuidad extensa.
No se definen fracturas.
Lo visualizado de las estructuras venosas se conserva.
CONCLUSIÓN:
Sangrado agudo activo abundante, con extravasación del medio de contraste en la cara lateral del tercio medio y distal del muslo izquierdo, secundario a lesión vascular de arterias musculares, ramas de la arteria femoral profunda izquierda. Probablemente se trate de rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral derecha y arteria del cuádriceps.
Edema y distorsión, mal definición de los tejidos blandos de la cara lateral del tercio medio y distal del muslo, también de la rodilla de predominio anterior, que sugiere solución de continuidad extensa con exposición muscular.
Irregularidad del tercio medio y distal del músculo cuádriceps en el lado izquierdo en relación con lesión muscular que afecta sobre todo el vasto lateral del cuadriceps.
Distorsión de la parte inferior del músculo bíceps femoral izquierdo que sugiere lesion parcial del mismo.
En forma adicional, en lo visualizado de la pelvis se identifica: fracturas de las ramas ilio/isquiopúbica izquierda, no desplazadas.
Fractura del cuerpo vertebral de L4 y de la apófisis transversa izquierda de L3.
Informe firmado electrónicamente por:
LINA MARIA CIFUENTES
MÉDICO RADIÓLOGO
No. registro: 38555658
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 11:34

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE TORAX
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
DOSIS DE RADIACIÓN: DLP 0.499 mGy.
HALLAZGOS:
Silueta cardiomediastínica normal.
La vascularización pulmonar es normal.
La transparencia pleuropulmonar es satisfactoria.
Estructuras óseas normales.
CONCLUSIÓN:
ESTUDIO DENTRO DE LÍMITES NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:06

ESTUDIO: TAC DE ABDOMEN TOTAL CONTRASTADO
NOMBRE: YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO
DOCUMENTO: PT 7527774 EDAD: 10 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-04
ENTIDAD:
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
TÉCNICA:
Con tomógrafo multidetector se realizan cortes axiales desde la base del tórax hasta la sínfisis púbica previa administración de medio de contraste yodado no iónico por vía endovenosa.
HALLAZGOS:
Hígado de volumen y morfología habituales, sin lesiones focales del parénquima.
Vesícula biliar distendida de aspecto usual.
La vía biliar intra y extrahepática es de calibre normal.
Páncreas sin alteración.
Bazo de volumen y morfología habituales sin lesiones focales.
Riñones que concentran y eliminan adecuadamente el medio de contraste sin lesiones focales del parénquima ni dilatación de los sistemas colectores.
Glándulas suprarrenales normales.
Vasos retroperitoneales normales.
Vejiga adecuadamente distendida de aspecto habitual.
No se identifican lesiones estenosantes ni compresiones extrínsecas a nivel intestinal.
No hay líquido libre intraabdominal.
No hay cámaras de neumoperitoneo.
Con ventana ósea se observa trazo de fractura a nivel de cuerpo vertebral de L4.
CONCLUSIÓN:
1. FRACTURA DE CUERPO VERTEBRAL DE L4. SE SUGIERE COMPLEMENTO CON TOMOGRAFÍA LUMBOSACRA.
Informe firmado electrónicamente por:
GUSTAVO ENRIQUE AGUILAR PALACIOS
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 151601
Fecha y hora de firma: 05-03-2026 07:01

2026-03-09 16:17	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

N° Orden: Orden: 202603080169
.- MUESTRA MEMO
PRELIMINAR 24 HORAS NGETIVO A LAS 24 HORAS
PRELIMINAR 48 HORAS ********** Pendiente **********
PRELIMINAR 72 HORAS********** Pendiente **********
REPORTE FINAL ********** Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO #1

N° Orden: Orden: 202603050091
.- MUESTRA MEMO
PRELIMINAR 24 HORAS NGETIVO A LAS 24 HORAS
PRELIMINAR 48 HORAS ********** Pendiente **********
PRELIMINAR 72 HORAS********** Pendiente **********
REPORTE FINAL ********** Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO #2

CULTIVO SECRECION MUSLO IZQUIERDO

TIPO DE MUESTRA ********** Pendiente **********
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h ********** Pendiente **********
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h ********** Pendiente **********
REPORTE FINAL SEC Pendiente

SIN AISLAMIENTO REPORTE MICROBIOLOGICO SE COMENTA CON INFECTOLOGIA
PACIENTE CON RIESGO DE SEPSIS POR MULTIPLE INVASION LESIONES PROBABLE NECROTICA DE MUSLO IZQUIERDO RIESGO DE ZONAS DE PRESION DE BACTERIEMIA SE COMENTARA CON COMITE DE INFECCIONES

DE ORDEN 202603090039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:35
GASES VENOSOS
pH 7.424
PCO2 38.8 mmHg
pO2 41.5 mmHg
HCO3act 24.8 mmol/L
BE(B) 0.5 mmol/L
SO2 77.3 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvCO2 NORMAL, PvO2 NORMAL, BICARBONATO NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2.

DE ORDEN 202603090029
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:14
INR 0.87
TIEMPO DE PROTROMBINA 9.3 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 30.0 seg
TIEMPOS DE COAGULACION EN RANGOS DE NORMALIDAD

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 85.6 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 34.1 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.3 um3
RDW CV 14.3 %
MPV 8.7 um3
NEUTROFILOS Abs 3.78
LINFOCITOS Abs 2.66
MONOCITOS Abs 0.72
EOSINOFILOS Abs 0.07
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 51.0 %
LINFOCITOS % 35.8 %
MONOCITOS % 9.7 %
EOSINOFILOS % 1.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.7 %
HEMOGLOBINA 9.1 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 7.42 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 254 X10³/mm³
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOSITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA CON HEMATOCRITO NO CRITICO

DE ORDEN 202603080170
HEMOCULTIVO #2 MSD
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080169
HEMOCULTIVO#1 LINEA ARTERIAL FEMORAL
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080168
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:14
PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO 1.88 ng/ml ELEVADA DISCRETAMENTE. PLAN: POR AHORA CONTINUAR CON AMPICILINA SULBACTAM.

ORDEN: 202603080040
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:44
ACIDO LACTICO 1.12 DEPURADO
CALCIO IONICO 1.13 LIMITE INFERIOR
PH: 7.32, PCO2: 35, CO2: 47.7, HCO3: 17.9M SO2: 79.8, GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICA , SATURACION VENOSA CENTRAL ALTA , CHOQUE VASODILATADO EN MANEJO CON VASOPRESINA.

#ORDEN 202603080039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:43
ELECTROLIOS EN RANGO DE NORMALIDAD
CLORO 104.0
FOSFORO 5.50
POTASIO 3.60
SODIO 140.0

HEMGORAMA SIN LEUCOCITOISS NI NEUTROFIA, HB ESTABLE POSTERIOR A PROCEDIMIENTO, PLAQUETAS EN RANGO DE SEGURIDAD.
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.15
MCV 86.4
MCH 29.0
MCHC 33.5
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9
RDW SD 45.1
RDW CV 14.3
MPV 9.1
NEUTROFILOS Abs 4.19
LINFOCITOS Abs 0.81
MONOCITOS Abs 0.28
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 78.4
LINFOCITOS % 15.2
MONOCITOS % 5.3
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 27.2
HEMOGLOBINA 9.1
RECUENTO DE LEUCOCITOS 5.34
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 177

ORDEN 202603070122
GASES VENOSOS
pH 7.399
PCO2 37.1 mmHg
pO2 35.8 mmol/L
HCO3act 22.4 mmol/L
BE(B) -2.1 mmol/L
SO2 70.8 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2, DELTA DE CO2 5 MMHG NORMAL

ORDEN 202603070121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 08:44
GASES ARTERIALES
pH 7.436
PCO2 32.1 mmHg
pO2 78.9 mmHG
HCO3act 21.1 mmol/L
BE(B) -2.6 mmol/L
SO2 95.6 %
pO2/FiO2 3.29 mmHg
FIO2 24.0 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, HIPOCAPNIA LEVE, NORMOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR.

ORDEN 202603070100
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:54
CLORO 102.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1311.0 U/L ELEVADA, PERO EN DESCENSO RESPECTO A LA PREVIA.
FOSFORO 3.60 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.50 mg/dl HIPOMAGNESEMIA LEVE
POTASIO 3.00 mmol/L HIPOCALEMIA LEVE, SE INICIA REPOSICION CON KATROL 15 MEQ EN INFUSION DE LEV.
SODIO 138.0 mmol/L NORMAL

INR 1.44
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.7 seg
INR EN LIMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD, PT Y PTT LIGERAMENTE PROLONADOS.

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 86.0 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 33.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.2 um3
RDW CV 14.4 %
MPV 9.2 um3
NEUTROFILOS Abs 3.51
LINFOCITOS Abs 2.08
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.05
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 53.0 %
LINFOCITOS % 31.3 %
MONOCITOS % 13.4 %
EOSINOFILOS % 0.8 %
BASOFILOS % 0.1 %

HEMATOCRITO 26.8 %
HEMOGLOBINA 9.0 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 6.63 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 147 X10³/mm³
TROMBOCITOPENIA LEVE, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL

ORDEN 202603070099
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:51
ACIDO LACTICO 0.94 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.17 mmol/L NORMAL

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29

DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO

GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %

NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

REPORTE FINAL NEGATIVO
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h NEGATIVA
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO

HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-10 07:29	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

****** REPORTE DE PARACLINICOS ********

CULTIVO SECRECION MUSLO IZQUIERDO N° Orden: 202603090162 - Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 11:24

TIPO DE MUESTRA ********** Pendiente **********
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h ********** Pendiente **********
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h ********** Pendiente **********
REPORTE FINAL SEC Pendiente

N° Orden:: 202603080169 - Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:15
.- MUESTRA MEMO
PRELIMINAR 24 HORAS NGETIVO A LAS 24 HORAS
PRELIMINAR 48 HORAS ********** Pendiente **********
PRELIMINAR 72 HORAS********** Pendiente **********
REPORTE FINAL ********** Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO #1

N° Orden: 202603050091 - Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:16
.- MUESTRA MEMO
PRELIMINAR 24 HORAS NGETIVO A LAS 24 HORAS
PRELIMINAR 48 HORAS ********** Pendiente **********
PRELIMINAR 72 HORAS********** Pendiente **********
REPORTE FINAL ********** Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO #2

SIN AISLAMIENTO REPORTE MICROBIOLOGICO SE COMENTA CON INFECTOLOGIA
PACIENTE CON RIESGO DE SEPSIS POR MULTIPLE INVASION LESIONES PROBABLE NECROTICA DE MUSLO IZQUIERDO RIESGO DE ZONAS DE PRESION DE BACTERIEMIA SE COMENTARA CON COMITE DE INFECCIONES

DE ORDEN 202603090039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:35
GASES VENOSOS
pH 7.424
PCO2 38.8 mmHg
pO2 41.5 mmHg
HCO3act 24.8 mmol/L
BE(B) 0.5 mmol/L
SO2 77.3 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvCO2 NORMAL, PvO2 NORMAL, BICARBONATO NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2.

DE ORDEN 202603090029
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:14
INR 0.87
TIEMPO DE PROTROMBINA 9.3 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 30.0 seg
TIEMPOS DE COAGULACION EN RANGOS DE NORMALIDAD

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 85.6 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 34.1 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.3 um3
RDW CV 14.3 %
MPV 8.7 um3
NEUTROFILOS Abs 3.78
LINFOCITOS Abs 2.66
MONOCITOS Abs 0.72
EOSINOFILOS Abs 0.07
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 51.0 %
LINFOCITOS % 35.8 %
MONOCITOS % 9.7 %
EOSINOFILOS % 1.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.7 %
HEMOGLOBINA 9.1 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 7.42 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 254 X10³/mm³
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOSITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA CON HEMATOCRITO NO CRITICO

DE ORDEN 202603080170
HEMOCULTIVO #2 MSD
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080169
HEMOCULTIVO#1 LINEA ARTERIAL FEMORAL
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente
REPORTE FINAL Pendiente
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente

ORDEN 202603080168
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:14
PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO 1.88 ng/ml ELEVADA DISCRETAMENTE. PLAN: POR AHORA CONTINUAR CON AMPICILINA SULBACTAM.

ORDEN: 202603080040
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:44
ACIDO LACTICO 1.12 DEPURADO
CALCIO IONICO 1.13 LIMITE INFERIOR
PH: 7.32, PCO2: 35, CO2: 47.7, HCO3: 17.9M SO2: 79.8, GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICA , SATURACION VENOSA CENTRAL ALTA , CHOQUE VASODILATADO EN MANEJO CON VASOPRESINA.

#ORDEN 202603080039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:43

ELECTROLIOS EN RANGO DE NORMALIDAD
CLORO 104.0
FOSFORO 5.50
POTASIO 3.60
SODIO 140.0

HEMGORAMA SIN LEUCOCITOISS NI NEUTROFIA, HB ESTABLE POSTERIOR A PROCEDIMIENTO, PLAQUETAS EN RANGO DE SEGURIDAD.
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.15
MCV 86.4
MCH 29.0
MCHC 33.5
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9
RDW SD 45.1
RDW CV 14.3
MPV 9.1
NEUTROFILOS Abs 4.19
LINFOCITOS Abs 0.81
MONOCITOS Abs 0.28
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 78.4
LINFOCITOS % 15.2
MONOCITOS % 5.3
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 27.2
HEMOGLOBINA 9.1
RECUENTO DE LEUCOCITOS 5.34
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 177

ORDEN 202603070122
GASES VENOSOS
pH 7.399
PCO2 37.1 mmHg
pO2 35.8 mmol/L
HCO3act 22.4 mmol/L
BE(B) -2.1 mmol/L
SO2 70.8 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2, DELTA DE CO2 5 MMHG NORMAL

ORDEN 202603070121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 08:44
GASES ARTERIALES
pH 7.436
PCO2 32.1 mmHg
pO2 78.9 mmHG
HCO3act 21.1 mmol/L
BE(B) -2.6 mmol/L
SO2 95.6 %
pO2/FiO2 3.29 mmHg
FIO2 24.0 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, HIPOCAPNIA LEVE, NORMOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR.

ORDEN 202603070100
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:54
CLORO 102.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1311.0 U/L ELEVADA, PERO EN DESCENSO RESPECTO A LA PREVIA.
FOSFORO 3.60 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.50 mg/dl HIPOMAGNESEMIA LEVE
POTASIO 3.00 mmol/L HIPOCALEMIA LEVE, SE INICIA REPOSICION CON KATROL 15 MEQ EN INFUSION DE LEV.
SODIO 138.0 mmol/L NORMAL

INR 1.44
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.7 seg
INR EN LIMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD, PT Y PTT LIGERAMENTE PROLONADOS.

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 86.0 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 33.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.2 um3
RDW CV 14.4 %
MPV 9.2 um3
NEUTROFILOS Abs 3.51
LINFOCITOS Abs 2.08
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.05
BASOFILOS Abs 0.01

NEUTROFILOS % 53.0 %
LINFOCITOS % 31.3 %
MONOCITOS % 13.4 %
EOSINOFILOS % 0.8 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.8 %
HEMOGLOBINA 9.0 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 6.63 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 147 X10³/mm³
TROMBOCITOPENIA LEVE, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL

ORDEN 202603070099
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:51
ACIDO LACTICO 0.94 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.17 mmol/L NORMAL

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL
pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L

BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6
mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %
pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18
TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³

NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

202603050091

CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO******

REPORTE FINAL NEGATIVO
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 48h NEGATIVA
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

2026-03-10 09:11	**PROFESIONAL:** marmulta - MARIA GISELL MURILLO TAMAYO	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

TERAPIA RESPIRATORIA DIA

PACIENTE YESHIA VALENTINA RODRIGUEZ CASTILLO DE GENERO FEMENINO DE 10 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICOS MEDICOS ANOTADOS PREVIAMENTE EN LA HISTORIA CLINICA, ENCUENTRO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES DE SALUD EN GENERAL, HEMODINAMICAMENTE INESTABLE, SOPORTADA CON VASOPRESINA, CON SEDACION CONSCIENTE, DAD POR PRECEDEXEN EL SISTEMA NEUROLOGICO SE ENCUENTRA, SIN SIGNOS DE FOCALIZACIÓN NEUROLÓGICA, EN EL SISTEMA CARDIVASCULAR SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES SIGNOS VITALES: TA 120/78, FC 125, FR 20, EN EL SISTEMA PULMONAR SE ENCUENTRA SIN SOPORTE DE OXIGENO SUPLEMENTARIO, AIRE AMBIENTE, FIO2 21%, SATURANDO ENTRE 97-99 A LA AUSCULTACION SE ENCUENTRA MRMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, SIN RUIDOS SOBREAGREGADOS, TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE, PATRON RESPIRATORIO RITMICO TORACOABDOMINAL SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

OBJETIVOS:
FAVORECER LA REEXPANSION PULMONAR.
MITIGAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA
--MONITORIA RESPIRATORIA
--POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER A 45°
--FISIOTERAPIA RESPIRARTORIA CON MOVILIZACIÓN DE REJA COSTAL
--ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO LENTO COMO TECNICA DE DESOBTRUCCION BRONQUIAL

PACIENTE TOLERA INTERVENCION, QUEDA ESTABLE DENTRO DE SU CUADRO CLÍNICO.

2026-03-10 14:15	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

** NOTA MEDICA **

PACIENTE QUIEN RETORNA PROCEDENTE DE LA CLINICA COLOMBIA DONDE REALIZAN LA TOMA DE RMN DE COLUMUNA LUMBAR, PACIENTE REINGRESA A UNIDAD EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, SIN REQUERIR NINGUN TIPO DE SOPORTE CLINICAMENTE ESTABLE.

2026-03-11 01:51	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

***** REPORTE DE PARACLINICOS *****

HEMOCULTIVO#3: MSD PLIEGUE
No orden: 202603110053 Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-11 01:28
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente **********
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente **********
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente **********
REPORTE FINAL Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente **********

HEMOCULTIVO#2 CVC LUMEN PROXIMAL
No ORDEN: 202603110052 Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-11 01:27
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente **********
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente **********
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente **********
REPORTE FINAL Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente **********

HEMOCULTIVO#1: CVC LUMEN DISTAL
No ORDEN: 202603110051 fecha y Hora de ingreso: 2026-03-11 01:26
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS Pendiente **********
PRELIMINAR 48 HORAS Pendiente **********
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente **********
REPORTE FINAL Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente **********

CULTIVO SECRECION MUSLO IZQUIERDO
N° Orden: 202603090162 - Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 11:24

REPORTE PRELIMINAR CULTIVO pendiente **********
REPORTE PRELIMINAR CULTIVO 24h NEGATIVO
REPORTE FINAL SEC Pendiente **********

N° Orden:: 202603080169 - Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:15
.- MUESTRA MEMO LINEA ARTERIAL
PRELIMINAR 24 HORAS NEGATIVO A LAS 24 HORAS
PRELIMINAR 48 HORAS NEGATIVO
PRELIMINAR 72 HORAS********** Pendiente **********
REPORTE FINAL ********** Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO #1

SIN AISLAMIENTO REPORTE MICROBIOLOGICO SE COMENTA CON INFECTOLOGIA
PACIENTE CON RIESGO DE SEPSIS POR MULTIPLE INVASION LESIONES PROBABLE NECROTICA DE MUSLO IZQUIERDO RIESGO DE ZONAS DE PRESION DE BACTERIEMIA SE COMENTARA CON COMITE DE INFECCIONES

DE ORDEN 202603090039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:35
GASES VENOSOS
pH 7.424
PCO2 38.8 mmHg
pO2 41.5 mmHg
HCO3act 24.8 mmol/L
BE(B) 0.5 mmol/L
SO2 77.3 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvCO2 NORMAL, PvO2 NORMAL, BICARBONATO NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2.

DE ORDEN 202603090029
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-09 01:14
INR 0.87
TIEMPO DE PROTROMBINA 9.3 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 30.0 seg
TIEMPOS DE COAGULACION EN RANGOS DE NORMALIDAD

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 85.6 um3
MCH 29.0 pg

MCHC 34.1 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.3 um3
RDW CV 14.3 %
MPV 8.7 um3
NEUTROFILOS Abs 3.78
LINFOCITOS Abs 2.66
MONOCITOS Abs 0.72
EOSINOFILOS Abs 0.07
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 51.0 %
LINFOCITOS % 35.8 %
MONOCITOS % 9.7 %
EOSINOFILOS % 1.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.7 %
HEMOGLOBINA 9.1 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 7.42 $X10^3/mm^3$
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 254 $X10^3/mm^3$
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOSITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA CON HEMATOCRITO NO CRITICO

DE ORDEN 202603080170
HEMOCULTIVO #2 MSD
MUESTRA Pendiente
PRELIMINAR 24 HORAS NEGATIVO
PRELIMINAR 48 HORAS NEGATIVO
PRELIMINAR 72 HORAS Pendiente **********
REPORTE FINAL Pendiente **********
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO Pendiente **********

ORDEN 202603080168
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:14
PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO 1.88 ng/ml ELEVADA DISCRETAMENTE. PLAN: POR AHORA CONTINUAR CON AMPICILINA SULBACTAM.

ORDEN: 202603080040
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:44
ACIDO LACTICO 1.12 DEPURADO
CALCIO IONICO 1.13 LIMITE INFERIOR
PH: 7.32, PCO2: 35, CO2: 47.7, HCO3: 17.9M SO2: 79.8, GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICA , SATURACION VENOSA CENTRAL ALTA , CHOQUE VASODILATADO EN MANEJO CON VASOPRESINA.

#ORDEN 202603080039
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 01:43
ELECTROLIOS EN RANGO DE NORMALIDAD
CLORO 104.0
FOSFORO 5.50
POTASIO 3.60
SODIO 140.0

HEMGORAMA SIN LEUCOCITOISS NI NEUTROFIA, HB ESTABLE POSTERIOR A PROCEDIMIENTO, PLAQUETAS EN RANGO DE SEGURIDAD.
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.15
MCV 86.4
MCH 29.0
MCHC 33.5
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9
RDW SD 45.1
RDW CV 14.3
MPV 9.1
NEUTROFILOS Abs 4.19
LINFOCITOS Abs 0.81
MONOCITOS Abs 0.28
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 78.4
LINFOCITOS % 15.2
MONOCITOS % 5.3
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.1
HEMATOCRITO 27.2
HEMOGLOBINA 9.1
RECUENTO DE LEUCOCITOS 5.34
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 177

ORDEN 202603070122
GASES VENOSOS
pH 7.399
PCO2 37.1 mmHg

pO2 35.8 mmol/L
HCO3act 22.4 mmol/L
BE(B) -2.1 mmol/L
SO2 70.8 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, ADECUADA EXTRACCION DE O2, DELTA DE CO2 5 MMHG NORMAL

ORDEN 202603070121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 08:44
GASES ARTERIALES
pH 7.436
PCO2 32.1 mmHg
pO2 78.9 mmHG
HCO3act 21.1 mmol/L
BE(B) -2.6 mmol/L
SO2 95.6 %
pO2/FiO2 3.29 mmHg
FIO2 24.0 %
EQUILIBRIO ACIDO BASE, HIPOCAPNIA LEVE, NORMOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR.

ORDEN 202603070100
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:54
CLORO 102.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1311.0 U/L ELEVADA, PERO EN DESCENSO RESPECTO A LA PREVIA.
FOSFORO 3.60 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.50 mg/dl HIPOMAGNESEMIA LEVE
POTASIO 3.00 mmol/L HIPOCALEMIA LEVE, SE INICIA REPOSICION CON KATROL 15 MEQ EN INFUSION DE LEV.
SODIO 138.0 mmol/L NORMAL

INR 1.44
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.7 seg
INR EN LIMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD, PT Y PTT LIGERAMENTE PROLONADOS.

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.12 X10*6/mm³
MCV 86.0 um3
MCH 29.0 pg
MCHC 33.6 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.9 %
RDW SD 45.2 um3
RDW CV 14.4 %
MPV 9.2 um3
NEUTROFILOS Abs 3.51
LINFOCITOS Abs 2.08
MONOCITOS Abs 0.89
EOSINOFILOS Abs 0.05
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 53.0 %
LINFOCITOS % 31.3 %
MONOCITOS % 13.4 %
EOSINOFILOS % 0.8 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.8 %
HEMOGLOBINA 9.0 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 6.63 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 147 X10³/mm³
TROMBOCITOPENIA LEVE, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, SIN CRITERIO TRANSFUSIONAL

ORDEN 202603070099
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-07 05:51
ACIDO LACTICO 0.94 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.17 mmol/L NORMAL

202603060176
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 12:25
GASES ARTERIALES
pH 7.344
PCO2 35.8 mmHg
pO2 107.6 mmol/L
HCO3act 19.1 mmol/L
HCO3std 19.5 mmol/L
BE(B) -6.0 mmol/L
BE(ecf) -6.7 mmol/L
ctCO2 20.2 mmol/L
SO2 97.4 %
FO2Hb 96.8 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.6 %
pO2/FiO2 3.84 mmHg
ctO2(a) 14.7 mL

pH(T) 7.351
pCO2(T) 35.0 mmHg
pO2(T) 104.6 mmHg
pO2(Aa)(T) 28.9 mmHg
AnGaP 12.8 mmol/L
mOsm 285.2 mOsm/Kg
TEMP 36.5 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 28.0
lactato serico de 1,8 mmol / l
gases para test de ventilacion espontanea adecuada oxigenacion y ventilacion lactato serico normal se indica extubacion programada

202603060150
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 09:15
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:3232984
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:19/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:02/02/2026

ORDEN 202603060147
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-06 08:45
TIEMPO DE PROTROMBINA 14.8 * 8.9 - 11.9 seg
Se sugiere correlación clínica.
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
13.1
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.44
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 36.6 * 24.5 - 33.8 seg
Deteccion Mecanica del Coagulo. Equipo STA COMPACT MAX
PTT CONTROL DIA 25.0
MEJORIA DE LA COAGULOPATIA POR TRAUMA NO REQUIERE SOPORTE DE HEMODERIVADOS

ORDEN 202603060134 - 2026-03-06
ACIDO LACTICO 1.87 mmol/L NORMAL
CALCIO IONICO 1.09 mmol/L HIPOCALCEMIA LEVE A MODERADA, SE VALORA REPOSICION.

GASES VENOSOS
pH 7.314
PCO2 37.0 mmHg
pO2 57.3 mmHg
HCO3act 18.4 mmol/L
BE(B) -7.2 mmol/L
SO2 87.7 %
ACIDEMIA METABOLICA, PvO2 NORMAL, PvCO2 NORMAL, DEFICIT DE BASE, HIPOBICARBONATEMIA, SvO2 ELEVADA EN RELACION A MENOR EXTRACCION DE O2 POR ESTADO DE CHOQUE MIXTO.

ORDEN 202603060133 - 2026-03-06

CLORO 108.0 mmol/L NORMAL
CPK TOTAL 1469.0 U/L ELEVADA, EN DESCENSO.
FOSFORO 4.30 mg/dl NORMAL
MAGNESIO 1.70 mg/dl NORMAL
POTASIO 4.10 mmol/L NORMAL
SODIO 136.0 mmol/L NORMAL

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.08 X10*6/mm³
MCV 84.5 um3
MCH 28.8 pg
MCHC 34.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.0 %
RDW SD 44.7 um3
RDW CV 14.5 %
MPV 9.8 um3
NEUTROFILOS Abs 6.44
LINFOCITOS Abs 2.12
MONOCITOS Abs 1.27
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.01
NEUTROFILOS % 65.1 %
LINFOCITOS % 21.4 %
MONOCITOS % 12.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 26.0 %
HEMOGLOBINA 8.9 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 9.90 X10³/mm³

RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 159 X10³/mm³
ANEMIA MODERADA NORMOCITICA, LEUCOCITOS EN RANGOS DE NORMALIDAD, CONTEO PLAQUETARIO NORMAL.

N° Orden: 202603050243 - FECHA 05/03/2026

.- HEMOGRAMA (ANEMIA NORMOCITICA NORMOCROMICA , CON LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA)

RECUENTO DE ERITROCITOS 3.28
MCV 83.4
MCH 28.9
MCHC 34.7
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8
RDW SD 43.8
RDW CV 14.2
MPV 8.8
NEUTROFILOS Abs 8.52
LINFOCITOS Abs 2.34
MONOCITOS Abs 1.38
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.00
NEUTROFILOS % 68.1
LINFOCITOS % 18.7
MONOCITOS % 11.0
EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.0
HEMATOCRITO 27.4
HEMOGLOBINA 9.5
RECUENTO DE LEUCOCITOS 12.52
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 157

.- TIEMPOS DE COAGULACION (NORMALES)

INR 1.77
TIEMPO DE PROTROMBINA 17.9
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 45.6

.- ELECTROLITOS

CLORO 111.0
FOSFORO 5.80
MAGNESIO 1.60
POTASIO 4.30
SODIO 140.0

TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 70.0 (NORMAL)
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 111.0 (NORMAL)

.- CPK TOTAL 2699.0 (AUMENTADO)

.- FUNCION RENAL (CONSERVADO)

NITROGENO UREICO 13.0
CREATININA SERICA 0.50

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.070 negativa

N° Orden: 202603050242

.- GASES ARTERIALES (ACIDOSIS METABOLICA DESCOMPENSADA SIN HIPOXEMIA, SIN DISFUNCION PULMONAR)

pH 7.323
PCO2 38.8
pO2 152.6
HCO3act 19.7
HCO3std 19.6
BE(B) -5.9
BE(ecf) -6.4
ctCO2 20.9
tHb 10.3
SO2 98.3
FO2Hb 97.6
FCOHb 0.3
FMetHb 0.4
FHHb 1.7
pO2/FiO2 3.82
ctO2(a) 14.5
pH(T) 7.324
pCO2(T) 38.6
pO2(T) 152.0
pO2(Aa)(T) 52.9
AnGaP 9.6

mOsm 286.0
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

N° Orden: 202603050241

ACIDO LACTICO 1.27 - NORMAL
CALCIO IONICO 1.07 BAJO

.- GASES VENOSOS (DELTA DE CO2: 3.5 NORMAL)

pH 7.271
PCO2 42.3
pO2 41.7
HCO3act 19.0
HCO3std 18.0
BE(B) -7.4
BE(ecf) -7.9
ctCO2 20.3
tHb 10.5
SO2 74.4
FO2Hb 73.7
FCOHb 0.5
FMetHb 0.4
FHHb 25.4
pO2/FiO2 1.04
ctO2(a) ----
pH(T) 7.272
pCO2(T) 42.1
pO2(T) 41.4
pO2(Aa)(T) ----
AnGaP 10.6
mOsm 286.2
TEMP 36.9
pAtm 670
FIO2 40.0

202603050178
Orden Número: 202603050178
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:59

DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD:3137234
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:10/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:10/11/2026

202603050173

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 12:29
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD:26020253
GRUPO SANGUINEO:O POSITIVO
FECHA DE EXTRACCION:28/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:11/03/2026

202603050172

HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR MICROTECNICA POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050160

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:21
ACIDO LACTICO 2.12
GASES VENOSOS
pH 7.297
PCO2 45.8 mmHg
pO2 28.4 mmol/L
HCO3act 21.9 mmol/L
HCO3std 20.1 mmol/L
BE(B) -4.5 mmol/L
BE(ecf) -4.6 mmol/L
ctCO2 23.3 mmol/L
SO2 54.7 %
FO2Hb 54.0 %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.5 %
FHHb 44.7 %

pO2/FiO2 0.95 mmHg
ctO2(a) 7.6 mL
pH(T) 7.297
pCO2(T) 45.8 mmHg
pO2(T) 28.4 mmHg
pO2(Aa)(T) 104.7 mmHg
AnGaP 9.5 mmol/L
mOsm 281.4 mOsm/Kg
TEMP 37.0 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
ACIDOSIS METABOICA HIPOXEMIA VENOSA

202603050159

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 10:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.06 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 8.6 * 10 - 14.5 g/dl
SE SUGIERE CORRELACIONAR CON LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
HEMATOCRITO 25.5 * 30 - 45 %
MCV 83.2 76 - 90 um3
MCH 28.2 25 - 32 pg
MCHC 33.7 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 43.8 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 218 150 - 500 X10³/mm³
MPV 8.6 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.8 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.78 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 13.9 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 12.9 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.0 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.85 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.50 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.39 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.00 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00
DESCENSO DE HEMOGLOBINA SE INDICA TRANSFUNDIR RECUENTO DE PLAQUETAS NORMAL

202603050130

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:22
ACIDO LACTICO 2.01
DEPURANDO
GASES VENOSOS
pH 7.331
PCO2 41.8 mmHg
pO2 30.2 mmol/L
HCO3act 21.6 mmol/L
HCO3std 20.4 mmol/L
BE(B) -4.1 mmol/L
BE(ecf) -4.3 mmol/L
ctCO2 22.9 mmol/L
SO2 61.6 %
FO2Hb 61.2 %
FCOHb 0.3 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 38.2 %
pO2/FiO2 1.01 mmHg
ctO2(a) 10.0 mL
pH(T) 7.344
pCO2(T) 40.2 mmHg
pO2(T) 28.3 mmHg
pO2(Aa)(T) 112.0 mmHg
AnGaP 11.9 mmol/L
mOsm 283.2 mOsm/Kg
TEMP 36.1 ºC
pAtm 670 mmHg
FIO2 30.0
HIPOXEMIA VENOSA ADECUADA VENTILACION

202603050129

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 07:18

TROPONINA I CUANTITATIVA 0.117
POSITIVA
NITROGENO UREICO 13.0 7 - 17 mg/dl
CREATININA SERICA 0.50
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 12.8 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.23
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 38.9 * 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 27.0
NORMAL

202603050125

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:25
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA O

202603050123

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 06:22
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 3.85 * 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 11.1 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 32.3 30 - 45 %
MCV 84.0 76 - 90 um3
MCH 28.8 25 - 32 pg
MCHC 34.4 32 - 36 g/dl
RDW CV 13.9 11 - 15.5 %
RDW SD 43.3 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 264 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.1 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 15.7 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 10.84 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 72.8 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 11.6 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 13.4 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 0.1 * 2 - 3 %
BASOFILOS % 0.0 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 7.89 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 1.26 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 1.45 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.01 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.00 0 - 0.2
HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETAS NORMALES LEUCOCITOS EN MODULACION
CLORO 104.0 98 - 107 mmol/L
NORMAL
NITROGENO UREICO 12.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
POTASIO 4.50 3.5 - 5.1 mmol/L
NORMAL
SODIO 135.0 *
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
CPK TOTAL 4060.0
ELEVADA

N° Orden: 202603050091 - Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 10:16
.- CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO
PRELIMINAR 24 HORAS NGETIVO A LAS 24 HORAS
PRELIMINAR 48 HORAS NEGATIVO
PRELIMINAR 72 HORAS NEGATIVO
REPORTE FIN NEGATIVO
HEMOCULTIVO MUESTRA NUMERO #2

202603050024

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:12
DESPACHO PLAQUETAS

SELLO UNIDAD: 26060266B
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603050023

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-05 01:11
DESPACHO PLAQUETAS
SELLO UNIDAD: 26060266A
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2026

202603040217

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3095524
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2026

202603040216

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:59
DESPACHO PLASMA
SELLO UNIDAD: 3107933
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2026

202603040213

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
DESPACHO GRPL
SELLO UNIDAD: B26009069
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040212

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 23:31
SELLO UNIDAD: 3229633
GRUPO SANGUINEO: O POSITIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2026

202603040210

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:53
HEMOCLASIFICACION RESERVA Y SOLICITUD
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D POR
MICROTECNICA
POSITIVO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO INVERSA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO DIRECTA O
GLOBULAR POR MICROTECNICA
O

202603040206

Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-04 22:19
CUADRO HEMATICO
CUADRO ROJO
RECUENTO DE ERITROCITOS 5.00 4.29 - 5.5 X10*6/mm³
HEMOGLOBINA 13.6 10 - 14.5 g/dl
HEMATOCRITO 40.2 30 - 45 %
MCV 80.4 76 - 90 um3
MCH 27.3 25 - 32 pg
MCHC 33.8 32 - 36 g/dl
RDW CV 14.2 11 - 15.5 %
RDW SD 42.5 um3
PLAQUETAS
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 383 150 - 500 X10³/mm³
MPV 9.2 6.4 - 13 um3
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.1 %
CUADRO BLANCO
RECUENTO DE LEUCOCITOS 24.67 * 5.1 - 12.4 X10³/mm³
NEUTROFILOS % 68.7 * 35.53 - 49.6 %
LINFOCITOS % 25.0 * 40.6 - 63.7 %
MONOCITOS % 3.6 * 4 - 10 %
EOSINOFILOS % 1.0 * 2 - 3 %

BASOFILOS % 0.1 0 - 1 %
NEUTROFILOS Abs 16.95 * 1.4 - 6.5
LINFOCITOS Abs 6.17 * 1.2 - 3.4
MONOCITOS Abs 0.89 0 - 1.9
EOSINOFILOS Abs 0.25 0 - 0.4
BASOFILOS Abs 0.02 0 - 0.2
LEUCOCITOSIS NEUTROFILIA HEMOGLOBINA ESTABLE RECUENTO DE PLAQUETS NORMAL
GLICEMIA 195.0 * 60 - 100 mg/dl
HIPERGLICEMIA 2 A ESTRESS
NITROGENO UREICO 11.0 7 - 17 mg/dl
NORMAL
TRANSAMINASA PIRUVICA TGP/ALT 152.0
TRANSAMINASA OXALACETICA TGO/AST 292.0 * 15 - 46 U/L
ELEVADA 2 A TRAUMA
CREATININA SERICA 0.50 0.33 - 0.64 mg/dl
NORMAL
TIEMPO DE PROTROMBINA 13.9 * 8.9 - 11.9 seg
NORMAL
PT CONTROL DIA 10.5 seg
INR 1.35
ISI 1.07
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 33.4 24.5 - 33.8 seg
PTT CONTROL DIA 30.0
NORMAL

DIAGNOSTICOS DE EGRESO ASIGNADOS	
CODIGO	DIAGNOSTICO DE EGRESO
S789	AMPUTACION TRAUMATICA DE CADERA Y MUSLO NIVEL NO ESPECIFICADO

FECHA	RESUMEN DEL PLAN TERAPEUTICO
2026-03-04	21:05 angrosnav - ANGIE DANIELA ROSERO NAVARRO ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 500ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 OBSERVACIONES: BOLO DE 500 CC AHORA Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE **Obs: TAC DE CRANEO SIMPLE EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO (EMERGENCIA) Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL) **Obs: TAC TORACOABDOMINAL CONTRASTADO EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO (EMERGENCIA) Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX **Obs: TAC TORACOABDOMINAL CONTRASTADO EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO (EMERGENCIA) Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL) **Obs: PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO (EMERGENCIA) Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL TORACICO LUMBAR O SACRO COMPLEMENTO A MIELOGRAFIA (CADA SEGMENTO) **Obs: TAC DE COLUMNA CERVICAL EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO. EMERGENCIA. Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL TORACICO LUMBAR O SACRO COMPLEMENTO A MIELOGRAFIA (CADA SEGMENTO) **Obs: TAC DE COLUMNA CERVICAL EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO. EMERGENCIA. Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL TORACICO LUMBAR O SACRO COMPLEMENTO A MIELOGRAFIA (CADA SEGMENTO) **Obs: TAC DE COLUMNA CERVICAL EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO. EMERGENCIA. Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL TORACICO LUMBAR O SACRO COMPLEMENTO A MIELOGRAFIA (CADA SEGMENTO) **Obs: TAC DE COLUMNA CERVICAL EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO. EMERGENCIA. Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL TORACICO LUMBAR O SACRO POR CADA NIVEL (TRES ESPACIOS) **Obs: TAC DE COLUMNA CERVICAL EN PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO. EMERGENCIA. MEDICAMENTO FORMULADO: CEFAZOLINA 1G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE VIAL-FARMALOGICA 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 POLVO Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1g AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 MEDICAMENTO FORMULADO: ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML SOLUCION INYECTABLE-SETAA PHARMA AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Dosis Unica, VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500mg/5ml SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 MEDICAMENTO FORMULADO: GENTAMICINA 80MG SOLUCION INYECTABLE X 2ML-PHARMAYECT 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 80 MG AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 21:33 angrosnav - ANGIE DANIELA ROSERO NAVARRO ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
**Obs: ANGIOTAC DE MIEMBROS INFERIORES POR POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO, EMERGENCIA.

21:34 angrosnav - ANGIE DANIELA ROSERO NAVARRO
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: NITROGENO UREICO
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: UROANALISIS
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)
**Obs: POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE D ETRANSITO
Solicitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA EN RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL
**Obs: angiotac de miembros inferiores por politraumatismo en accidente d etransito con sospecha de lesion vascular
Solicitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
**Obs: angiotac de miembros inferiores por politraumatismo en accidente d etransito con sospecha de lesion vascular

22:07 melagugo - MELISSA AGUDELO GOMEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO DIRECTA [HEMOCLASIFICACION GLOBULAR] POR MICROTECNICA
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR MICROTECNICA
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA Rh [ANTIGENO Rh D] POR MICROTECNICA
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES) POR MICROTECNICA
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA POR MICROTECNICA
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE PLAQUETAS
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: ANTICUERPOS IRREGULARES TITULACION POR MICROTECNICA
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS O ERITROCITOS
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes
Solicitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS
**Obs: kit de emergencia reserva de hemocomponentes

22:26 melagugo - MELISSA AGUDELO GOMEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Proc Qx: EXPLORACION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES
**Obs: POLITRA7UMA EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON TRUMA VASCULAR DE AMBOS MIEMBROS INFERIOORES SE SOLICTA EXPLORACION QUIRURGICA
Solicitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLAQUETAS POR AFERESIS
**Obs: KIT DE EMERGENCIA

22:37 angrosnav - ANGIE DANIELA ROSERO NAVARRO
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Proc Qx: EXPLORACION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES
**Obs: POLITRA7UMA EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON TRUMA VASCULAR DE AMBOS MIEMBROS INFERIOORES SE SOLICTA EXPLORACION QUIRURGICA COMO URGENCIA VITAL

22:46 obegetsa - OBEIMAR EFREN GETIAL SALAZAR
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

ORDENES M?DICAS**
-INGRESO UCI
-NADA VIA ORAL
-CUIDADOS DE ENFERMER?A
-CONTROL DE SIGNOS VITALES
-MONITORIA NO INVASIVA

MEDICAMENTOS:
PESO 40 KG APROXIMADOS
-DIPIRONA 1 GR CADA 8 HORAS EV
-OMEPRAZOL 40 MG CADA 24 HORAS EV
-LEV HARTMAN DE 500 CC BOLO INICIAL, DEJAR A 70 CC HORA
- AMPICILINA SULBACTAM 1 GR CADA 8 HORAS E
-ACIDO TRANEXAMICO 500 MG AHORA
-KETAMINA 40 MG DOSIS UNICA EV

SE SOLICITA:
- TAC DE CRANEO SIMPLE
-TAC DE COLUMNA CERVICL
- TAC DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO
-TAC DE ABDOMEN Y PELVIS
-RX DE TORAX PORTATIL
-SANGRAR PARA: HEMOGRAMA PCR, PERFIL HEPATICO, RENAL, ELECTROLITOS, TIEMPOS.
-GASES VENOSOS
-GLUCOMETRIA
-SE SOLICITA VALORACION POR VASCULAR.

SEGUIMIENTO:
-PEDIATR?A/MEDICINA GENERAL

22:50 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO DIRECTA [HEMOCLASIFICACION GLOBULAR] POR MICROTECNICA
**Obs: RESEVA DE 3 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS.
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR MICROTECNICA
**Obs: RESEVA DE 3 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS.
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA Rh [ANTIGENO Rh D] POR MICROTECNICA
**Obs: RESEVA DE 3 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS.
Solucitud Apoyo Dx: ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES) POR MICROTECNICA
**Obs: RESEVA DE 3 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS.
Solucitud Apoyo Dx: PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA POR MICROTECNICA
**Obs: RESEVA DE 3 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS.
Solucitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS
**Obs: RESEVA DE 3 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS.

22:53 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS
**Obs: TRASFUSION DE 1 UNIDAD DE GR URGENCIA VITAL.
Solucitud Apoyo Dx: TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS O ERITROCITOS
**Obs: TRASFUSION DE 1 UNIDAD DE GR URGENCIA VITAL.

23:23 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO UCIP.
PESO APROX: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
NADA POR VIA ORAL.
HARTMAN 1000 CC EN BOLO IV (YA SE PASO). CONTINUAR A 100 CC/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV.
TOXOIDE TETANICO 40 UI, IM. DU.
CEFAZOLINA 1 G, IV. PREQUIRURGICO.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA).
TRASFUNDIR 2 UD DE GLOBULOS ROJOS COMPATIBLES (YA SE TRASFUNDIERON).
TRASFUNDIR 1 UD DE PLASMA.
TRASFUNDIR 1 UD DE PLAQUETAS.
OXIGENO A 2 L/MIN POR CANULA NASAL.
CUIDADOS DE ENFERMERIA.
CUIDADOS DE LA PIEL.
PREVENCION DE ZONAS DE PRESION Y DE CAIDAS.
PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD.
GLUCOMETRIA CADA 6 HORAS.

		MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES. CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS.
	23:25	josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS ESPECIALIDAD: PEDIATRIA MEDICAMENTO FORMULADO: LACTATO DE RINGER X 1000ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1000ml SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 OBSERVACIONES: .... MEDICAMENTO FORMULADO: DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE X 2ML-ECAR 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 OBSERVACIONES: ... MEDICAMENTO FORMULADO: PARACETAMOL 1000MG SOLUCION INYECTABLE 100ML-FRESENIUS 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1000mg SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 OBSERVACIONES: ... MEDICAMENTO FORMULADO: TOXOIDE TETANICO 40 UI/0.5ML SOLUCION INYECTABLE-DELTA 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Dosis Unica, VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 OBSERVACIONES: ... MEDICAMENTO FORMULADO: AMPICILINA 1G + SULBACTAM 0.5G POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR VIAL-FARMALOGICA 1 VIAL - LAB. :VARIOS 1 VIAL Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1g/0,5mg VIAL, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 OBSERVACIONES: ...
	23:44	fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL Solicitud Interconsulta por: CIRUGIA VASCULAR **Obs: PACIENTE CON TRAUMA VASCULAR EN MIEMBRO INFERIOE IZQUIERDO SE SOLICITA CONCEPTO.
2026-03-05	00:09	josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS ESPECIALIDAD: PEDIATRIA NUEVA ORDEN MEDICA .- GLUCONATO DE CALCIO 500 MG IV CADA 8 HORAS .- SS// VALORACION POR TRABAJO SOCIAL - PSICOLOGIA - CIRUGIA PLASTICA .- RESTO DE MANEJO IGUAL GRACIAS !!! MEDICAMENTO FORMULADO: GLUCONATO DE CALCIO 10 % SOLUCION INYECTABLE X 10ML-FRESENIUS 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 8 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 10 AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 OBSERVACIONES: ...
	00:44	anggomga - ANGELA MARIA GOMEZ GARCIA ESPECIALIDAD: ORTOPEDIA PEDIATRICA Solicitud Proc Qx: SECUESTRECTOMIA DRENAJE DESBRIDAMIENTO DE FEMUR VIA ABIERTA **Obs: Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 20% AL 29% DE SUPERFICIE CORPORAL **Obs: Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO CON COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA **Obs: Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL) **Obs: RODILLA IZQUIERDA Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES **Obs: RODILLA IZQUIERDA
	01:11	melagugo - MELISSA AGUDELO GOMEZ ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 500 MG / 10 ML VIAL - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 MEDICAMENTO RE FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 500ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 12 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1 OBSERVACIONES: BOLO DE 500 CC AHORA
	02:04	fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL) **Obs: CONTROL PASO CVC - SE SOLICITA DE MANERA PRIORITARIA. Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL) **Obs: CONTROL PASO CVC - SE SOLICITA DE MANERA PRIORITARIA. Solucitud Apoyo Dx: FLUOROSCOPIA COMO GUIA PARA PROCEDIMIENTOS **Obs: CONTROL PASO CVC - SE SOLICITA DE MANERA PRIORITARIA. Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO **Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED. Solucitud Apoyo Dx: SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS **Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED. Solucitud Apoyo Dx: POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS **Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED. Solucitud Apoyo Dx: CLORO **Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED. Solucitud Apoyo Dx: CREATIN QUINASA TOTAL [CK-CPK]

**Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED.
Solucitud Apoyo Dx: CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED.
Solucitud Apoyo Dx: NITROGENO UREICO
**Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED.
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED.
Solucitud Apoyo Dx: MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA
**Obs: CONTROL POS QUIRURURUGICO UCI PED.

02:12 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
NADA POR VIA ORAL.
HARTMAN A 100 CC/H, IV.
MIDAZOLAM A 2 MCG/KG/MIN, IV.
FENTANILO A 2 MCG/KG/H, IV.
NORADRENALINA A 0.03 MCG/KG/MIN, IV (TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.3 MCG/KG/MIN). INICIAR SI TAM >65 MMHG.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV.
GLUCONATO DE CALCIO 500 MG, C/8H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA).
TRASFUNDIR 1 UD DE PLASMA.
TRASFUNDIR 1 UD DE PLAQUETAS.
VENTILACION MECANICA DINAMICA.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
CUIDADOS DE ENFERMERIA.
CUIDADOS DE LA PIEL.
PREVENCION DE ZONAS DE PRESION Y DE CAIDAS.
PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD.
GLUCOMETRIA CADA 6 HORAS.
VIGILAR PULSOS Y SO2 DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES.
CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS.
REALIZAR ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

02:18 dencobol - DENIS EDMOND COBO OLIVEROS
ESPECIALIDAD: TRAUMATOLOGIA-ORTOPEDIA

Solicitud Proc No Qx: 901217-CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA ORINA Y HECES

02:43 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO FORMULADO: OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE VIAL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE VIAL-BUSSIE 1 VIAL - LAB. :VARIOS 1 POLVO Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 40 MG POLVO INYECTABLE, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: ...
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 100ML-BAXTER 1 BOLSA - LAB. :VARIOS 10 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % BOLSA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: ...
MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-MIDAZOLAM 50MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-SIEGFRIED 50 MG / 10 ML SOLUCION - LAB. :VARIOS 4 AMPOLLA (S) Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 50 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: ....
MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-FENTANILO 0.5MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-BIOSANO 0.5 MG / 10 ML AMPOLLA - LAB. :VARIOS 4 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.5 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: ...
MEDICAMENTO FORMULADO: NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE X 4ML-RYAN 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 4 AMPOLLA (S) Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 4 MG/4ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: ...
MEDICAMENTO FORMULADO: DEXTROSA AL 5 % EN A.D SOLUCION INYECTABLE X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 5 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: ...

04:53 melagugo - MELISSA AGUDELO GOMEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO RE FORMULADO: CONTROL-KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 500 MG / 10 ML VIAL - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 12 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

05:11 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 1000ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 12 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION,

DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: AGUA ESTERIL PARA INYECCION X 10ML-VITALIS 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 10ml SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

06:29 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Interconsulta por: NEUROCIRUGIA
**Obs: POLITRAUMA EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON SOSPECHA DE FRACTURA L4-L5
Solicitud Interconsulta por: TRAUMATOLOGIA-ORTOPEDIA
**Obs: POLITRAUMA EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON SOSPECHA DE FRACTURA DE PELVIS

06:41 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA
**Obs: SE SOLICITAN DE MANERA URGENTE

06:42 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] SEMIAUTOMATIZADO
**Obs: SE SOLICITAN DE MANERA URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO
**Obs: SE SOLICITAN DE MANERA URGENTE

06:44 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: TROPONINA I CUANTITATIVA
**Obs: CONTROL URGENTE

06:50 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
**Obs: CONTROL URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
**Obs: CONTROL URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: VCONTROL URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: NITROGENO UREICO
**Obs: CONTROL URGENTE
MEDICAMENTO FORMULADO: REG-DEXMEDETOMIDINA 4MCG/ML SOLUCION INYECTABLE X 100ML-BAXTER 1 BOLSA - LAB. :VARIOS 4 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 400 MCG / 4 ML BOLSA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: REG-DEXMEDETOMIDINA 4MCG/ML SOLUCION INYECTABLE X 100ML-BAXTER 1 BOLSA - LAB. :VARIOS 4 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 400 MCG / 4 ML BOLSA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO RE FORMULADO: CONTROL-KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 500 MG / 10 ML VIAL - LAB. :VARIOS 8 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO RE FORMULADO: CONTROL-KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 500 MG / 10 ML VIAL - LAB. :VARIOS 8 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO RE FORMULADO: CONTROL-KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 500 MG / 10 ML VIAL - LAB. :VARIOS 8 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO RE FORMULADO: CONTROL-KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 500 MG / 10 ML VIAL - LAB. :VARIOS 8 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO RE FORMULADO: CONTROL-KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 500 MG / 10 ML VIAL - LAB. :VARIOS 8 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 2 MEQ/M SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 6 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 2 MEQ / ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 2 MEQ/M SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 6 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 2 MEQ / ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION EN TRONCO Y CARA
Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION EN TRONCO Y CARA

Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION EN TRONCO Y CARA
Solicitud Proc Qx: DERMOABRASION (QUIMICA O MECANICA) EN AREA ESPECIAL EN CARA O CUELLO
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION EN CARA
Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION EN TRONCO Y CARA
Solicitud Proc Qx: DERMOABRASION (QUIMICA O MECANICA) EN AREA ESPECIAL EN CARA O CUELLO
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION EN CARA
Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL MENOR DEL 10% DE SUPERFICIE CORPORAL EN AREA GENERAL
**Obs: HERIDA COMPLEJA EN CARA
Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION EN TRONCO Y CARA
Solicitud Proc Qx: DERMOABRASION (QUIMICA O MECANICA) EN AREA ESPECIAL EN CARA O CUELLO
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION EN CARA
Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL MENOR DEL 10% DE SUPERFICIE CORPORAL EN AREA GENERAL
**Obs: HERIDA COMPLEJA EN CARA
Solicitud Proc Qx: COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL HASTA DE DOS CENTIMETROS CUADRADOS
**Obs: HERIDA COMPLEJA EN CARA

09:07 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
**Obs: POLITRAUME EN CACIDENTE DE TRANSITO

ESTADO DE CHOQUE, TRAUMA CERRADO DE TORAX, TROPOPNINAS POSITIVAS

SOSPECHA DE CONTUSION MIOCARDICA
Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: SE SOLICITA CONTROL AHORA

09:55 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,1 A 1 MCG / K / H
KETAMINA 2 000 MG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 8 MCG / K / MIN INFUSION ENTRE 5 A 30 MCG / K / MIN
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 500 MG, C/6H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

REALIZAR ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.
SUSPENDER MIDAZOLAM FENTANILO

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION PROFUNDA RASS DE -4
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 80 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5

--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PROTECTOR
--NORMOXEMIA , HIPERCAPNIA PERMISIVA
--VT 4 A 6 ML / K DP MENOR DE 15 CMH20 PRESION MESETA MENOR DE 28 CMH20
--PEEP OPTIMO CON METAS HEMODINAMICAS INCREMENTAR EL PEEP PROGRESIVAMENTE HASTA 8 CMH2O
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
--CADA 12 HORA GASES ARTERIOVENOSOS CALCULAR SHUNT INTRAPULMONAR META DELTA DE CO2 MENOR DE 10 MMHG ARTERIOVENOSO CUANDO SE TOME LOS GASES REGISTRAR CAPNOGRAFIA Y SO2 N ESE MOMENTO
GI METABOLICO
--INICIAR MA?ANA SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE 0, 8 Y 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2

10:52 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES) POR MICROTECNICA
**Obs: SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA Rh [ANTIGENO Rh D] POR MICROTECNICA
**Obs: SE SOLICITA:

SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO DIRECTA [HEMOCLASIFICACION GLOBULAR] POR MICROTECNICA
**Obs: SE SOLICITA:

SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR MICROTECNICA
**Obs: SE SOLICITA:

SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA POR MICROTECNICA
**Obs: SE SOLICITA:

SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS
**Obs: SE SOLICITA:

SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO
**Obs: SE SOLICITA:

-SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS O ERITROCITOS
**Obs: SE SOLICITA:

-SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE
Solucitud Apoyo Dx: TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO
**Obs: SE SOLICITA:

- RESERVA DE 3 UGR Y TRANSFUSION DE 1 UGR

- TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO

URGENTE

11:01 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO FORMULADO: VASOPRESINA 20 UI/M SOLUCION INYECTABLE X 1ML-ADS 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 2 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: VASOPRESINA 20 UI/M SOLUCION INYECTABLE X 1ML-ADS 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 2 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 4 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 4 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1

11:55 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,1 A 1 MCG / K / H
KETAMINA 2 000 MG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 8 MCG / K / MIN INFUSION ENTRE 5 A 30 MCG / K / MIN
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 500 MG, C/6H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.

GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

TOMAR A LAS 13 00 HORAS HEMOGRAMA , PT PTT INR . GASES ARTERIOVENOSOS LACTATO SERICO TROPONINA DE CONTROL BUN CREATININA

REALIZAR ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.
SUSPENDER MIDAZOLAM FENTANILO

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION PROFUNDA RASS DE -4
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 80 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PROTECTOR
--NORMOXEMIA , HIPERCAPNIA PERMISIVA
--VT 4 A 6 ML / K DP MENOR DE 15 CMH20 PRESION MESETA MENOR DE 28 CMH20
--PEEP OPTIMO CON METAS HEMODINAMICAS INCREMENTAR EL PEEP PROGRESIVAMENTE HASTA 8 CMH2O
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
--CADA 12 HORA GASES ARTERIOVENOSOS CALCULAR SHUNT INTRAPULMONAR META DELTA DE CO2 MENOR DE 10 MMHG ARTERIOVENOSO CUANDO SE TOME LOS GASES REGISTRAR CAPNOGRAFIA Y SO2 N ESE MOMENTO
GI METABOLICO
--INICIAR MA?ANA SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE 0, 8 Y 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2
Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solucitud Apoyo Dx: NITROGENO UREICO
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solucitud Apoyo Dx: CREATIN QUINASA TOTAL [CK-CPK]
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solucitud Apoyo Dx: CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solucitud Apoyo Dx: MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solucitud Apoyo Dx: GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA

Solicitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: TROPONINA I CUANTITATIVA
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: CLORO
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: CALCIO IONICO
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA
Solicitud Apoyo Dx: TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]
**Obs: NOTA DE UNIDAD 11 HORAS
PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE CHOQUE SIN RESPUESTA A NOREPINEFRINA CON REPOSCIIN HIDRICA SE INDICA INICIA DE VASOPRESINA

14:58 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE PELVIS
**Obs: TRAUMA EN PELVIS CON FRACTURAS SECUNDARIAS

16:10 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO FORMULADO: CARBOXIMETILCELULOSA 0.5 % SOLUCION OFTALMICA X 15ML-INCOBRA 1 SOLUCION OFTALMICA - LAB. :VARIOS 1 GOTA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: OFTALMICA, CONCENTRACIÓN 0.5 % SOLUCION OFTALMICA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CARBOXIMETILCELULOSA 0.5 % SOLUCION OFTALMICA X 15ML-INCOBRA 1 SOLUCION OFTALMICA - LAB. :VARIOS 1 GOTA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: OFTALMICA, CONCENTRACIÓN 0.5 % SOLUCION OFTALMICA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
Solicitud Apoyo Dx: RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE
**Obs: POLITRAUMA EN ACCIDENTE DE TRANSITO -- TRAUMA EN COLUMNA LUMBOSACRA CON TC QUE REPORTA FRACTURA CUERPO VERTEBRAL DE L4

SE SOLICITA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE

***ESTUDIO BAJO SEDACION ***
Solicitud Interconsulta por: ANESTESIOLOGIA
**Obs: POLITRAUMA EN ACCIDENTE DE TRANSITO -- TRAUMA EN COLUMNA LUMBOSACRA CON TC QUE REPORTA FRACTURA CUERPO VERTEBRAL DE L4

SE SOLICITA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE

***ESTUDIO BAJO SEDACION ***
MEDICAMENTO FORMULADO: LIDOCAINA 2 % JALEA X 30ML-ARBOFARMA 1 JALEA - LAB. :VARIOS 1 JALEA Cada 1 Dia(s), VIA: OROYEYUNAL, CONCENTRACIÓN 2 % UNGUENTO, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
Solicitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL)
**Obs: *CONTROL POST PASO DE SONDA NASOYEYUNAL

Solucitud Apoyo Dx: FLUOROSCOPIA COMO GUIA PARA PROCEDIMIENTOS
**Obs: **CONTROL POST PASO DE SONDA NASOYEYUNAL

20:02 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,1 A 1 MCG / K / H
KETAMINA 2 000 MG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 8 MCG / K / MIN INFUSION ENTRE 5 A 30 MCG / K / MIN
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 500 MG, C/6H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE SOLICITA
GASES VENOSOS, HEMOGRAMA , LACTATO, ELECTROLITOS COMPLETOS, CPK

EN PROCESO
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION PROFUNDA RASS DE -4
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 80 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PROTECTOR
--NORMOXEMIA , HIPERCAPNIA PERMISIVA
--VT 4 A 6 ML / K DP MENOR DE 15 CMH20 PRESION MESETA MENOR DE 28 CMH20
--PEEP OPTIMO CON METAS HEMODINAMICAS INCREMENTAR EL PEEP PROGRESIVAMENTE HASTA 8 CMH2O
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
--CADA 12 HORA GASES ARTERIOVENOSOS CALCULAR SHUNT INTRAPULMONAR META DELTA DE CO2 MENOR DE 10 MMHG ARTERIOVENOSO CUANDO SE TOME LOS GASES REGISTRAR CAPNOGRAFIA Y SO2 N ESE MOMENTO
GI METABOLICO
--INICIAR MA?ANA SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE 0, 8 Y 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2

GRACIAS!

20:06 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA
**Obs: PCONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: CLORO
**Obs: CONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: CALCIO IONICO
**Obs: CONTROL UCI - PED.
Solucitud Apoyo Dx: CREATIN QUINASA TOTAL [CK-CPK]
**Obs: CONTROL UCI - PED.

21:51 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,1 A 1 MCG / K / H
KETAMINA 2 000 MG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 8 MCG / K / MIN INFUSION ENTRE 5 A 30 MCG / K / MIN
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV. ***NUEVO***
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HROAS ** NUEVO **
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE SOLICITA
GASES VENOSOS, HEMOGRAMA , PT, PTT , LACTATO, ELECTROLITOS COMPLETOS, CPK, FIBRINOGENO
SE SOLICITA VALORACION POR NUTRICION

EN PROCESO
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION PROFUNDA RASS DE -4
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE REANIMACION

--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 80 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PROTECTOR
--NORMOXEMIA , HIPERCAPNIA PERMISIVA
--VT 4 A 6 ML / K DP MENOR DE 15 CMH20 PRESION MESETA MENOR DE 28 CMH20
--PEEP OPTIMO CON METAS HEMODINAMICAS INCREMENTAR EL PEEP PROGRESIVAMENTE HASTA 8 CMH2O
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
--CADA 12 HORA GASES ARTERIOVENOSOS CALCULAR SHUNT INTRAPULMONAR META DELTA DE CO2 MENOR DE 10 MMHG ARTERIOVENOSO CUANDO SE TOME LOS GASES REGISTRAR CAPNOGRAFIA Y SO2 N ESE MOMENTO
GI METABOLICO
--INICIAR MA?ANA SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE 0, 8 Y 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2

GRACIAS!
MEDICAMENTO FORMULADO: FITOMENADIONA 10MG/M SOLUCION INYECTABLE X 1ML (VITAMINA K1)-BIOSANO 1 AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAMUSCULAR, CONCENTRACIÓN AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: FIBRINOGENO
**Obs: CONTROL
Solicitud Interconsulta por: NUTRICION Y DIETETICA
**Obs: PACIENTE CON REQUEIRMIENTO DE INCIO DE VIA ENTERAL TEMPRANA

2026-03-06

08:13 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
**Obs: control, paciente con estado de choque mixto severo
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
**Obs: control, paciente con estado de choque mixto severo

08:14 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,1 A 1 MCG / K / H
KETAMINA 2 000 MG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 8 MCG / K / MIN INFUSION ENTRE 5 A 30 MCG / K / MIN
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV.
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HROAS
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL

MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SS PT PTT INR
PASAR AL LLAMADO A CIRUGIA PLASTICA
CONFIRMAR RESERVA DE GRE
TRANSFUNDIR 1 UNIDAD DE GRE AHORA

EN PROCESO
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION PROFUNDA RASS DE -4
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 80 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PROTECTOR
--NORMOXEMIA , HIPERCAPNIA PERMISIVA
--VT 4 A 6 ML / K DP MENOR DE 15 CMH20 PRESION MESETA MENOR DE 28 CMH20
--PEEP OPTIMO CON METAS HEMODINAMICAS INCREMENTAR EL PEEP PROGRESIVAMENTE HASTA 8 CMH2O
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
--CADA 12 HORA GASES ARTERIOVENOSOS CALCULAR SHUNT INTRAPULMONAR META DELTA DE CO2 MENOR DE 10 MMHG ARTERIOVENOSO CUANDO SE TOME LOS GASES REGISTRAR CAPNOGRAFIA Y SO2 N ESE MOMENTO
GI METABOLICO
--INICIAR MA?ANA SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE 0, 8 Y 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2

GRACIAS!

08:16 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES) POR MICROTECNICA
**Obs: TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA Rh [ANTIGENO Rh D] POR MICROTECNICA
**Obs: TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO DIRECTA [HEMOCLASIFICACION GLOBULAR] POR MICROTECNICA
**Obs: TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR MICROTECNICA
**Obs: TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA POR MICROTECNICA
**Obs: TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS
**Obs: TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS
Solucitud Apoyo Dx: TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS O ERITROCITOS
**Obs: TRANSFUSION DE 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS

08:40 evidurqu - EVIS ZIOMARA DURANGO QUINTERO
ESPECIALIDAD: CIRUGIA VASCULAR

Solucitud Apoyo Dx: ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCION
**Obs: CIRUGIA VASCULAR - DRA. DURANGO

PACIENTE CON ANTECEDENTE DE TRAUMA SEVERO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO POST OPERATORIO DE REVASCULARIZACION VASCULAR, LAVADO Y DESBRIDAMIENTO DE LA EXTREMIDAD. SE ENCUENTRA ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, SIN SOPORTE VASO ACTIVO Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VENTILATORIO. SE EVALUA EXTREMIDAD DISTAL (MII) EL CUAL SE EVIDENCIA ADECUADA PERFUSION DISTAL, LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS. PULSOS DISTALES NO PALPABLES.

CONDUCTA: PACIENTE QUIEN REQUIERE REALIZACION DE ARTERIOGRAFIA MII PARA EVALUAR VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD LA CUAL SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TENGA ESTABLIDAD HEMODINAMICA Y VENTILATORIA.

09:56 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

PLAN TERAPEUTICO UCIP. - POSTQUIRURGICO.
PESO APROX: 40 KG. AHH 80 CC / H

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL
NADA POR VIA ORAL.
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,2 MCG / K / H
KETAMINA SUSPENDIDA
NORADRENALINA 16 MG EN 250 cc DAD 5 % 1 CC =0,02 MCG / K / MIN TITULABLE ENTRE 0.03 Y 0.2 MCG/KG/MIN
TITULAR PARA SUSPENDER
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV.
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HROAS
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
FUROSEMIDA 10 MG IV CADA 6 HORAS
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO PASO A CIRUGIA PLASTICA
CONFIRMAR RESERVA DE GRE
TRANSFUNDIR 1 UNIDAD DE GRE
SE SOLICITA RADIOGRAFIA DE TORAX PORTATIL
SE SOLICITA GASES PARA TEST DE VENTILACION ESPONTANEA

EN PROCESO
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--SEDACION CONCIENTE
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE DES REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 70 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO PLAN DE EXTUBACION
--TEST DE VENTILACION ESPONTANEA
--CAPNOGRAFIA META PARA HIPERCAPNIA PERMISIVA
-- GASES ARTERIOVENOSOS DURANTE TEST DE VENTILACION ESPONTANEA

GI METABOLICO
--INICIAR SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
--CONTROL DE CPK TOTAL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE MAYOR DE 1,5 CC / K / H

HEMATOLOGICO TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 2

GRACIAS!

10:17 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

MEDICAMENTO FORMULADO: FUROSEMIDA 20MG SOLUCION INYECTABLE X 2ML-BIO ESTERIL 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 20 MG AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 3

12:24 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Interconsulta por: NEUROCIRUGIA
**Obs: VALORACION POR CIRUGIA DE COLUMNA RETROSPECTIVA

14:51 anggomga - ANGELA MARIA GOMEZ GARCIA
ESPECIALIDAD: ORTOPEDIA PEDIATRICA

Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO CON COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA
**Obs:

15:59 eriherva - ERIKA JULIETH HERRERA VALLEJO
ESPECIALIDAD: NUTRICION Y DIETETICA

PLAN DE MANEJO NUTRICIONAL

1. SI LA SONDA SE ENCUENTRA BIEN UBICADA INICIAR SOPORTE ENTERAL CON
2. PEDIASURE CLINICAL BOTELLA X 220ML
3.TIEMPO DE TRATAMIENTO: 30 D?AS
4.VOLUMEN EN 24 HORAS 1320 ML
5.VELOCIDAD DE INFUSION A 55 ML POR HORAS
6. PASAR 6 UNIDADES POR BOMBA DE INFUSION INICIAR A 10ML SI EL PACIENTE TOLERA AUMENTAR CADA 6 HORAS 10ML HASTA COMPLETAR LA VELOCIDAD DE INFUSION
7. IRRIGACION DE LA SONDA SEGUN PROTOCOLO INSTITUCIONAL
8. REPORTAR A ESTE SERVICIO ALTERACIONE METABOLICAS O GASTROINTESTINALES DESPUES DEL INICIO DE LA NUTRICION
9. ESTE SERVICIO QUEDA ATENTO A EVOLUCION DE LA PACIENTE

MEDICAMENTO FORMULADO: PEDIASURE CLINICAL BOTELLA X 220 ML 1 UNIDAD - LAB. :VARIOS 6 BOTELLA(S) Cada 24 Hora(s), VIA: OROYEYUNAL, CONCENTRACIÓN BOTELLA PLASTICA, DIAS DE TRATAMIENTO: 30

16:02 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

ORDENES POSEXTUBACION
PESO APROX: 40 KG. AHH 70 CC / H AJUSTAR

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
SONDA NASOYEYUNAL INICIAR NUTRICION ENTERAL CONTINUA A 10 CC / H INCREMENTAR HASTA 30 CC / H
NADA POR VIA ORAL.
SOPORTE VENTILATORIO MECANICA NO INVASIVO CON CANULA RAM PROTOCOLO INSTITUSIONAL
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,2 MCG / K / H
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (1 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV.
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HROAS
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
FUROSEMIDA 10 MG IV CADA 6 HORAS
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO PASO A CIRUGIA PLASTICA

EN PROCESO LECTURA OFICIAL DE RADIOGRAFIA DE TORAX PORTATIL

REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS

EN PROCESO
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE DES REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 65 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO

GI METABOLICO
--INICIAR SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE MAYOR DE 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO METAS (TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI ESTA FUERA DE METAS)
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR DE 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 1,3

GRACIAS!

20:08 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] SEMIAUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: CLORO
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: CALCIO IONICO
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS
Solucitud Apoyo Dx: CREATIN QUINASA TOTAL [CK-CPK]
**Obs: CONTROL 07/03/2026 05:00 HORAS

20:40 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

ORDENES CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
PESO APROX: 40 KG. AHH 70 CC / H AJUSTAR

MONITORIA
--OXIGENACION CEREBRAL POR NIRS
--OXIGENACION REGIONAL TISULAR DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO
--MONITORIA DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO POR BIORREACTANCIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS
NUTRICION ENTERAL CONTINUA A 10 CC / H META 30 CC/H
NADA POR VIA ORAL.

SOPORTE VENTILATORIO MECANICA NO INVASIVO CON CANULA RAM PROTOCOLO INSTITUCIONAL
LACTATO DE RINGER COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,2 MCG / K / H
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
DESMONTE PROGRESIVO
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS *SUSPENDER*
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (2 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV. *SUSPENDER
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HORAS
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
FUROSEMIDA 10 MG IV CADA 6 HORAS
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE SOLICITA
HEMOGRAMA, TIEMPOS DE COAGULACION, CPK, ELECTROLITOS COMPLETOS Y ACIDO LACTICO 07.03.26

EN PROCESO
CIRUGIA PLASTICA
EN PROCESO LECTURA OFICIAL DE RADIOGRAFIA DE TORAX PORTATIL
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE DES REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 65 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO

GI METABOLICO
--INICIAR SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE MAYOR DE 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO METAS (TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI ESTA FUERA DE METAS)
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR DE 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 1,3

GRACIAS!

22:31 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO RE FORMULADO: LEVOMEPROMAZINA 25MG TABLETA-HUMAX 1 TABLETA (S) - LAB. :VARIOS 1 TABLETA (S) Cada 8 Hora(s), VIA: SONDA NASOGASTRICA, CONCENTRACIÓN 25mg TABLETA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO RE FORMULADO: LEVOMEPROMAZINA 25MG TABLETA-HUMAX 1 TABLETA (S) - LAB. :VARIOS 1 TABLETA (S) Cada 8 Hora(s), VIA: SONDA NASOGASTRICA, CONCENTRACIÓN 25mg TABLETA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
**Obs: TRAUMA SEVERO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, SE SOLICITA:

TC DE RODILLA IZQUIERDA
Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL)
**Obs: TRAUMA SEVERO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, SE SOLICITA:

RADIOGRAFIA DE RODILLA IZQUIERDA

2026-03-07

06:57 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA , EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR A ENTRE 20 Y 30 GRADOS

NUTRICION ENTERAL CONTINUA A 10 CC / H META 30 CC/H
NADA POR VIA ORAL.
SOPORTE VENTILATORIO MECANICA NO INVASIVO CON CANULA RAM PROTOCOLO INSTITUCIONAL
LACTATO DE RINGER + 5 CC KATROL COMPLETAR APORTE HIDRICO IV
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG / K / H INFUSION ENTRE 0,2 MCG / K / H
VASOPRESINA 40 UNIDADES EN 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 U / K / H INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 U/ K / H
DESMONTE PROGRESIVO
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO
CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA OJO CADA 6 HORAS *SUSPENDER*
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. CON HORARIO (2 / 5 DIAS)
GLUCONATO DE CALCIO 1 GR , C/8 H, IV. *SUSPENDER *
VITAMINA K 10 MG EV CADA 24 HORAS
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI 4 / 03 / 2025
FUROSEMIDA 10 MG IV CADA 6 HORAS
LEVOMEPROMAZINA 7 MG POR SONDA CADA 8 HORAS *NUEVO* (0.5MG/KG/DIA)
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNAL
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE SOLICITA
HEMOGRAMA, TIEMPOS DE COAGULACION, CPK, ELECTROLITOS COMPLETOS Y ACIDO LACTICO 07.03.26
RX DE RODILLA Y TAC DE RODILLA IZQUIERDA

EN PROCESO
CIRUGIA PLASTICA
EN PROCESO LECTURA OFICIAL DE RADIOGRAFIA DE TORAX PORTATIL
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO EL 07/03/2026.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS ENTRE 60 - 80
--ANALGESIA CON HORARIO
--FRACTURA VERTEBRAL MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR FASE DE DES REANIMACION
--PRESION ARTERIAL MEDIA DE 65 MMHG
--PRESION VENOSA CENTRAL ENTRE 10 Y 12 CMH20
--INDICE CARDIACO POR MONITORIA NO INVASIVA ENTRE 2,5 Y 3,5
--LACTATO SERICO MENOR DE 2 SATURACION VENOSA DE OXIGENO MAYOR DE 70 % BASE EXCESO MAYOR DE -5
--EVALUAR CADA TURNO POCUS - E
--REALIZAR ELECTROCARDIOGRAMA CADA 24 HORAS EVALUAR CONTUSION MIOCARDICA EN EVOLUCION CONTROL DE TROPONINA EN 12 / 24 / 48 / 72 HORAS
++RESPIRATORIO
-SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO

GI METABOLICO
--INICIAR SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL
--NA ENTRE 135 Y 145 MMOL / L K ENTRE 3,4 Y 4,5 MMOL / L CALCIO IONICO MAYOR DE 1,2 MMOL / L MG MAYOR E 2,4 MMOL / L FOSFORO MAYOR DE 3 MMOL / L MENOR DE 5
--GLUCOMETRIA ENTRE 90 Y 140 MG / DL
RENAL FASE DE REANIMACION
--DIURESIS ENTRE MAYOR DE 1,5 CC / K / H
HEMATOLOGICO METAS (TRANSDUNDIR HEMODERIVADOS SI ESTA FUERA DE METAS)
--HB MAYOR DE 9 G / DL PLAQUETAS MAYOR DE 90 000 FIBRINOGENO MAYOR DE 170 MG / DL
--INR MENOR DE 1,3

GRACIAS!

07:13 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)
**Obs: SE SOLICITA CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA
**Obs: SE SOLICITA CONTROL

08:07 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO-UCIP.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
NUTRICION ENTERAL A 10 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. (META: 30 CC/H). MANTENER SUSPENDIDA HASTA NUEVA ORDEN.
LACTATO DE RINGER + 5 CC KATROL COMPLETAR APORTE HIDRICO IV

DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 C = 0,1 MCG/KG/H. A 0,2 MCG/KG/H, IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. 1 CC = 0,1 UD/KG/H. INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-3/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/6H, IV.
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
SOPORTE VENTILATORIO MECANICO NO INVASIVO CON CANULA RAM.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
EN PROCESO: CIRUGIA PLASTICA. REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS. ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO (07/03/2026).

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

09:21 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE PELVIS
**Obs: SE SOLICITA TAC DE PELVIS POR TRAUMA POR APLASTAMIENTO Y FRACTURA DE RAMA ISQUIOPUBICAS EVIDENCIADAS EN TAC DE ABDOMEN

12:38 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO-UCIP.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
NUTRICION ENTERAL A 10 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. (META: 30 CC/H). MANTENER SUSPENDIDA HASTA NUEVA ORDEN.
LACTATO DE RINGER PARA COMPLETAR APORTE HIDRICO IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9 % 1 CC = 0,1 MCG/KG/H. A 0,3 MCG/KG/H, IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. 1 CC = 0,1 UD/KG/H. INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-3/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/6H, IV.
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
SOPORTE VENTILATORIO MECANICO NO INVASIVO CON CANULA RAM.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION

EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
EN PROCESO: CIRUGIA PLASTICA. REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS. ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO (07/03/2026).

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

14:39 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

NUEVA ORDEN MEDICA
FENTANIL A 0.5 MCG/KG/H. IV.

17:46 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO-UCIP.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
REINICIAR NUTRICION ENTERAL A 10 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. REALIZAR INCREMENTOS SEGUN LO ESTIPULADO POR NUTRICIONSTA (META: 55 CC/H).
LACTATO DE RINGER 1000 CC + CLORURO DE POTASIO 7.5 CC, PARA COMPLETAR APORTE HIDRICO IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9% 1 CC = 0,1 MCG/KG/H. A 0,3 MCG/KG/H, IV.
FENTANILO 1000 MCG/100 C SSN0.9%, PASAR A 0.5 MCG/KG/H, IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. 1 CC = 0,1 UD/KG/H. INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-3/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/6H, IV.
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
SOPORTE VENTILATORIO MECANICO NO INVASIVO CON CANULA RAM.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
EN PROCESO: CIRUGIA PLASTICA. REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS. ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO (07/03/2026).

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG

--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

20:45 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

ORDENES UCIPED
PESO: 40 KG

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
OXIGENO POR CANULA NASAL
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
REINICIAR NUTRICION ENTERAL A 10 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. REALIZAR INCREMENTOS SEGUN LO ESTIPULADO POR NUTRICIONSTA (META: 55 CC/H).
LACTATO DE RINGER 1000 CC + CLORURO DE POTASIO 7.5 CC, PARA COMPLETAR APORTE HIDRICO IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG LLEVAR A 100 CC SSN 0,9% 1 CC = 0,1 MCG/KG/H. A 0,3 MCG/KG/H, IV.
FENTANILO 1000 MCG/100 C SSN0.9%, PASAR A 0.5 MCG/KG/H, IV. ** SUSPENDER*
KETAMINA 500 MG EN 100 CC (1CC/HORA =2 MCG/KG/MIN) PASAR A 1-4 MCG/KG/MIN *** NUEVO ***
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. 1 CC = 0,1 UD/KG/H. INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-3/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. *** CAMBIO **
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO:
CIRUGIA PLASTICA. REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POS SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO (07/03/2026).
PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 3 DIAS

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:

--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

22:41 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

Solucitud Apoyo Dx: MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] SEMIAUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] SEMIAUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: CLORO
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: CALCIO IONICO
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
**Obs: CONTROL
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
**Obs: CONTROL

2026-03-08

01:44 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: paraclinicos de control

06:11 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO POTASIO (K-TROL) 2 MEQ/M SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 4 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 2meq/ml SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

09:16 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
NUTRICION ENTERAL A 20 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. REALIZAR INCREMENTOS SEGUN LO ESTIPULADO POR NUTRICIONSTA (META: 55 CC/H).
LACTATO DE RINGER 1000 CC + CLORURO DE POTASIO 7.5 CC, PARA COMPLETAR APORTE HIDRICO IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,3 MCG/KG/H, IV.
KETAMINA 500 MG/100 CC SN0.9% (1 CC/H=2 MCG/KG/MIN) PASAR A 3-10 MCG/KG/MIN. IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-4/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV.
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD

MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
REALIZAR PROCALCITONINA Y HEMOCULTIVOS PERIFERICO Y CENTRAL.
EN PROCESO: REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS. ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 2 DIAS.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

09:18 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

Solucitud Apoyo Dx: PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO
**Obs: SEPSIS
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA
**Obs: HEMOCULTIVO PERIFERICO.
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA
**Obs: HEMOCULTIVO POR CATETER CENTRAL

09:52 isaandbo - ISABELLA ANDREA VALDIVIA BOTERO
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO CON COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA
**Obs: PACIENTE QUE SUFRIO POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, DONDE SUFRE TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9, DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL, AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA, POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACI?N DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026), POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACI?N Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPL?TEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCI?N. TROMBECTOM?A Y RECONSTRUCCI?N VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACI?N VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOF?SICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACI?N DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACI?N DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPL?TEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026). POR LO ANTEIROR SE SOLICITA AHORA NUEVA INTERVENCION DE LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO MAS CAMBIOS TERAPIA VAC.

09:56 juapraoj - JUAN SEBASTIAN PRADO OJEDA
ESPECIALIDAD: ORTOPEDIA PEDIATRICA

Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO CON COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA
**Obs: PACIENTE QUE SUFRIO POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, DONDE SUFRE TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9, DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL, AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA, POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACI?N DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026), POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACI?N Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPL?TEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCI?N. TROMBECTOM?A Y RECONSTRUCCI?N VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACI?N VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOF?SICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACI?N DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACI?N DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPL?TEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026). POR LO ANTEIROR SE SOLICITA AHORA NUEVA INTERVENCION DE LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO MAS CAMBIOS TERAPIA VAC.
Solicitud Proc Qx: LAVADO Y DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA DE FEMUR
**Obs: PACIENTE QUE SUFRIO POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, DONDE SUFRE TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9, DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL, AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA, POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACI?N DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026), POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E

INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACI?N Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPL?TEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCI?N. TROMBECTOM?A Y RECONSTRUCCI?N VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACI?N VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOF?SICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACI?N DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACI?N DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPL?TEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026). POR LO ANTEIROR SE SOLICITA AHORA NUEVA INTERVENCION DE LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO MAS CAMBIOS TERAPIA VAC.

09:58 juapraoj - JUAN SEBASTIAN PRADO OJEDA
ESPECIALIDAD: ORTOPEDIA PEDIATRICA

Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO CON COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA
**Obs: PACIENTE QUE SUFRIO POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, DONDE SUFRE TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9, DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL, AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA, POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACI?N DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026), POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACI?N Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPL?TEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCI?N. TROMBECTOM?A Y RECONSTRUCCI?N VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACI?N VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOF?SICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACI?N DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACI?N DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPL?TEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026). POR LO ANTEIROR SE SOLICITA AHORA NUEVA INTERVENCION DE LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO MAS CAMBIOS TERAPIA VAC.

11:17 juapraoj - JUAN SEBASTIAN PRADO OJEDA
ESPECIALIDAD: ORTOPEDIA PEDIATRICA

Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO CON COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PRESION SUBATMOSFERICA
Obs: PACIENTE QUE SUFRIO POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, DONDE SUFRE TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9, DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL, AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA, POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACI?N DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026), POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACI?N Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPL?TEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCI?N. TROMBECTOM?A Y RECONSTRUCCI?N VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACI?N VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOF?SICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACI?N DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACI?N DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPL?TEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026). POR LO ANTEIROR SE SOLICITA AHORA NUEVA INTERVENCION DE LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO MAS CAMBIOS TERAPIA VAC **COMO URGENCIA VITAL
Solicitud Proc Qx: LAVADO Y DESBRIDAMIENTO DE FRACTURA ABIERTA DE FEMUR
Obs: PACIENTE QUE SUFRIO POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, DONDE SUFRE TRAUMA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MESS INICIAL DE 9, DEFECTO DE COBERTURA ASOCIADO Y DEGLOVING EN MUSLO CARA ANTEROMEDIAL Y PIERNA TERCIO PROXIMAL, AVULSION DE CONDILO FEMORAL MEDIAL Y PERDIDA DE LIGAMENTO COLATERAL LATERAL Y CAPSULA ARTICULAR EN RODILLA, POSTQUIRURGICO DE ORTOPEDIA LAVADO Y DESBRIDAMIENTO COLOCACI?N DE SISTEMA VAC. (DRA. GOMEZ - 04/03/2026), POSQUIRURGICO DE CIRUGIA VASCULAR LIGADURA DE VASOS ARTERIALES MUSCULARES Y VENOSOS A NIVEL DE TERCIO MEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE MUSLO.A EXPLORACI?N Y CONTROL VASCULAR DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL, POPL?TEA PRIMERO Y SEGUNDA PORCI?N. TROMBECTOM?A Y RECONSTRUCCI?N VASCULAR DE VASOS MUSCULARES A NIVEL DE TERCIO DISTAL DE MUSLO, EXPLORACI?N VASCULAR ECOGUIADA DE ARTERIA TIBIAL ANTERIOR, POSTERIOR Y PEDIA DONDE SE EVIDENCIA PERMEABILIDAD Y FLUJO MONOF?SICO DISTAL. HEMOSTASIA, DRENAJE DE HEMATOMAS Y LIBERACI?N DE COMPARTIMIENTOS A NIVEL DEL PLANO VASCULAR VERIFICANDO REVASCULARIZACI?N DE ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DISTAL Y ARTERIA POPL?TEA (DRA. DURANGO - 04/03/2026). POR LO ANTEIROR SE SOLICITA AHORA NUEVA INTERVENCION DE LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO MAS CAMBIOS TERAPIA VAC **COMO URGENCIA VITAL

15:35 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
NUTRICION ENTERAL A 20 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. SUSPENDIDA HASTA NUEVA ORDEN.
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,3 MCG/KG/H, IV.
KETAMINA 500 MG/100 CC SN0.9% (1 CC/H=2 MCG/KG/MIN) PASAR A 3-10 MCG/KG/MIN. IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-4/5)
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV.
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION

EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
REALIZAR PROCALCITONINA Y HEMOCULTIVOS PERIFERICO Y CENTRAL.
EN PROCESO: REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS. ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 2 DIAS.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

20:48 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
NUTRICION ENTERAL A 20 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. SUSPENDER A LAS 00+00 HORAS
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV. DISMINUIR SEGUN TOLERANICA A ENTERAL
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,3 MCG/KG/H, IV.
KETAMINA 500 MG/100 CC SN0.9% (1 CC/H=2 MCG/KG/MIN) PASAR A 3-10 MCG/KG/MIN. IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-4/5)
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA *** CAMBIO**
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV. *** SUSPENDER**
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO:
EN PROCESO CIRUGIA COMO URGENCIA VITAL
HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 2 DIAS.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:

--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

22:02 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
**Obs: CONTROL UCI
Solucitud Apoyo Dx: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
**Obs: CONTROL UCI
Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: CONTROL UCI

22:04 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA
**Obs: control uci

22:08 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
NUTRICION ENTERAL A 20 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. SUSPENDER A LAS 00+00 HORAS
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV. DISMINUIR SEGUN TOLERANICA A ENTERAL ** CAMBIO**
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,3 MCG/KG/H, IV.
KETAMINA 500 MG/100 CC SN0.9% (1 CC/H=2 MCG/KG/MIN) PASAR A 3-10 MCG/KG/MIN. IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-4/5)
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA *** CAMBIO**
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV. *** SUSPENDER**
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO:
EN PROCESO CIRUGIA COMO URGENCIA VITAL
HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 2 DIAS.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE

++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

2026-03-09

01:29 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL)
**Obs: RODILLA IZQUIERDA, TRAUMA POR APLASTAMIENTO SEVERO, DEGLOVING
Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES
**Obs: TAC DE RODILLA IZQUIERDA, TRAUMA POR APLASTAMIENTO SEVERO, DEGLOVING

05:46 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
NUTRICION ENTERAL A 20 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL. SUSPENDER A LAS 00+00 HORAS
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV. DISMINUIR SEGUN TOLERANICA A ENTERAL ** CAMBIO**
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,3 MCG/KG/H, IV.
KETAMINA 500 MG/100 CC SN0.9% (1 CC/H=2 MCG/KG/MIN) PASAR A 3-10 MCG/KG/MIN. IV.
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-4/5)
MORFINA 2 MG EV CADA 4 HORAS SI EVA >4, MAXIMO 4 DOSIS.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA *** CAMBIO**
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV. *** SUSPENDER**
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO:
EN PROCESO CIRUGIA COMO URGENCIA VITAL
HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA EN 2 DIAS.

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS: 60-80%
--RASS DE -2, -3
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--IC: 2,5 - 3,5
--LACTATO <2
--SvO2 >70%

--EB >-5
--POCUS-E POR TURNO.
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

09:12 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL. DESTETE
NADA VIA ENTERAL REINICIAR NUTRICION ENTERAL A 20 CC/H. POR SONDA NASOYEYUNAL POSTERIO A CIRUGIA
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,2 MCG/KG/H, IV.
KETAMINA DESTETE Y SUSPENDER
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-5/5) CON HORARIO
MORFINA 2 MG EV CADA 4 HORAS SI EVA >4, MAXIMO 4 DOSIS.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

VALORACION CON INFECTOLOGIA PEDIATRICA DR BRAVO
VALORACION DE ESPECIALISTA DEL DOLOR RUBIO

EN PROCESO:
SE TRASLADA A CIRUGIA COMO URGENCIA VITAL
HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
PROCEDIMIENTO POR CIRUGIA PLASTICA NUEVO LAVADO
RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS RETIRAR
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.

--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

Solicitud Interconsulta por: MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS Y/O PEDIATRIA
**Obs: DOLO AGUDO POP Y NEUROPATICO

10:13 sebbursa - SEBASTIAN ARMANDO BURITICA SANDOVAL
ESPECIALIDAD: TRAUMATOLOGIA-ORTOPEDIA

Solucitud Apoyo Dx: CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA ORINA Y HECES
**Obs: SS CULTIVO DE SECRECION MUSLO IZQUIERDO

19:39 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL. DESTETE *SUSPENDER*
DIETA BLANDA PARA LA EDAD
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,2 MCG/KG/H, IV.)
VASOPRESINA 40 UD/100 CC SSN0,9%. (1 CC= 0,1 UD/KG/H). INFUSION ENTRE 0,01 A 0,6 UD/KG/H, IV. *SUSPENDER*
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
DIPIRONA 600 MG, C/6H, IV. (D-5/5) CON HORARIO *SUSPENDER*
MORFINA 2 MG EV CADA 4 HORAS SI EVA >4, MAXIMO 4 DOSIS.
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO
VALORACION CON INFECTOLOGIA PEDIATRICA DR BRAVO
VALORACION DE ESPECIALISTA DEL DOLOR RUBIO
HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA 10/03/26

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS RETIRAR
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

Solicitud Interconsulta por: MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS Y/O PEDIATRIA
**Obs: DOLO AGUDO POP Y NEUROPATICO

19:54 andmalca - ANDREA LIZETH MALLAMA CARDENAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTO FORMULADO: REG-GABAPENTIN 400MG CAPSULA CX100-LEGRAND 1 CAPSULA - LAB. :LEGRAND 1 CAPSULA (S) Cada 12 Hora(s), VIA: ORAL, CONCENTRACIÓN 400MG CAPSULA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

21:47 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL. DESTETE *SUSPENDER*
DIETA BLANDA PARA LA EDAD
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV.
DEXMEDETOMIDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H). A 0,2 MCG/KG/H, IV.)
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
MORFINA 2 MG CADA 4 HORAS EV POR 3 DIAS Y SUSPENDER (DOSIS 0.05MG/KG)
DEXMEDETOMEDINA DEJAR A 0.4MCG/KG/HORA HASTA COMPLETAR 5 DIAS
PARACETAMOL 600MG DEJAR CADA 6 HORAS EV
GABAPENTINA 300MG (DOSIS 5MG/KG) DAR 200MG CADA 24 HORAS (EN LAS NOCHES) POR 3 DIAS Y LUEGO SUBIR A 200MG CADA 12 HORAS POR 2 MESES
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026.
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV.
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
INMOVILIZACION TERAP?UTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO
VALORACION CON INFECTOLOGIA PEDIATRICA DR BRAVO
HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA 10/03/26

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS RETIRAR
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

Solicitud Interconsulta por: MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS Y/O PEDIATRIA
**Obs: DOLO AGUDO POP Y NEUROPATICO

2026-03-10

08:43 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Interconsulta por: INFECTOLOGIA (INT. ENFERMEDADES CONTAGIOSAS)
**Obs: PACIENTE CON LESION COMPLEJA EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO CON COMPROMISO VASCULAR Y OSEO , SE SOLICITA INTERCONSULTA PARA DETERMINAR AJUSTES A TERAPIA ANTIBIOTICA DADOS LAS CARACTERITICAS DE LESIONES.

12:41 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
DIETA BLANDA PARA LA EDAD
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
MORFINA 2 MG CADA 4 HORAS EV POR 3 DIAS Y SUSPENDER (DOSIS 0.05MG/KG)
DEXMEDETOMEDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H) DEJAR A 0.4MCG/KG/HORA HASTA COMPLETAR 5 DIAS
PARACETAMOL 600MG DEJAR CADA 6 HORAS EV
GABAPENTINA 300MG (DOSIS 5MG/KG) DAR 200MG CADA 24 HORAS (EN LAS NOCHES) POR 3 DIAS Y LUEGO SUBIR A 200MG CADA 12 HORAS POR 2 MESES
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
AMPICILINA SULBACTAM 2 G, C/6H, IV. (CON BASE EN AMPICILINA). FI:04/03/2026. *SUSPENDER*
PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4 G EV CADA 8 HORAS (300MG/KG/DIA) FI 10/03/2026 *NUEVO*
CLINDAMICINA 400 MG EV CADA 6 HORAS (40 MG/KG/DIA) FI 09/03/2026
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H, POR SONDA NASOYEYUNAL.
TERAPIA RESPIRATORIA A NECESIDAD.
VITAMINA K. ADMINISTRAR 10 MG, C/24H, IV. *SUSPENDER*
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
PROFILAXIS ANTITROMBOTICA MECANICA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE SOLICITA
RADIOGRAFIA DE TORAX

EN PROCESO
SEGUIMIENTO A HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
CULTIVO DE SECRECION TOMADOS 09/03/26
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.
VALORACION POR TEO
RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA 10/03/26

SEGUIMIENTO
ORTOPEDIA INFANTIL
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIATRICOS
NUTRICION
CIRUGIA PLASTICA
CIRUGIA VASCULAR

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS RETIRAR
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

13:35 josvalba - JOSE ALEJANDRO VALENCIA BARRAGAN
ESPECIALIDAD: ANESTESIOLOGIA

MEDICAMENTO RE FORMULADO: CONTROL-KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCION INYECTABLE X 10ML-RYAN 500 MG / 10 ML VIAL - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 500 MG / 10 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE X 5ML-VITECO 5 MG / 5 ML SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 AMPOLLA (S) Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 5 MG / 5 ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-FENTANILO 250MCG/5ML SOLUCION INYECTABLE (LANZAPIN)-BLASKOV 250MCG AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 250MCG/5ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: CONTROL-PROPOFOL 1 % (10MG/M) SOLUCION INYECTABLE X 20ML-B BRAUN 200MG/20ML AMPOLLA - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 1 Dia(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 200MG/20ML AMPOLLA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

14:28 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
**Obs: control uci - ped.
Solucitud Apoyo Dx: CREATIN QUINASA TOTAL [CK-CPK]
**Obs: uci - ped

21:28 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
OXIGENO POR CANULA NASAL CONVENCIONAL.
DIETA BLANDA PARA LA EDAD
LACTATO DE RINGER A 75 CC/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
MORFINA 2 MG CADA 4 HORAS EV POR 3 DIAS 1/3
DEXMEDETOMEDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H) DEJAR A 0.4MCG/KG/HORA D: 1/5
PARACETAMOL 600MG DEJAR CADA 6 HORAS EV
GABAPENTINA 300MG (DOSIS 5MG/KG) DAR 200MG CADA 24 HORAS (EN LAS NOCHES) POR 3 DIAS 1/3, Y LUEGO SUBIR A 200MG CADA 12 HORAS POR 2 MESES
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4 G EV CADA 8 HORAS (300MG/KG/DIA) FI 10/03/2026
CLINDAMICINA 400 MG EV CADA 6 HORAS (40 MG/KG/DIA) FI 09/03/2026
FUROSEMIDA 10 MG, C/8H, IV. , SI DIURESIS <1.5 CC/KG/HORA *** SUSPENDER***
ENOXAPARINA 30 MG SC CADA 24 HORAS. *** NUEVO ***
LEVOMEPROMAZINA 7 MG, C/8H,
TERAPIA RESPIRATORIA CON INCETIVO PULMONAR
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA
MOVILIZACION EN BLOQUE
PROFILAXIS ANTITROMBOTICA MECANICA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

SE SOLICITA
SE SOLICITA HEMOCULTIVOS #3 , UROCULTIVO, URONALISIS

EN PROCESO
SEGUIMIENTO A HEMOCULTIIVOS #1 Y #2 TOMADOS EL 08/03/2026
CULTIVO DE SECRECION TOMADOS 09/03/26
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.

SEGUIMIENTO
ORTOPEDIA INFANTIL
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIATRICOS
NUTRICION
CIRUGIA PLASTICA
CIRUGIA VASCULAR

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--NIRS RETIRAR
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--LACTATO <2
--SvO2 >70%

--EB >-5
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

GRACIAS!

21:44 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solucitud Apoyo Dx: UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA DE DISCO)
**Obs: UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA DE DISCO)
Solucitud Apoyo Dx: UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)
**Obs: UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)
Solucitud Apoyo Dx: UROANALISIS
**Obs: UROANALISIS
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA
**Obs: HEMOCULTIVOS DE CVC # 1
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA
**Obs: HEMOCULTIVOS DE CVC # 2
Solucitud Apoyo Dx: HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA
**Obs: HEMOCULTIVO PERIFERICO # 3

22:16 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

MEDICAMENTO FORMULADO: REG-ENOXAPARINA 40MG/0.4ML SOLUCION INYECTABLE CX1-PROCAPS 1 JERINGA PRELLENADA - LAB. :PROCAPS S.A 1 SOLUCION Cada 24 Hora(s), VIA: SUBCUTANEA, CONCENTRACIÓN 40MG/0.4ML JERINGA PRELLENADA, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

23:11 fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION Y HERIDAS COMPLEJAS EN REGION DORSAL DE TRONCO
Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION Y HERIDAS COMPLEJAS EN REGION DORSAL DE TRONCO
Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION Y HERIDAS COMPLEJAS EN REGION DORSAL DE TRONCO
Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL ENTRE EL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL EN AREA GENERAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION Y HERIDAS COMPLEJAS EN REGION DORSAL DE TRONCO
Solicitud Proc Qx: ESCARECTOMIA DEL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION Y HERIDAS COMPLEJAS EN REGION DORSAL DE TRONCO
Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL ENTRE EL 10% AL 19% DE SUPERFICIE CORPORAL EN AREA GENERAL
**Obs: QUEMADURAS POR FRICCION Y HERIDAS COMPLEJAS EN REGION DORSAL DE TRONCO

2026-03-11

07:07 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

*PLAN TERAPEUTICO:
PESO: 40 KG.

CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO.
CAMA PLANA, EN EL PLANO HORIZONTAL DEJAR ENTRE 20? Y 30?
SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO CON INTERFASE CANULA DE ALTO FLUJO
TERAPIA CON INCENTIVO RESPIRATORIO CADA 2 HORA
MADA VIA ORAL 8 HORAS ANTES DE EVENTO QUIRURGICO REINICIAR POSQUIRURTICO DIETA BLANDA PARA LA EDAD
LACTATO DE RINGER A 40 CC/H, IV.
PARACETAMOL 600 MG, C/6H, IV.
MORFINA 2 MG CADA 4 HORAS EV POR 3 DIAS 2/3
DEXMEDETOMEDINA 400 MCG/100 CC SSN 0,9% (1 CC=0,1 MCG/KG/H) DEJAR A 0.4MCG/KG/HORA D: 2/5
PARACETAMOL 600MG DEJAR CADA 6 HORAS EV
GABAPENTINA 300MG (DOSIS 5MG/KG) DAR 200MG CADA 24 HORAS (EN LAS NOCHES) POR 3 DIAS 1/3, Y LUEGO SUBIR A 200MG CADA 12 HORAS POR 2 MESES
OMEPRAZOL 40 MG, C/24H, IV.
PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4 G EV CADA 8 HORAS (300MG/KG/DIA) FI 10/03/2026
CLINDAMICINA 400 MG EV CADA 6 HORAS (40 MG/KG/DIA) FI 09/03/2026
ENOXAPARINA 30 MG SC CADA 24 HORAS. *** NUEVO *** DIFERIR 12 HORAS PARA EVENTO QUIRURGICO
LEVOMEPROMAZINA SUSPENDER
TERAPIA RESPIRATORIA CON INCETIVO PULMONAR
GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
HOJA NEUROLOGICA CADA HORA

MOVILIZACION EN BLOQUE
PROFILAXIS ANTITROMBOTICA MECANICA
MEDIDAS DE PREVENCION DE LESIONES OCULARES ZONAS DE PRESION
EDUCACION A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DEL DELIRIUM
BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

EN PROCESO
REMISION PARA MANEJO INTEGRAL POR SU EPS.
ARTERIOGRAFIA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO.

SEGUIMIENTO
ORTOPEDIA INFANTIL
INFECTOLOGIA PEDIATRICA
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIATRICOS
NUTRICION
CIRUGIA PLASTICA
CIRUGIA VASCULAR

METAS TERAPEUTICAS
++NEUROLOGICA
--MOVILIZAR EN BLOQUE
++CARDIOVASCULAR:
--TAM >65 MMHG
--PVC: 10 - 12
--LACTATO <2
--SvO2 >70%
--EB >-5
++METABOLICO
--NA: 135 - 145 MEQ/L.
--K: 3,4 - 4,5 MEQ/L.
--CA IONICO: >1.2 MMOL/L.
--MG >2,4 MMOL/L.
--P: 3 - 5 MMOL/L.
--GLUCOMETRIA: 90 - 140 MG/DL
**RENAL:
--DIURESIS >1,5 CC/KG/H
**HEMATOLOGICO:
--HGB >9 G/DL.
--PLAQUETAS >90.000
--FIBRINOGENO >170 MG/DL
--INR <1,3

GRACIAS!

NO HAY RESULTADOS DE EXAMEN FISICO

REVISION POR SISTEMA DEL PACIENTE

SISTEMA	OBSERVACION	FECHA REGISTRO
Neurologico	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
Nervioso Central y Periferico	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
Organos de los Sentidos	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
CardioVascular	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
Respiratorio	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
GastroIntestinal	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
GenitoUrinario	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
OsteoMuscular	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
Esfera Mental	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
Piel	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
Sistema Endocrino	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27
General	LO COMENTADO	04/03/2026 22:27

Andrea L. Mallama C.
1086104635
Medico General
UCC

PROFESIONAL : ANDREA LIZETH MALLAMA CARDENAS
CC - 1086104635 - T.P 1086104635
ESPECIALIDAD - MEDICINA GENERAL

Imprimiï¿½: ANDREA LIZETH MALLAMA CARDENAS - andmalca

Fecha Impresiï¿½n : 2026/3/11 - 09:47:33